



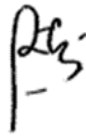
RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KOMITE MUTU
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
RS Prima Husada Malang
Tahun 2026

Pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien RS Prima Husada Malang digunakan sebagai bahan acuan di unit kerja untuk menjalankan program mutu di unit kerja RS Prima Husada Malang

Disusun oleh :
Penanggung Jawab Bab Peningkatan Mutu dan Keselamatan
Pasien



(dr. Ari Putriani, Sp. PK)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes AFP)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Resti Lestantini. M.Kes)

TIM PENYUSUN

PENGARAH

- 1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP., CHAE

PENYUSUN

- 1. dr. Resti Lestantini, M.Kes
- 2. dr. Ari Putriani, Sp. PK
- 3. Alifia Dian Sukmaningtyas, S.Kep., Ns
- 4. Sherly Rosita, S.Kep., Ns
- 5. Faisal Aminuddin Ilham, S.KM

KATA PENGANTAR

Semakin meningkatnya pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat maka persepsi masyarakat pun mulai berubah. Masyarakat mulai menuntut pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih ramah dan lebih berkualitas. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas mutu pelayanan, maka fungsi pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dalam rumah sakit secara bertahap perlu terus ditingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien serta memberi kepuasan terhadap pasien, keluarga maupun masyarakat.

Dalam rangka pemantapan peningkatan mutu dan pelayanan, maka disusunlah pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada Malang. Dalam pedoman ini diuraikan dengan detail prinsip upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, dimulai dari pembuatan rancangan mutu, penentuan indikator, bagaimana pelaksanaannya, *monitoring*, sampai dengan *evaluasi* dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemilik dan pengelola seluruh unit di Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Semoga pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini dapat menjadi pegangan untuk semua unit kerja terkait di Rumah Sakit Prima Husada dan bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Malang, 03 Januari 2026
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini. M.Kes

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii

TIM PENYUSUN.....iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI..... v

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA..... 3

BAB I 15

PENDAHULUAN..... 15

1.1 16

1.2 17

1.3 17

BAB II 17

DEFINISI OPERASIONAL 17

2.1 18

2.1.1 18

2.1.2 18

2.2 18

2.2.1 18

2.2.2 18

2.2.3 18

2.2.4 18

2.2.5 18

2.2.6 19

2.2.7 19

2.2.8 19

2.2.9 20

2.2.10 24

2.2.11 25

2.2.12 25

2.2.13 25

2.3 26

BAB III 26

KEBIJAKAN & REFERENSI MUTU 26

3.1 27

3.2 28

BAB IV PENGORGANISASIAN 27

4.1. 29

4.2. 30

A. 30

B. 30

C. 32

D.	33	
E.	34	
F.	36	
G.	38	
BAB V		40
KEGIATAN PENINGKATAN MUTU		40
5.1.	40	
5.2	40	
5.3	41	
5.4	42	
5.5	45	
5.6	46	
5.7	48	
5.6	Validasi data Indikator Mutu	48
BAB VI		51
SISTEM MANAJEMEN DATA		51
6.1	52	
6.2	52	
BAB VII		56
METODE PERBAIKAN MUTU		56
7.1	58	
7.2	59	
BAB VIII		58
KEGIATAN KESELAMATAN PASIEN		58
8.1	60	
8.2	61	
8.3	62	
8.4	64	
BAB IX		64
KEGIATAN MANAJEMEN RESIKO		64
9.2	68	
9.3	69	
9.4	77	
BAB X		74
EVALUASI, TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN		74
10.1	78	
10.2	78	
10.3	78	
10.3.1	78	
10.3.2	79	
BAB XI PENUTUP		78
REFERENSI		79

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR: 004.2/I-PDM/KMKP/I/2026
TENTANG
PEDOMAN PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN
PASIEN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan rumah sakit yang berdaya saing maka peningkatan mutu dan keselamatan pasien menjadi hal utama yang harus dilakukan rumah sakit secara berkesinambungan;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan juga harus berlandaskan pada etika dan moral serta bersikap lebih profesional dan mematuhi peraturan perundangan-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit tentang Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang – Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang – Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
4. Undang – Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Undang – Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha Sakitan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan

Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah;

- 18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis (Elektronik)
- 19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
- 20. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi RS
- 21. Keputusan Menteri Kesehatan No.HK.01.07/MENKES/174 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Prioritas
- 22. Kepdirjen Nomor Hk.02.02/D/43961/2024 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit
- 23. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 773.145/I-KEP/DIR/VI/2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada
- 24. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 262/DPM/I-KEP/DIR/VII/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kesatu : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN
- Kedua : Pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien Rumah Sakit Prima Husada tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- Ketiga : Komite mutu dan keselamatan pasien bertanggung jawab dalam mensosialisasikan ke unit-unit kerja terkait
- Keempat : Semua komponen yang terlibat dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien agar berpedoman pada buku pedoman yang ditetapkan dalam keputusan ini
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Peningkatan mutu adalah keseluruhan upaya dan kegiatan secara komprehensif dan integrative memantau dan menilai mutu pelayanan, memecahkan masalah-masalah yang ada dan mencari jalan keluarnya, sehingga mutu pelayanan akan menjadi lebih baik.
- 2. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.
- 3. Manajemen resiko adalah pendekatan proaktif berupa kegiatan untuk mengidentifikasi dan evaluasi untuk mengurangi resiko

cedera dan kerugian pada pasien, karyawan rumah sakit, pengunjung dan organisasinya sendiri.

BAB II ORGANISASI

Pasal 1

1. Direktur rumah sakit membentuk Komite MUTU atau bentuk organisasi lainnya untuk membantu kepala atau direktur rumah sakit mengelola dan memandu program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta mempertahankan standar pelayanan rumah sakit.
2. Direktur rumah sakit menetapkan keanggotaan Komite Mutu dan penanggung jawab data di tiap- tiap unit kerja.
3. Individu di dalam komite MUTU, anggota Komite Mutu dan penanggungjawab data di tiap-tiap unit kerja telah dilatih serta kompeten.

BAB III PELATIHAN MUTU

Pasal 2

1. Rumah sakit mempunyai program pelatihan MUTU yang diberikan oleh narasumber yang kompeten, diikuti oleh pimpinan di rumah sakit termasuk komite medis dan komite keperawatan telah mengikuti pelatihan MUTU.
2. Semua individu yang terlibat dalam pengumpulan, analisis, dan validasi data telah mengikuti pelatihan MUTU, khususnya tentang sistem manajemen data.
3. Pelatihan Manajemen data diikuti oleh penanggungjawab data unit kerja.
4. Staf di semua unit kerja termasuk staf klinis dilatih sesuai dengan pekerjaan mereka sehari-hari.

BAB IV PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR MUTU

Pasal 3

1. Direktur rumah sakit berkoordinasi dengan para kepala bidang/divisi dalam memilih dan menetapkan indikator mutu yang akan di ukur meliputi indikator mutu prioritas Rumah Sakit dan indikator mutu unit.
2. Komite MUTU memfasilitasi pemilihan mutu prioritas rumah sakit.
3. Sehubungan dengan sumber daya terbatas yang dimiliki rumah sakit, penentuan indikator mutu prioritas Rumah Sakit dipilih berdasarkan pelayanan klinis prioritas, sasaran keselamatan pasien, tujuan strategis, perbaikan sistem, dan manajemen resiko yang harus di nilai (ukur) dengan mengacu pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien dan jenis pelayanan.
4. Penilaian difokuskan pada masalah yang paling banyak di rumah sakit, jumlah yang banyak (*High Volume*), Proses beresiko tinggi (*High Process*), Ketidakpuasan pasien dan staf, Kemudahan dalam pengukuran, Ketentuan Pemerintah/ Persyaratan Ekstrenal, Sesuai dengan tujuan strategis rumah sakit, Memberikan pengalaman pasien lebih baik (*patient experience*). Berdasarkan atas prioritas rumah sakit tersebut ditetapkan pengukuran mutu menggunakan indikator mutu sasaran keselamatan pasien, indikator mutu area

klinis, indikator mutu sesuai tujuan strategi Rumah Sakit, Indikator mutu perbaikan sistem, dan indikator mutu manajemen resiko.

5. Pemilihan mutu prioritas unit dipilih oleh kepala unit, selanjutnya akan dikoordinasikan kepada Komite MUTU.
6. Pemilihan mutu prioritas sebagai mana dimaksud dalam ayat 5 dilakukan dan dievaluasi oleh komite MUTU dan pimpinan unit.
7. Setiap indikator mutu MUTU baik indikator mutu prioritas Rumah Sakit (IMP-RS) maupun indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit) agar dilengkapi dengan profil indikator sebagai berikut :
 - a. Judul indikator;
 - b. Dasar pemikiran;
 - c. Dimensi mutu;
 - d. Tujuan;
 - e. Definisi Operasional;
 - f. Jenis Indikator;
 - g. Satuan Pengukuran
 - h. Numerator (pembilang);
 - i. Denominator (penyebut);
 - j. Target Pencapaian;
 - k. Kriteria : inklusi / eksklusi;
 - l. Formula;
 - m. Metode Pengumpulan Data
 - n. Sumber data;
 - o. Instrumen Pengambilan Data
 - p. Besar Sampel
 - q. Cara Pengambilan Sampel
 - r. Periode Pengumpulan Data
 - s. Penyajian Data
 - t. Periode Analisis dan Pelaporan Data
 - u. Penanggung Jawab
8. Komite MUTU melakukan koordinasi dan integrasi kegiatan pengukuran mutu di unit pelayanan serta pelaporannya.
9. Komite MUTU melaksanakan supervisi terhadap progres pengumpulan data sesuai dengan yang direncanakan.

BAB V PENGUKURAN MUTU

Pasar 4

1. Rumah sakit mempunyai regulasi pengukuran mutu dan cara pemilihan indikator mutu di unit kerja yang antara lain meliputi:
 - a. Pengukuran mutu prioritas rumah sakit (IMP-RS) mencakup, indikator sasaran keselamatan pasien, indikator pelayanan klinis prioritas, indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit, indikator terkait perbaikan sistem, dan indikator terkait manajemen resiko yang fokus di ukur untuk hal-hal yang ingin diperbaiki oleh Rumah Sakit.
 - b. Pengukuran mutu unit prioritas yang khusus dipilih kepala unit berdasarkan permasalahan yang sering muncul di unitnya.
 - c. Sumber data pengukuran mutu di Rumah Sakit di ambil pada setiap unit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan bagian dari indikator mutu yang berlaku di unit.
2. Setiap unit kerja telah menetapkan indikator mutu prioritas (IMP-RS) yang berlaku di unitnya dan memilih indikator mutu prioritas unit (IMP-Unit) yang akan di ukur di unit.

3. Setiap unit kerja melaksanakan proses pengumpulan data dan pelaporan yang dilakukan oleh penanggung jawab data unit kepada kepala ruangan dan penanggung jawab MUTU di Rumah Sakit.
4. Kepala unit melakukan supervisi terhadap proses pengumpulan data yang dilakukan oleh penanggung jawab data unit .
5. Direktur rumah sakit dan Komite MUTU melakukan supervisi terhadap proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan oleh kepala unit dan penanggung jawab data.

BAB VI ANALISIS DATA

Pasal 5

1. Rumah Sakit mempunyai regulasi analisis data
2. Penanggung jawab data di unit melakukan pengukuran mutu, hasil pengukuran dikumpulkan dan di analisis untuk mendukung program peningkatan mutu serta mendukung partisipasi dalam pengumpulan *database* eksternal.
3. Hasil analisis data dapat menjadi informasi untuk pengambilan keputusan sehingga dapat membantu Rumah Sakit melihat pola dan tren capaian kinerjanya.
4. Analisis data dilakukan menggunakan metode dan teknik statistic sesuai dengan kebutuhan.
5. Analisis data telah dilakukan dengan melakukan perbandingan dari waktu ke waktu di dalam rumah sakit, dengan melakukan perbandingan database eksternal dari rumah sakit sejenis atau data nasional/internasional, dan melakukan perbandingan dengan standar serta praktik terbaik berdasar atas referensi terkini.
6. Pelaksana analisis data, yaitu staf komite MUTU dan penanggung jawab data di unit, dan sudah mempunyai pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang tepat sehingga dapat berpartisipasi dalam proses tersebut dengan baik.
7. Hasil analisis data telah disampaikan kepada direktur, para kepala bidang/divisi, dan kepala unit untuk di tindaklanjuti.

BAB VII PENCAPAIAN DAN MEMPERTAHANKAN PERBAIKAN

Pasal 6

1. Rumah sakit membuat rencana perbaikan terhadap mutu dan keselamatan berdasarkan hasil capaian mutu.
2. Rumah sakit telah melakukan uji coba rencana perbaikan terhadap mutu dan keselamatan pasien.
3. Rumah sakit telah menerapkan/melaksanakan rencana perbaikan terhadap mutu dan keselamatan pasien.
4. Tersedia data yang menunjukkan bahwa perbaikan bersifat efektif dan berkesinambungan.
5. Perubahan-perubahan regulasi yang diperlukan dalam membuat rencana, melaksanakan dan mempertahankan perbaikan.
6. Keberhasilan-keberhasilan telah didokumentasikan dan dijadikan laporan mutu.
- 7.

BAB VIII VALIDASI DATA

Pasal 7

1. Rumah Sakit mempunyai regulasi validasi data
2. Regulasi validasi data sebagaimana dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Regulasi data yang harus divalidasi, yaitu :
 - 1) Pengukuran indikator mutu baru.
 - 2) Bila data akan dipublikasi ke masyarakat baik melalui website Rumah Sakit atau media lain.
 - 3) Ada perubahan pada pengukuran yang selama ini sudah dilakukan, misalnya perubahan profil indikator, instrument pengumpulan data, proses agregasi data atau perubahan staf pengumpul data atau validator.
 - 4) Bila terdapat perubahan hasil pengukuran tanpa diketahui sebabnya.
 - 5) Bila terdapat perubahan hasil pengukuran tanpa diketahui sebabnya.
 - 6) Bila terdapat perubahan sumber data, misalnya terdapat perubahan sistem pencatatan pasien dari manual ke elektronik.
 - 7) Bila terdapat perubahan subyek data seperti perubahan umur rata rata pasien, perubahan protokol riset, panduan praktik klinik baru diberlakukan, serta adanya teknologi dan metodologi pengobatan baru.
 - 8) Bila data akan dilaporkan ke Direktur dan Dewan pengawas secara regular setiap 3 (tiga) bulan
 - b. Proses validasi data mencakup namun tidak terbatas sebagai berikut:
 - 1) mengumpulkan ulang data oleh orang kedua yang tidak terlibat dalam proses pengumpulan data sebelumnya (data asli)
 - 2) menggunakan sampel tercatat, kasus dan data lainnya yang sah secara statistik. Sample 100 % hanya dibutuhkan jika jumlah pencatatan, kasus atau data lainnya sangat kecil jumlahnya.
 - 3) membandingkan data asli dengan data yang dikumpulkan ulang
 - 4) menghitung keakuratan dengan membagi jumlah elemen data yang ditemukan dengan total jumlah
 - 5) data elemen dikalikan dengan 100. Tingkat akurasi 90 % adalah patokan yang baik.
 - 6) jika elemen data yg ditemukan ternyata tidak sama, dengan catatan alasannya (misalnya data tidak Koleksi sample baru setelah semua tindakan koreksi dilakukan untuk memastikan tindakan menghasilkan tingkat akurasi yang diharapkan
 - c. Proses validasi data yang akan dipublikasi di *website* atau media lainnya agar diatur tersendiri, dan dapat menjamin kerahasiaan pasien dan keakuratan data jelas definisinya dan dilakukan tindakan koreksi
3. Rumah sakit telah melakukan validasi data pada pengukuran mutu area yang baru dan bila terjadi perubahan sesuai dengan regulasi.
4. Rumah sakit telah melakukan validasi data yang akan dipublikasikan di *website* atau media lainnya termasuk kerahasiaan pasien dan keakuratan sesuai dengan regulasi.
5. Rumah sakit telah melakukan perbaikan berdasarkan hasil

validasidata.

BAB IX EVALUASI PELAYANAN KEDOKTERAN

Pasal 8

1. Rumah Sakit menetapkan evaluasi pelayanan kedokteran
2. Direktur bersama-sama dengan pimpinan medis, ketua Komite Medik dan kelompok staf medis menetapkan evaluasi penerapan panduan praktik klinis dan evaluasi kinerja dokter yang diukur menggunakan indikator mutu.
3. Ketua Kelompok Staf Medis telah menetapkan paling sedikit 5 (lima) prioritas panduan praktik klinis-alur klinis dan/atau protokol klinis dan atau prosedur dan atau standing order, sebagai panduan dari standarisasi proses asuhan klinik yang dimonitor oleh Komite Medik. Dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Melakukan standarisasi proses asuhan klinik
 - b. Mengurangi risiko dalam proses asuhan, terutama yang berkaitan asuhan kritis
 - c. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan efisien dalam memberikan asuhan klinik tepat waktu dan efektif
 - d. Memanfaatkan indikator prioritas sebagai indikator dalam penilaian kepatuhan penerapan alur klinis di area yang akan diperbaiki di tingkat rumah sakit
 - e. Secara konsisten menggunakan praktik berbasis bukti ("*evidence based practices*") dalam memberikan asuhan bermutu tinggi
4. Evaluasi proses pelaksanaan standar pelayanan kedokteran di Rumah Sakit paling sedikit 5 (lima) evaluasi pelayanan prioritas standar pelayanan kedokteran diukur menggunakan alur klinis / *clinical pathway* (CP).
5. Hasil evaluasi dapat menunjukkan adanya perbaikan terhadap kepatuhan dan mengurangi variasi dalam penerapan prioritas standar pelayanan kedokteran di Rumah Sakit
6. Rumah sakit telah melaksanakan audit medis dan atau audit klinis pada panduan praktik klinis/alur klinis prioritas di tingkat rumah sakit.

BAB X SISTEM MANAJEMEN DATA

Bagian Kesatu Referensi

Pasal 9

1. Rumah sakit mempunyai referensi yang dipergunakan untuk meningkatkan mutu asuhan klinis dan proses kegiatan manajemen lebih baik.
2. Komite medis dan komite keperawatan mempunyai referensi peningkatan mutu asuhan klinis terkini.

Bagian Kedua Manajemen Data

Pasal 10

1. Rumah sakit mempunyai regulasi sistem manajemen data program MUTU yang terintegrasi.
2. Rumah sakit mempunyai regulasi tentang manajemen data yang meliputi:
 - a. sistem manajemen data yang meliputi pengumpulan, pelaporan, analisis, *feedback* dan publikasi data
 - b. menetapkan data-data yang akan dibandingkan dengan rumah sakit lain atau menggunakan *database* eksternal
 - c. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dalam berkontribusi dengan database eksternal.
3. Regulasi sistem manajemen data yang dimaksud pada pasal 10 ayat (2) antara lain meliputi :
 - a. rumah sakit perlu mempunyai sistem manajemen data yang didukung dengan teknologi informasi, mulai dari pengumpulan, pelaporan, analisis, validasi, serta publikasi data untuk internal rumah sakit dan eksternal Rumah Sakit Publikasi data tetap harus memperhatikan kerahasiaan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. data yang dimaksud meliputi, data dari indikator mutu unit dan indikator mutu prioritas rumah sakit;
 - c. data dari pelaporan insiden keselamatan pasien; dan
 - d. data hasil monitoring kinerja staf klinis (bila monitoring kinerja menggunakan indikator mutu).
 - e. data hasil pengukuran budaya keselamatan;
 - f. integrasi seluruh data diatas baik di tingkat rumah sakit dan unit kerja meliputi:
 - 1) pengumpulan
 - 2) pelaporan
 - 3) analisa
 - 4) validasi dan publikasi indikator mutu
4. Rumah sakit menyediakan teknologi, fasilitas, dan dukungan lain untuk menerapkan sistem manajemen data di rumah sakit sesuai dengan sumber daya yang ada di rumah sakit.
5. Rumah sakit telah melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mendukung asuhan pasien, manajemen rumah sakit, pengkajian praktik profesional, serta program mutu dan keselamatan pasien secara menyeluruh
6. Kumpulan data dan informasi disampaikan kepada badan di luar rumah sakit sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan.
7. Rumah sakit berkontribusi terhadap database eksternal dengan menjamin keamanan dan kerahasiaan

BAB XI

MENEJEMEN DATA EKSTERNAL

Pasal 11

1. Rumah sakit mempunyai regulasi tentang manajemen data yang meliputi:
 - a. sistem manajemen data yang meliputi pengumpulan, pelaporan, analisis, *feedback* dan publikasi data.
 - b. menetapkan data-data yang akan dibandingkan dengan rumah sakit lain atau menggunakan *database* eksternal.
 - c. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dalam berkontribusi

dengan database eksternal.

2. Komite MUTU melakukan koordinasi dengan unit pelayanan dalam pengumpulan data.
3. Rumah sakit melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mendukung asuhan pasien, manajemen Rumah Sakit, pengkajian praktik profesional serta program MUTU secara menyeluruh.
4. Hasil pengumpulan data dan informasi yang meliputi indikator prioritas Rumah Sakit (IMP-RS), indikator prioritas unit (IMP-Unit) dan tingkat kepatuhan DPJP terhadap PPK.
5. Kumpulan data dan informasi disampaikan kepada badan diluar Rumah sakit sesuai peraturan dan perundangan-undangan;
6. Rumah sakit berkontribusi terhadap database eksternal dengan menjamin keamanan dan kerahasiaan

BAB XII INSIDEN KESELAMATAN PASIEN

Bagian Kesatu Insiden Keselamatan Pasien

Pasal 12

1. Rumah Sakit menetapkan regulasi jenis insiden
2. Insiden di Rumah Sakit meliputi :
 - a. Kondisi Potensial Cedera (KPC) : merupakan kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden
 - b. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) : merupakan terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien.
 - c. Kejadian Tidak Cedera (KTC) : merupakan insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak timbul cedera.
 - d. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) : merupakan Insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien.
 - e. Sentinel : merupakan insiden yang mengakibatkan cedera permanen dan kematian pada pasien.

Bagian Kedua Penanganan Insiden

Pasal 13

1. Rumah Sakit harus melakukan penanganan insiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
2. Selain penanganan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit harus melakukan penanganan pada kejadian sentinel.
3. Kejadian sentinel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien.
4. Kejadian sentinel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disebabkan oleh hal lain selain Insiden.

Pasal 14

1. Penanganan insiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

-
- (1) ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien
2. Penanganan Insiden di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan tim Keselamatan Pasien yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai pelaksana kegiatan penanganan Insiden.
 3. Dalam melakukan Penanganan Insiden, tim keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kegiatan berupa :
 - a. Pelaporan
 - b. Verifikasi
 - c. Investigasi
 - d. analisis penyebab Insidentanpa menyalahkan, menghukum, dan mempermalukan seseorang.

Bagian Ketiga
Tim Keselamatan Pasien

Pasal 15

1. Tim Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur manajemen dan insur klinis pelayanan di Rumah Sakit, tim bertanggung jawab langsung kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Tim Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
 - a. menyusun kebijakan dan pengaturan di bidang Keselamatan Pasien
 - b. mengembangkan program Keselamatan Pasien
 - c. melakukan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian tentang penerapan program Keselamatan Pasien
 - d. melakukan pelatihan Keselamatan Pasien bagi staff di Rumah Sakit
 - e. melakukan pencatatan, pelaporan Insiden, analisis insiden termasuk melakukan RCA, dan mengembangkan solusi untuk meningkatkan Keselamatan Pasien
 - f. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direktur Rumah Sakit dalam rangka pengambilan kebijakan Keselamatan Pasien
 - g. membuat laporan kegiatan kepada Direktur Rumah Sakit.
 - h. mengirim laporan Insiden secara kontinu melalui *e-reporting* sesuai dengan pedoman pelaporan Insiden
3. Jika tim Keselamatan Pasien belum dapat dibentuk karena keterbatasan tenaga, Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki petugas yang bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

Bagian Keempat
Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

Pasal 16

1. Setiap Insiden harus dilaporkan secara internal kepada tim Keselamatan Pasien dalam waktu paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan format laporan insiden keselamatan pasien
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh tim Keselamatan Pasien untuk memastikan kebenaran adanya Insiden

melalui investigasi dalam bentuk wawancara dan pemeriksaan dokumen.

3. Berdadarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim keselamatan pasien menentukan drajat insiden (*grading*) dan melakukan *root cause analysis* (RCA) dengan metode baku untuk menentukan akar masalah
4. Setelah menentukan akar masalah tim keselamat pasien harus memberikan rekomendasi keselamatan pasien kepada Direktur Rumah Sakit berdasarkan hasil *Root Cause Analysis* (RCA)
5. Selanjutnya, Rumah Sakit harus melakukan pelaporan insiden kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII MANAJEMEN RESIKO

Pasal 17

1. Program manajemen risiko berkelanjutan digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengurangi cedera serta mengurangi risiko lain terhadap keselamatan pasien dan staf.
2. Komponen-komponen penting program manajemen risiko formal meliputi :
 - a. identifikasi risiko,
 - b. prioritas risiko,
 - c. pelaporan risiko,
 - d. manajemen risiko
 - e. investigasi kejadian yang tidak diharapkan (KTD) 6) manajemen terkait tuntutan (klaim)
3. Dalam menerapkan manajemen risiko rumah sakit perlu memperhatikan proses-proses berisiko yang dapat terjadi pada pasien, antara lain meliputi:
 - a. manajemen pengobatan ;
 - b. risiko jatuh;
 - c. pengendalian infeksi;
 - d. gizi;
 - e. risiko peralatan; dan
 - f. risiko sebagai akibat kondisi yang sudah lama berlangsung.
4. Ruang lingkup manajemen risiko rumah sakit yang meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. pasien;
 - b. staf medis;
 - c. tenaga kesehatan dan tenaga lainnya yang bekerja di rumah sakit;
 - d. fasilitas rumah sakit;
 - e. lingkungan rumah sakit; dan
 - f. bisnis rumah sakit

BAB XIV BUDAYA KESELAMATAN

Bagian Kesatu
Bangun Budaya Keselamatan

Pasal 18

1. Budaya keselamatan di rumah sakit adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang terbuka dan tidak menyalahkan sehingga menimbulkan rasa aman staff untuk melakukan pelaporan jika melihat atau menemukan insiden terkait keselamatan pasien
2. Rumah sakit menentukan regulasi tentang budaya keselamatan pasien
3. Direktur Rumah Sakit menentukan kebijakan yang mengatur tentang alur penanganan insiden oleh staf disertai peran individu dan akuntabilitasnya bila terjadi insiden
4. Direktur Rumah Sakit melakukan suvei budaya keselamatan untuk menilai budaya pelaporan dan pembelajaran di Rumah Sakit.

Bagian Kedua

Integrasi Budaya Keselamatan dengan Manajemen Resiko

Pasal 19

1. Rumah sakit membangun sistem dan proses untuk mengelola resiko yang ada di setiap unit dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan dari setiap resiko di unit.
2. Rumah sakit melakukan integrasi terhadap manajemen resiko, keselamatan staf, manajemen komplain, penanganan litigasi dan klaim serta resiko keuangan dan lingkungan di dukung oleh strategi manajemen resiko yang mencakup program asesmen resiko secara pro-aktif dan risk regiser.
3. Pengaturan sistem menjaga kerahasiaan, sederhana, dan mudah diakses oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk melaporkan masalah yang terkait dengan budaya keselamatan dalam rumah sakit secara tepat waktu.
4. Sistem yang rahasia, sederhana, dan mudah diakses oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk melaporkan masalah yang terkait dengan budaya keselamatan dalam rumah sakit telah disediakan.
5. Semua laporan terkait dengan budaya keselamatan rumah sakit telah diinvestigasi secara tepat waktu.
6. Evaluasi dan pemantauan budaya keselamatan menggunakan pengukuran/indikator mutu dalam rumah sakit serta melaksanakan perbaikan yang telah teriden kasi dari pengukuran dan evaluasi tersebut.
7. Pencegahan kerugian/dampak terhadap individu yang melaporkan masalah terkait dengan budaya keselamatan tersebut telah diatur.

BAB XV

MONITORING, EVALUASI DAN KOORDINASI

Pasal 20

1. Rumah sakit telah membuat rencana perbaikan terhadap mutu dankeselamatan berdasar atas hasil capaian mutu.
2. Rumah sakit telah melakukan uji coba rencana perbaikan terhadap mutu dan keselamatan pasien.
3. Rumah sakit telah menerapkan/melaksanakan rencana perbaikanterhadap mutu dan keselamatan pasien.

-
4. Tersedia data yang menunjukkan bahwa perbaikan bersifat efektif danberkesinambungan.
 5. Bukti perubahan-perubahan regulasi yang diperlukan dalam membuat rencana, melaksanakan, dan mempertahankan perbaikan.
 6. Keberhasilan telah didokumentasikan dan dijadikan laporan Mutu.
 7. Untuk melakukan perbaikan Komite Mutu melakukan koordinasi dengan Komite Lain dan Kepala Ruang Unit Pelayanan maupun Penunjang

BAB XVI PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai dengan pasal 21 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan direktur ini.

Pasal 22

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 03 Januari 2026

PLT Direktur RS Prima Husada Malang,



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 004.2/I-PDM/KMKP/I/2026
TENTANG
PEDOMAN PENINGKATAN MUTU DAN
KESELAMATAN PASIEN

PEDOMAN PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Bila rumah sakit ingin berhasil dalam memulai dan mempertahankan perbaikan serta mengurangi risiko bagi pasien dan staf, kepemimpinan dan perencanaan merupakan hal yang penting. Kepemimpinan dan perencanaan dimulai dari pemilik dan representasi pemilik, Direktur Rumah Sakit, para pimpinan klinis, dan pimpinan manajerial secara bersama-sama menyusun dan mengembangkan program peningkatan mutu serta keselamatan pasien. Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab untuk memulai dan menyediakan dukungan berkelanjutan dalam hal komitmen rumah sakit terhadap mutu. Direktur Rumah Sakit mengembangkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta mengajukan persetujuan program kepada representasi pemilik, dan melalui misi rumah sakit serta dukungan pemilik rumah sakit membentuk suatu budaya mutu di rumah sakit.

Direktur Rumah Sakit juga menerapkan suatu struktur dan proses untuk memantau dan melakukan koordinasi menyeluruh terhadap program yang ada di rumah sakit. Tindakan ini memastikan koordinasi di seluruh unit pelayanan dalam upaya pengukuran dan perbaikan. Koordinasi ini dapat tercapai melalui pemantauan dari unit/departemen mutu atau komite/tim peningkatan mutu, atau struktur lainnya. Koordinasi ini mendukung pendekatan sistem untuk pemantauan kualitas dan aktivitas perbaikan sehingga mengurangi duplikasi upaya peningkatan mutu. Misalnya terdapat dua departemen yang secara independen mengukur suatu proses atau luaran yang sama.

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang selanjutnya disingkat MUTU merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan (*never ending process*). Di sisi lain, kegiatan MUTU harus dilaksanakan di setiap unit kerja yang memerlukan mekanisme koordinasi antarunit dan juga antarkepala unit kerja termasuk dengan komite medis dan komite keperawatan sehingga kegiatan MUTU tetap sesuai dengan program MUTU yang sudah disetujui oleh pemilik atau representasi pemilik.

Karena itu, rumah sakit perlu menetapkan organisasi yang mengelola kegiatan MUTU yang dapat berbentuk Komite MUTU atau bentuk organisasi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlu diingat bahwa kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien tidak dapat dipisahkan secara tegas karena ada kegiatan yang sering tumpang tindih (*overlapping*), misalnya terkait dengan pemilihan indikator mutu untuk pelayanan bedah, yaitu salah operasi, salah orang, dan salah prosedur. Data tersebut juga merupakan data insiden keselamatan pasien. Karena itu, kegiatan peningkatan mutu dan kegiatan keselamatan pasien sebaiknya dilaksanakan secara terintegrasi yang dikelola oleh komite lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat yang dikelola adalah data mutu dan data insiden maka di bawah komite dapat dibentuk subkomite/subtim/penanggung jawab yang mengelola mutu dan keselamatan pasien yang disesuaikan dengan kondisi rumah sakit dan peraturan perundang-undangan. Selain komite, rumah sakit juga perlu mempunyai penanggungjawab data di setiap unit kerja yang diharapkan dapat

membantu komite dalam pengumpulan dan analisis data.

1.2 Tujuan Pedoman

Untuk dijadikan pedoman RS dalam mengelola kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

1.3 Sasaran

Seluruh karyawan Rumah Sakit Prima Husada Malang

BAB II

DEFINISI OPERASIONAL

2.1 Mutu Pelayanan Kesehatan

2.1.1 Definisi Mutu Pelayanan Kesehatan

Dalam kehidupan sehari-hari mutu bersifat persepsi pada setiap orang, dimana setiap orang memiliki persepsi yang berbeda namun berimplikasi pada superioritas suatu hal. Keahlian seseorang dalam melakukan pekerjaan juga disebut sebagai mutu dimana, diartikan petugas melakukan pekerjaan atau kegiatan tanpa salah dalam melakukan pekerjaan baik produk atau jasa.

Di dalam Rumah Sakit, mutu pelayanan kesehatan diartikan sebagai derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien, dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah, serta masyarakat konsumen (Wijono, 1999).

2.1.2 Definisi Peningkatan Mutu

Peningkatan mutu adalah keseluruhan upaya dan kegiatan yang komprehensif dan integratif yang menyangkut input, proses dan output secara objektif, sistematis dan berlanjut memantau dan menilai mutu dan kewajaran pelayanan terhadap pasien, dan memecahkan masalah-masalah yang terungkap sehingga mutu pelayanan kesehatan diharapkan akan lebih baik dan keselamatan pasien terjamin.

2.2 Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

2.2.1 Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)

Indikator mutu merupakan suatu cara untuk menilai penampilan kerja suatu kegiatan dengan menggunakan instrument. Indikator merupakan variabel yang digunakan untuk memulai suatu perubahan. Indikator nasional mutu (INM) yaitu indikator mutu nasional yang wajib dilakukan pengukuran dan digunakan sebagai informasi mutu secara nasional.

2.2.2 Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS)

Indikator mutu prioritas rumah sakit yaitu indikator yang dipilih untuk pengukuran yang berdampak luas atau menyeluruh di rumah sakit mencakup :

1. Indikator sasaran keselamatan pasien
2. Indikator pelayanan klinis prioritas
3. Indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit
4. Indikator terkait perbaikan sistem
5. Indikator terkait manajemen resiko

2.2.3 Pengukuran Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP-Unit)

Indikator mutu prioritas unit adalah indikator prioritas yang khusus dipilih kepala unit.

2.2.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data indikator mutu dilaksanakan oleh penanggung jawab data yang ada di masing-masing unit kerja yang dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis indikator yang ada di unit tersebut. Data dikumpulkan secara manual dengan mengisi formulir monitoring sesuai dengan indikator yang ada di unit tersebut melalui observasi, wawancara maupun studi dokumen.

2.2.5 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk mendapatkan simpulan. Secara garis besar pengolahan atau analisis data dilakukan setelah seluruh data indikator mutu yang diperlukan telah terkumpul. Analisis data melibatkan individu di dalam Komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang memahami manajemen

informasi, mempunyai keterampilan dalam metode pengumpulan data dan mengetahui cara menggunakan berbagai alat statistik.

Tujuan analisis data adalah dapat membandingkan rumah sakit dalam empat hal yaitu dengan data di rumah sakit dari waktu ke waktu, membandingkan dengan rumah sakit lain, membandingkan dengan standar, membandingkan dengan praktik yang diinginkan.

Adapun metode analisis yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dengan menggunakan bantuan statistik. Terkait dengan analisis data indikator mutu lebih banyak menggunakan teknik statistik deskriptif yang merupakan proses transformasi data dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik dengan menggunakan program Excel dapat berupa model run chart, diagram kontrol (*control chart*), histogram dan diagram pareto. Hasil analisis data dibuatkan laporan disampaikan kepada Direktur, para kepala bidang/divisi dan kepala unit untuk ditindaklanjuti.

Analisa data meliputi :

1. Penggunaan statistik dalam melakukan analisis data.
2. Analisis yang harus dilakukan yaitu :
 - a. Membandingkan data di rumah sakit dari waktu ke waktu (analisis trend) misalnya bulan ke bulan atau tahun ke tahun.
 - b. Membandingkan dengan rumah sakit lain / dengan rumah sakit sejenis melalui data base eksternal baik nasional maupun internasional.
 - c. Membandingkan dengan standar seperti yang ditentukan oleh badan akreditasi atau organisasi profesional ataupun standar yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan.
 - d. Membandingkan dengan praktik yang diinginkan yang dalam literatur digolongkan sebagai best practice (praktik terbaik) atau better practice (praktik yang lebih baik) atau practice guidelines (panduan praktik klinik). Untuk melakukan validasi dan analisis data diperlukan staf yang sudah mengikuti pelatihan .

2.2.6 Pelaporan dan Perbaikan Mutu dan Mempertahankan Capaian

Data indikator mutu yang ada di unit akan dikumpulkan oleh penanggung jawab data unit dan diterima Komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Untuk indikator yang nilai capaiannya masih rendah Unit akan melakukan rencana perbaikan terhadap mutu dan keselamatan pasien atas capaian hasil mutu dengan menggunakan metode PDSA. Setelah itu, Data tersebut nantinya akan diolah dan dibuatkan laporan setiap tiga bulan, semester dan tahunan disampaikan ke Direktur dan Direktur menyampaikan ke representasi pemilik.

2.2.7 Validasi Data dan Publikasi Data

Data yang dipublikasi harus sudah divalidasi oleh Komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien dimana publikasi dilaksanakan oleh Komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan berkoordinasi dengan Instalasi rekam medis. Publikasi data internal dilakukan melalui pelaporan, untuk publikasi eksternal dapat dilakukan melalui website rumah sakit atau cara lainnya seperti melalui papan informasi.

Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan baik dan valid. Validasi data dilakukan setiap triwulan, dengan penanggung jawab adalah Penanggung Jawab Mutu Rumah Sakit

2.2.8 Evaluasi Pelaksanaan Panduan Praktik Klinis (PPK-CP)

Setiap kelompok staf medis (KSM) memilih dan menetapkan panduan praktik klinis yang dapat dilengkapi dengan alur klinis (clinical pathway) dan atau protokol klinis dan atau prosedur dan atau standing order sebagai panduan asuhan klinis yang akan dievaluasi. Panduan praktik klinis, alur klinis (clinical pathway) atau protokol yang diseleksi untuk dilakukan evaluasi memenuhi kriteria :

1. Sesuai dengan populasi pasien yang ada dan misi rumah sakit.
2. Disesuaikan dengan teknologi obat, sumber daya di rumah sakit atau norma

profesional yang berlaku secara nasional.

3. Dilakukan asesmen terhadap bukti ilmiahnya dan disahkan oleh pihak berwenang.
4. Disetujui resmi atau digunakan oleh rumah sakit.
5. Dilaksanakan dan diukur terhadap efektivitasnya.
6. Dijalankan oleh staf yang terlatih menerapkan pedoman atau pathway.
7. Secara berkala diperbaharui berdasar bukti dan evaluasi dari proses dan hasil proses.

Setiap kelompok staf medis (KSM) setiap tahun :

1. Menetapkan secara bersama paling sedikit setiap tahun 5 (lima) panduan praktik klinis untuk diimplementasikan di unit pelayanan.
2. Menetapkan panduan pemilihan dan penyusunan panduan praktik klinis , alur klinis (*clinical pathway*) dan atau protokol klinis dan atau prosedur dan atau standing order sebagai panduan asuhan klinis.

Komite medis bersama-sama dengan pimpinan pelayanan medis melakukan monitoring kepatuhan staf medis/DPJP terhadap panduan praktik klinis dengan sasaran untuk :

1. Standarisasi proses asuhan klinis
2. Mengurangi risiko dalam proses asuhan istimewa yang berkaitan dengan keputusan tentang asuhan kritikal
3. Memberikan asuhan klinik tepat waktu, efektif, menggunakan sumber daya yang tersedia dengan efisien.
4. Memberikan asuhan bermutu tinggi secara konsisten menggunakan evidence based practices

Monitoring dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi :

1. Ketepatan penggunaan obat
2. Pemeriksaan penunjang medik
3. Length of stay (LOS).

2.2.9 Penerapan Sasaran Keselamatan Pasien

Keselamatan pasien merupakan suatu sistem yang membentuk Rumah Sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen resiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan resiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil (Permenkes RI no 11 Tahun 2017)

Tujuan dari sistem keselamatan pasien di Rumah Sakit adalah :

1. Menciptakan budaya keselamatan pasien di Rumah Sakit.
2. Meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat.
3. Menurunkan angka insiden keselamatan pasien di Rumah Sakit.
4. Terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian yang sama / tidak diharapkan.

Menurut Permenkes RI nomor 11 tahun 2017, pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa penyelenggaraan keselamatan pasien dilakukan melalui pembentukan sistem pelayanan dengan menerapkan :

1. Standar keselamatan pasien

Standar keselamatan pasien di Rumah Sakit di Indonesia disusun mengacu pada "*Hospital Patient Safety Standards*" yang diterbitkan oleh *Joint Commission on Accreditation of Health Organization, Illinois, USA* tahun 2002 yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perumasan di Indonesia. Standar keselamatan pasien wajib diterapkan di Rumah Sakit dan penilaiannya dilakukan dengan menggunakan instrument akreditasi Rumah Sakit. Dalam pedoman Nasional Keselamatan pasien Rumah Sakit (2015) dijelaskan bahwa terdapat 7 Standar Keselamatan Pasien, yang terdiri dari :

- a. Standar 1 - Hak Pasien
Dimana pasien beserta keluarganya berhak mengetahui tentang rencana pengobatan dan hasil yang diharapkan ketika perawatan. Selain itu, keluarga juga berhak tau tentang kemungkinan insiden yang mungkin terjadi selama pengobatan.
- b. Standar 2 – Mendidik Pasien dan Keluarga
Memberikan edukasi atau pembelajaran kepada pasien dan keluarga, terutama tentang kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pasien dan keluarga selama dilakukannya proses pelayanan kesehatan. Pendidikan ini akan membuat pengobatan berjalan dengan lancar dan penyembuhan dapat berjalan lebih cepat.
- c. Standar 3 – Keselamatan Pasien dan Kesiambungan Pelayanan Fasilitas kesehatan dapat menjamin keselamatan pasien secara berkesinambungan dalam pelayanan kesehatan, serta dapat menjamin kerjasama antara tim pelayanan dalam mencapai kesembuhan pasien
- d. Standar 4 – Penggunaan Metode-Metode Peningkatan Kinerja
Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja, dimana peningkatan kinerja ini bertujuan untuk melakukan evaluasi sekaligus meningkatkan program keselamatan pasien.
- e. Standar 5 – Peran Kepemimpinan dalam Meningkatkan Keselamatan Pasien
Pemimpin berperan penting dalam upaya peningkatan keselamatan pasien, dengan standar sebagai berikut :
 - 1) Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan “Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit”.
 - 2) Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi Kejadian Tidak Diharapkan.
 - 3) Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien.
 - 4) Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta meningkatkan keselamatan pasien
 - 5) Pimpinan mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien.
- f. Standar 6 – Mendidik Staf tentang keselamatan Pasien
Fasilitas pelayanan kesehatan, bukan hanya membuat kriteria keselamatan pasien saja, tetapi harus memberikan pendidikan terhadap pihak-pihak yang ikut serta dalam pelayanan kepada pasien. Berikut standarnya :
 - 1) Rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan dan orientasi bagi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas.
 - 2) Rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf serta mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien
 - 3) Rumah sakit harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap kegiatan *in-service training* dan memberi pedoman yang jelas terhadap pelaporan insiden
- g. Standar 7 – Komunikasi
Komunikasi menjadi salah satu kunci bagi setiap staf untuk mencapai

keselamatan pasien, dengan standar seperti berikut :

- 1) Rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal terkait dengan keselamatan pasien.
- 2) Tersedianya mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang ada. (Depkes, 2015).

2. Sasaran keselamatan pasien

Sasaran Keselamatan Pasien RS merupakan syarat mutlak yang wajib diterapkan di semua rumah sakit yang diakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Penyusunan sasaran mengacu pada Nine Life - Saving Patient Safety Solutions dari WHO Patient Safety (2007) dan dari Joint Commission International (JCI). Maksud dari Sasaran Keselamatan Pasien adalah mendorong perbaikan spesifik dalam keselamatan pasien. Sasaran lebih menyoroti bagian - bagian yang bermasalah dalam pelayanan kesehatan dan menjelaskan bukti serta solusi dari konsensus berbasis bukti dan keahlian atas permasalahan tersebut. Berikut Enam Sasaran Keselamatan Pasien (Depkes, 2015) :

- a. Sasaran Keselamatan Pasien 1 : Ketepatan identifikasi pasien Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki / meningkatkan ketelitian indentifikasi pasien. Sesuai prosedur identifikasi pasien memerlukan sedikitnya dua cara mengidentifikasi seperti : dengan dua nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, gelang (identitas pasien). Identifikasi pasien dilakukan pada semua pasien tanpa terkecuali, pasien koma juga termasuk. Kegiatan yang perlu dilakukan identifikasi yaitu :
 - 1) Pasien di identifikasi menggunakan 2 identifikasi pasien tidak boleh menggunakan nomor kamar atau lokasi pasien
 - 2) Pasien di identifikasi sebelum pemberian obat, darah, atau produk darah
 - 3) Pasien di identifikasi sebelum mengambil darah dan spesimen untuk pemeriksaan klinis pasien di identifikasi sebelum pemberian pengobatan dan tindakan atau prosedur
 - 4) Kebijakan dan prosedur mengarahkan pelaksanaan identifikasi yang konsisten pada semua situasi dan lokasi
- b. Sasaran Keselamatan Pasien 2 : Peningkatan komunikasi yang efektif Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antar para pemberi pelayanan. Kegiatan yang perlu dilakukan menggunakan komunikasi efektif yaitu :
 - 1) Perintah lisan dan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
 - 2) Perintah lisan dan melalui telpon atau hasil pemeriksaan secara lengkap dibacakan kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
 - 3) Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh individu yang memberi perintah atau hasil pemeriksaan tersebut.
 - 4) Kebijakan dan prosedur mendukung praktek yang konsisten dalam melakukan verifikasi terhadap akurasi dari komunikasi lisan melalui telepon.
- c. Sasaran Keselamatan Pasien 3 : Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat – obatan yang perlu diwaspadai (high alert). Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :
 - 1) Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan agar memuat proses identifikasi, lokasi, pemberian label, dan penyimpanan obat-obat yang

- perlu diwaspadai.
- 2) Kebijakan dan prosedur diimplementasikan.
 - 3) Elektrolit konsentrat tidak berada di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja di area tersebut, bila diperkenankan kebijakan.
 - 4) Elektrolit konsentrat yang disimpan di unit pelayanan pasien harus diberi label yang jelas, dan disimpan pada area yang dibatasi ketat (restricted).
- d. Sasaran Keselamatan Pasien 4: Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk memastikan tepatlokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
- 1) Rumah sakit menggunakan suatu checklist atau proses lain untuk memverifikasi saat preoperasi tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia, tepat, dan fungsional.
 - 2) Tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatat prosedur “sebelum insisi/time-out” tepat sebelum dimulainya suatu prosedur/tindakan pembedahan.
 - 3) Kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk mendukung keseragaman proses untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien, termasuk prosedur medis dan tindakan pengobatan gigi/dental yang dilaksanakan di luar kamar operasi.
- e. Sasaran Keselamatan Pasien 5: Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan pasien Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk mengurangi risiko infeksi yang terkait pelayanan pasien. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :
- 1) Rumah sakit mengadopsi atau mengadaptasi pedoman hand hygiene terbaru yang diterbitkan dan sudah diterima secara umum (al.dari WHO Patient Safety).
 - 2) Rumah sakit menerapkan program hand hygiene yang efektif.
 - 3) Kebijakan dan/atau prosedur dikembangkan untuk mengarahkan pengurangan secara berkelanjutan risiko infeksi yang terkait pelayanan kesehatan
- f. Sasaran Keselamatan Pasien 6 : Pengurangan risiko pasien jatuh Rumah sakit mengembangkan pendekatan untuk mengurangi risiko pasien dari cedera karena jatuh. (Depkes, 2015) kegiatan yang dilaksanakan meliputi:
- 1) Rumah sakit menerapkan proses asesmen awal risiko pasien jatuh dan melakukan asesmen ulang terhadap pasien bila diindikasikan terjadi perubahan kondisi atau pengobatan.
 - 2) Langkah-langkah diterapkan untuk mengurangi risiko jatuh bagi mereka yang pada hasil asesmen dianggap berisiko
3. Tujuh langkah menuju keselamatan pasien
- Sangat penting bagi Rumah Sakit untuk dapat menilai kemajuan yang dicapai dalam memberikan asuhan yang lebih aman. Hal ini dapat dilakukan melalui tujuh langkah keselamatan pasien, dengan menerapkan hal tersebut rumah sakit dapat memastikan bahwa asuhan yang diberikan seaman mungkin dan jika terjadi suatu hal yang tidak benar dapat segera ditangani dengan tepat. Tujuh langkah menuju keselamatan pasien terdiri dari :
- a. membangun kesadaran akan nilai Keselamatan Pasien. Ciptakan budaya adil dan terbuka.
 - b. memimpin dan mendukung staf. Tegakkan fokus yang kuat dan jelas tentang keselamatan pasien diseluruh Fasilitas pelayanan Kesehatan

anda.

- c. mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Bangun sistem dan proses untuk mengelola risiko dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kesalahan
- d. mengembangkan sistem pelaporan Pastikan staf anda mudah untuk melaporkan insiden secara internal (lokal) maupun eksternal (nasional).
- e. melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien Kembangkan cara-cara berkomunikasi cara terbuka dan mendengarkan pasien.
- f. belajar dan berbagi pengalaman tentang Keselamatan Pasien. Dorong staf untuk menggunakan analisa akar masalah guna pembelajaran tentang bagaimana dan mengapa terjadi insiden.
- g. mencegah cedera melalui implementasi sistem Keselamatan Pasien Pembelajaran lewat perubahan-perubahan didalam praktek, proses atau sistem. Untuk sistem yang sangat kompleks seperti Fasilitas pelayanan Kesehatan untuk mencapai hal-hal diatas dibutuhkan perubahan budaya dan komitmen yang tinggi bagi seluruh staf dalam waktu yang cukup lama

2.2.10 Insiden Keselamatan Pasien

Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan *harm* (penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain – lain) yang tidak seharusnya terjadi (Depkes, 2015). Berikut merupakan jenis-jenis insiden yang dapat terjadi di Rumah sakit :

1. Kondisi Potensial Cedera (KPC), merupakan kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden
2. Kondisi Nyaris Cedera (KNC), merupakan terjadinya insiden yang belum sampai terparap ke pasien.
3. Kejadian Tidak Cedera (KNC), merupakan insiden yang sudah terparap ke pasien, tetapi tidak timbul cedera.
4. Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), merupakan Insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien.
5. Kejadian Sentinel, merupakan suatu Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempetahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien.

Kejadian sentinel meliputi :

- a. Kematian tidak terduga termasuk, dan tidak terbatas hanya : Kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit pasien atau kondisi pasien (contoh : kematian setelah infeksi pascaoperasi atau emboli paru – paru), Kematian bayi aterm dan Bunuh diri
- b. Kehilangan permanen fungsi yang tidak terkait dengan penyakit pasien atau kondisi pasien
- c. Operasi salah tempat, salah prosedur, salah pasien
- d. Terjangkitnya penyakit kronik atau penyakit fatal akibat transfusi darah atau produk darah
- e. Penculikan anak termasuk bayi atau anak termasuk bayi yang dikirim ke rumah bukan rumah orang tuanya
- f. Perkosaan, kekejaman di tempat kerja, seperti penyerangan (berakibat kematian atau kehilangan fungsi secara permanen), atau pembunuhan (yang disengaja) atas pasien, anggota staf, dokter, siswa latihan, serta pengunjung atau vendor/pihak ketiga ketika berada dalam lingkungan rumah sakit Penting untuk diperhatikan bahwa istilah kejadian sentinel tidak selalu mengarah kepada kekeliruan (error) dan kesalahan (mistake) maupun memberi kesan pertanggungjawaban legal (liability) tertentu.

2.2.11 Budaya Keselamatan Pasien

Budaya keselamatan pasien merupakan produk dari nilai, sikap, persepsi, kompetensi dan pola perilaku dari individu dan kelompok di Rumah sakit yang menentukan komitmen, gaya dan kemahiran dalam manajemen keselamatan pasien. Rumah Sakit cenderung memiliki budaya keselamatan pasien yang positif, hal ini dapat dilihat dari komunikasi saling percaya antar komponen, dengan persepsi yang sama tentang pentingnya keselamatan dan dengan keyakinan akan besarnya manfaat tindakan pencegahan (*Agency for Healthcare Research and Quality*, 2004)

Budaya keselamatan pasien memiliki manfaat yang baik bagi pasien antara lain:

1. Organisasi lebih tahu jika ada kesalahan yang akan terjadi atau jika kesalahan telah terjadi.
2. Meningkatnya laporan kejadian yang dibuat dan belajar dari kesalahan yang terjadi akan berpotensi menurunkan kejadian sama yang berulang kembali dan keparahan dari keselamatan pasien.
3. Kesadaran akan keselamatan pasien, yaitu bekerja untuk mencegah error dan melaporkan jika ada kesalahan.
4. Berkurangnya perawat yang merasa tertekan, bersalah, malu karena kesalahan yang telah diperbuat.
5. Berkurangnya turn over pasien, karena pasien yang mengalami insiden umumnya akan mengalami perpanjangan hari perawatan dan pengobatan yang diberikan lebih dari pengobatan yang seharusnya diterima pasien.
6. Mengurangi biaya yang diakibatkan oleh kesalahan dan penambahan terapi.
7. Mengurangi sumber daya yang dibutuhkan dalam menangani keluhan pasien

Selain memiliki manfaat bagi pasien, penilaian budaya keselamatan pasien juga memiliki manfaat bagi rumah sakit, yakni :

1. Mendiagnosis dan meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan pasien.
2. Evaluasi program dan melihat perubahan budaya keselamatan secara periodik.
3. Melakukan benchmarking baik internal maupun eksternal
4. Sebagai pemenuhan standar dan peraturan yang berlaku.

2.2.12 Penanganan Insiden Keselamatan Pasien

Rumah sakit harus melakukan penanganan insiden keselamatan pasien yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Penanganannya insiden di Rumah Sakit dilakukan melalui pembentukan Tim Keselamatan Pasien yang ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit. Dalam melakukan penanganan insiden dilakukan beberapa kegiatan berupa pelaporan, verifikasi, investigasi dan analisa penyebab insiden tanpa menyalahkan, menghukum dan mempermalukan seseorang (Permenkes No 11 tahun 2017).

2.2.13 Penerapan Manajemen Risiko

Resiko adalah peristiwa atau keadaan yang mungkin terjadi yang dapat berpengaruh negatif terhadap perusahaan. Pengaruhnya dapat berdampak terhadap kondisi sumber daya (*human and capital*), produk dan jasa, atau Pelanggan, dan dapat juga berdampak eksternal terhadap masyarakat, pasar atau lingkungan. Untuk dapat menanggulangi semua risiko yang mungkin terjadi, diperlukan sebuah proses yang dinamakan sebagai manajemen risiko .

Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia di rumah sakit. Rumah sakit perlu melakukan pendekatan proaktif untuk manajemen risiko. Salah satunya adalah dengan program manajemen risiko formal yang komponen – komponen pentingnya meliputi :

1. Identifikasi Risiko
2. Prioritas Risiko

-
3. Pelaporan Risiko
 4. Manajemen Risiko
 5. Investigasi kejadian yang tidak diharapkan (KTD)
 6. Manajemen terkait tuntutan (klaim)

Tujuan ditetapkan manajemen resiko di Rumah Sakit adalah :

1. Tujuan Umum : Memberikan pelayanan yang aman, bermutu dan menurunkan risiko yang terdapat di rumah sakit.
2. Tujuan Khusus :
 - a. Menurunkan angka insiden keselamatan pasien, angka insiden hospital safety sebagai bentuk pencegahan cedera pasien, pengunjung, dokter provider dan karyawan rumah sakit.
 - b. Proteksi terhadap aset finansial rumah sakit.
 - c. Proteksi terhadap aset reputasi rumah sakit.
 - d. Menurunkan angka infeksi.

2.3 Pelatihan Staff dalam Program MUTU

Direktur rumah sakit bersama-sama dengan Wakil Direktur dan para manager di rumah sakit merumuskan program pelatihan Mutu untuk pimpinan rumah sakit serta seluruh staf yang terlibat dalam pengumpulan, analisis dan validasi data yang diberikan oleh narasumber yang kompeten.

1. Direktur rumah sakit menunjuk dan mengangkat narasumber program diklat Mutu yang kompeten, ditetapkan dengan SK Dir tentang Tim Pengajar Mutu Seluruh personil yang terlibat dalam pengelolaan data mutu dan keselamatan pasien dijadwalkan dan dipastikan mengikuti program diklat yang telah dibuat.

BAB III

KEBIJAKAN & REFERENSI MUTU

3.1 Referensi Regulasi MUTU

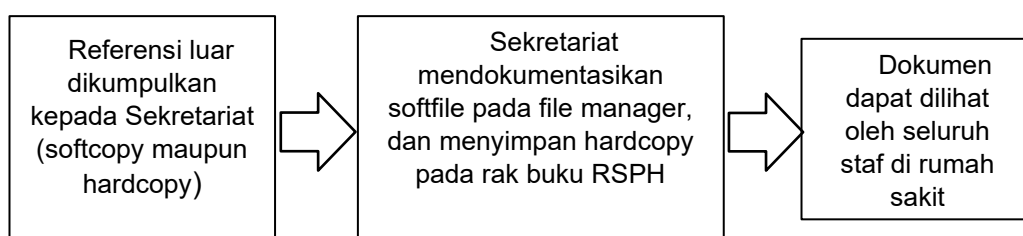
Rumah sakit mempunyai referensi terkini tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien berdasar atas ilmu pengetahuan dan informasi terkini serta perkembangan konsep peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Kegiatan peningkatan mutu dan keselamatan pasien memerlukan regulasi yang didasarkan atas referensi ilmiah terkini. Karena ilmu pengetahuan terus berkembang maka rumah sakit wajib menyediakan referensi yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan mutu serta keselamatan pasien. Referensi yang harus disediakan oleh rumah sakit dapat berupa literatur ilmiah terkait asuhan pasien dan manajemen, international clinical guidelines, pedoman nasional praktik kedokteran, pedoman praktik klinis (clinical practice guidelines), temuan penelitian dan metodologi pendidikan, fasilitas internet, bahan cetak di perpustakaan, sumber-sumber pencarian online, bahan-bahan pribadi, serta peraturan perundang-undangan adalah sumber informasi terkini yang berharga.

Secara rinci referensi dan informasi terkini yang diperlukan rumah sakit dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien meliputi:

1. literatur ilmiah dan informasi lainnya yang dapat dipergunakan untuk mendukung asuhan pasien terkini, misalnya pedoman nasional pelayanan kedokteran dan international clinical guidelines;
2. literatur ilmiah dan informasi lainnya yang dapat dipergunakan untuk mendukung penelitian (khusus untuk rumah sakit pendidikan);
3. literatur ilmiah dan informasi lainnya yang dapat dipergunakan untuk mendukung terselenggaranya manajemen yang baik;
4. informasi lainnya sesuai dengan kebutuhan rumah sakit, misalnya data indikator mutu ditingkat nasional atau internasional;
5. peraturan perundang-undangan terkait dengan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit termasuk pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Referensi di atas agar dipergunakan dalam menyusun regulasi proses kegiatan asuhanklinis pada pasien dan proses kegiatan manajemen yang baik termasuk didalamnya komite medis dan komite keperawatan. Di sisi lain, untuk melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien maka rumah sakit agar mempunyai regulasi peningkatan mutu dan keselamatan pasien sebagai acuan dalam meningkatkan mutu serta keselamatan pasien rumah sakit yang dapat dilengkapi dengan SPO sesuai dengan kebutuhan.

Bagan 3.1
Alur Penyimpanan Regulasi MUTU



Alur Penyimpanan Referensi di RS Prima Husada terdiri dari:

1. Peraturan perundang-undangan (Undang-undang, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Menteri)
2. Konsil
3. Panduan Nasional Praktik Klinis.

3.2 Kebijakan yang Digunakan di MUTU

Rumah Sakit Prima Husada berkomitmen dalam melaksanakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dijadikan acuan dalam penyusunan pedoman peningkatan mutu dan keselamatan pasien antara lain :

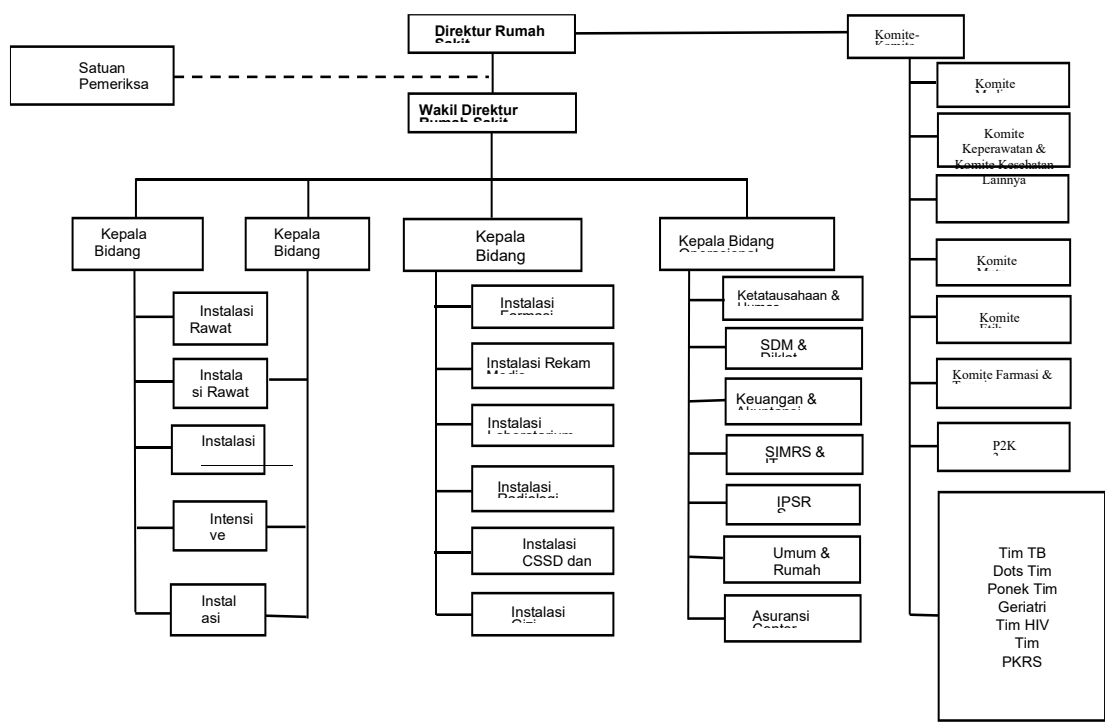
1. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Praktik Kedokteran
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/174 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampunan Pelayanan Kesehatan Prioritas
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

4.1.
4.2. Struktur Organisasi

Memperhatikan bahwa mutu dan keselamatan pasien merupakan hal yang sangat penting, maka diperlukan adanya suatu bagian yang dapat mengkoordinir dan mengelola secara intens terkait program mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada

Bagan 4.1
Struktur Organisasi RS. Prima Husada Malang

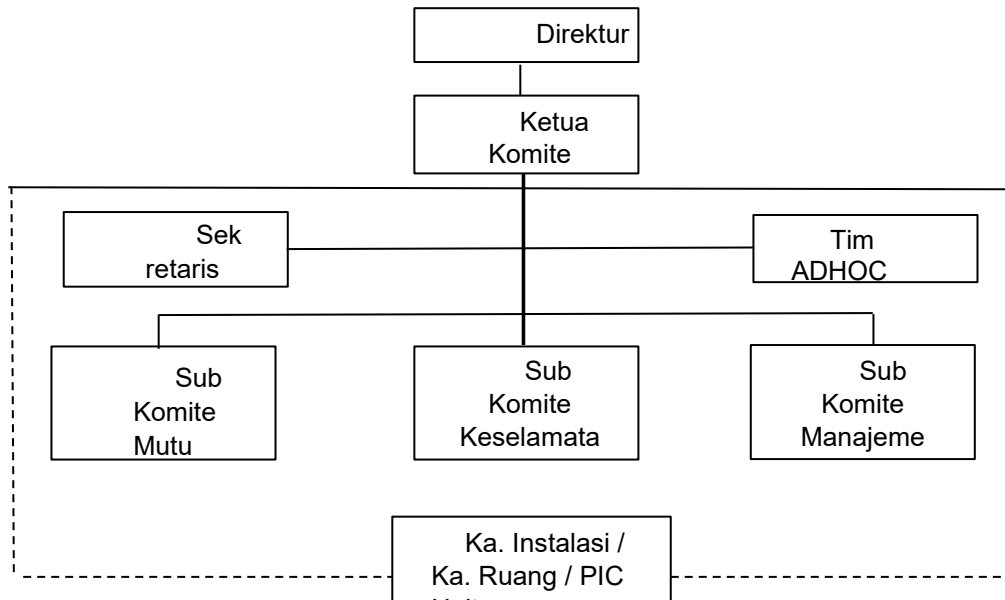


Komite mutu adalah jajaran struktural dibawah Direktur serta bertanggung jawab kepada kepala Direktur RS Prima Husada, yang bertugas agar tujuan pengawasan mutu di Rumah Sakit berjalan dengan baik.

Direktur dibantu oleh komite mutu untuk mengelola seluruh mutu pelayanan dan terkait akreditasi yang dilaksanakan di Rumah Sakit. Komite Mutu terdiri atas kepala komite dan sekretaris mutu. Kemudian dibagi menjadi Sub komite Mutu, sub komite Keselamatan pasien, dan sub komite manajemen resiko. Dalam menjalankan tugasnya komite mutu dibantu oleh tim Adhoc yang terdiri dari penanggungjawab mutu unit.

Bagan 4.2

Struktur Organisasi Komite Mutu RS. Prima Husada



4.3. Uraian Tugas

A. Uraian Tugas Direktur

Tabel 4.1 Uraian Tugas Direktur di Komite Mutu

1	Nama Jabatan	Direktur
2	Tugas Pokok	Mengelola dan mengendalikan kegiatan terkair pelayanan di RS. Prima Husada
3	Tanggung Jawab	1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengelolaan RS 2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RS. Prima Husada
5	Wewenang	1. mendorong dan menjamin implementasi Keselamatan Pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan tujuh langkah menuju Keselamatan Pasien; 2. menjamin berlangsungnya kegiatan identifikasi risiko Keselamatan Pasien dan menekan atau mengurangi insiden secara proaktif; 3. menumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang Keselamatan Pasien; 4. mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan serta meningkatkan Keselamatan Pasien; dan 5. mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusi setiap unsur dalam meningkatkan kinerja fasilitas pelayanan kesehatan dan Keselamatan Pasien.

B. Uraian Tugas Ketua Komite Mutu

Tabel 4.2 Uraian Tugas Ketua Komite di Komite Mutu

1	Nama Jabatan	Ketua Komite Mutu
2	Tugas Pokok	Menyelenggarakan kebijakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit

3	Tanggung Jawab	1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit 2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien 3. Bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien kepada Direktur RS Prima Husada 4. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit 5. Bertanggung jawab dalam pemberian informasi yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit 6. Bertanggung jawab terhadap disiplin dan kinerja kerja staf di Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
4	Uraian Tugas	1. Menyusun dan merencanakan pelaksanaan kegiatan program kerja Mutu 2. Memimpin, mengkoordinir, dan mengevaluasi pelaksanaan operasional Mutu secara efektif, efisien dan bermutu 3. Mengumpulkan data indikator baik dari Koordinator Peningkatan Mutu maupun dari Koordinator Keselamatan Pasien RS dan unit kerja terkait 4. Menganalisa data indikator mutu pelayanan baik indikator mutu klinis RS maupun indikator mutu manajerial RS serta indikator keselamatan pasien 5. Mengevaluasi pelaksanaan 5 (lima) area prioritas yang sudah ditetapkan oleh Direktur dengan fokus utama pada penggunaan PPK, clinical pathway dan indikator mutu kunci 6. Melaksanakan analisis terhadap data yang dikumpulkan dan diubah menjadi informasi 7. Melakukan validasi data Mutu secara internal dan dilakukan secara periodik 8. Menyebarkan informasi tentang peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara regular melalui rapat staf 9. Meningkatkan pengetahuan anggota dengan memberikan pelatihan terhadap staf yang ikut serta dalam program Mutu

5	Wewenang	1. Memerintahkan dan menugaskan staf dalam melaksanakan Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 2. Meminta laporan pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dari unit kerja terkait 3. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan RS Prima Husada terkait pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien 4. Memberikan pengarahan dalam hal penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien 5. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien dari unit-unit kerja di lingkungan RS Prima Husada
6	Persyaratan Jabatan	Mengikuti pelatihan eksternal peningkatan mutu dan keselamatan pasien

C. Uraian Tugas Sekretaris Komite Mutu

Tabel 4.3 Uraian Tugas Sekretaris di Komite Mutu

1	Nama Jabatan	Sekretaris Komite
2	Tugas Pokok	Menyelenggarakan tugas-tugas administrasi sekretariat komite mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.
3	Tanggung Jawab	1. Bertanggung jawab terhadap kegiatan administratif di Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien 3. Bertanggung jawab melaporkan hasil kegiatan administratif kepada Ketua Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
4	Uraian Tugas	1. Mengatur rapat dan jadwal rapat Komite Mutu 2. Menyiapkan ruang rapat dan perlengkapan yang diperlukan 3. Membantu meminta laporan indikator kepada unit kerja terkait 4. Menganalisis data Mutu bersama ketua dan anggota Komite Mutu 5. Mendokumentasikan hasil pencapaian indikator area klinis, manajerial dan indikator sasaran keselamatan pasien 6. Menjadi notulen di setiap kegiatan pertemuan Komite Mutu 7. Mengorganisir kebutuhan logistik Komite Mutu 8. Membantu berkoordinasi dalam kegiatan internal dan eksternal Komite Mutu 9. Mengerjakan tugas – tugas administratif dan kesekretariatan lainnya

5	Wewenang	1. Meminta laporan pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dari unit kerja terkait 2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan RS Prima Husada terkait pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien 3. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien dari unit-unit kerja di lingkungan RS Prima Husada 4. Melakukan komunikasi internal dan eksternal kepada unit kerja di lingkungan RS Prima Husada dan pihak luar melalui surat tertulis, email, dan telepon
6	Persyaratan	Mengikuti pelatihan eksternal peningkatan mutu dan keselamatan pasien

D. Uraian Tugas Tim Adhoc Komite Mutu

Tabel 4.4 Uraian Tugas Tim Adhoc di Komite Mutu

1	Nama Jabatan	PIC Data Unit
2	Tanggung Jawab	1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di unit rumah sakit 2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien di unit rumah sakit
2	Tanggung Jawab	3. Bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien kepada komite Mutu 4. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi yang berhubungan dengan mutu dan keselamatan pasien di unit
3	Uraian Tugas	1. Mengumpulkan data indikator baik dari Koordinator Peningkatan Mutu maupun dari Koordinator Keselamatan Pasien RS dan unit kerja terkait 2. Menganalisa data indikator mutu pelayanan baik indikator mutu klinis RS maupun indikator mutu manajerial RS serta indikator keselamatan pasien 3. Melakukan validasi data Mutu secara internal dan dilakukan secara periodik 4. Meningkatkan pengetahuan anggota dengan memberikan pelatihan terhadap staf yang ikut serta dalam program Mutu
4	Wewenang	1. Membuat laporan pelaksanaan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien dari unit kerja 2. Melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut rekomendasi dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien

5	Persyaratan	Mengikuti pelatihan internal peningkatan mutu dan keselamatan pasien
---	-------------	--

E. Uraian Tugas Kordinator Sub Komite Mutu

Tabel 4.5 Uraian Tugas Kooordinator Sub Komite Mutu di Komite Mutu

1	Nama Jabatan	Koordinator Sub Komite Mutu
2	Tanggung Jawab	1. Bertanggung jawab terhadap pemantauan Program Indikator Mutu dan pelaksanaan clinical pathway 2. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan pemantauan indikator mutu dan pelaksanaan clinical pathway di Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan inovasi mutu dan pelaksanaan clinical pathway dan Manajemen resiko di rumah sakit 4. Bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan indikator mutu dan pelaksanaan clinical pathway serta kegiatan-kegiatan mutu lainnya kepada Ketua Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 5. Bertanggung jawab terhadap pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan mutu dan pelaksanaan <i>clinical pathway</i> rumah sakit 6. Bertanggung jawab terhadap pemantauan indikator mutu unit kerja 7. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan pemantauan mutu unit kerja 8. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan mutu rumah sakit 9. Bertanggung jawab dalam pemberian informasi yang berhubungan dengan kegiatan mutu rumah sakit
3	Uraian Tugas	1. Membuat program kerja mutu RS, 2. Melaksanakan kegiatan program peningkatan mutu 3. Menyusun panduan indikator mutu 4. Membuat metode pemantauan indikator mutu klinis dan manajerial 5. Menyusun formulir pemantauan indikator mutu 6. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam penyelenggaraan pemantauan indikator mutu dan pelaksanaan clinical pathway 7. Menganalisa hasil pencapaian indikator mutu 8. Membuat laporan periodik hasil pemantauan indikator mutu 9. Melakukan perbandingan hasil pemantauan indikator mutu secara periodik dengan standar nasional serta rumah sakit lain yang sejenis 10. Melaksanakan komunikasi secara internal dan eksternal tentang pencapaian mutu dan pelaksanaan clinical pathway kepada unit kerja

		di lingkungan dan pihak luar melalui surat tertulis, email dan telepon 11. Membantu berkoordinasi dalam kegiatan internal dan eksternal program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 12. Menyusun panduan pelaksanaan validasi data internal khusus indikator mutu 13. Membuat alat ukur validasi khusus indikator mutu 14. Menyelenggarakan kegiatan validasi hasil pencapaian indikator mutu berkoordinasi dengan unit terkait 15. Melaksanakan analisis komparatif hasil validasi internal dengan data unit terkait 16. Membuat laporan hasil validasi internal khusus indikator mutu 17. Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Perencanaan dan Informasi dalam mengunggah hasil pencapaian indikator mutu yang telah dinyatakan valid dan direkomendasi oleh Direktur 18. Sebagai motor penggerak penyusunan program mutu rumah sakit; 19. Melakukan monitoring dan memandu penerapan program mutu di unit kerja; 20. Membantu dan melakukan koordinasi dengan pimpinan unit pelayanan dalam memilih 21. Prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian Indikator 22. Melakukan koordinasi dan pengorganisasian pemilihan prioritas program di tingkat unit 23. Kerja serta menggabungkan menjadi prioritas rumah sakit secara keseluruhan. Prioritas 24. Program rumah sakit ini harus terkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaanya; 25. Menentukan profil indikator mutu, metode analisis, dan validasi data dari data indikator mutu yang dikumpulkan dari seluruh unit kerja di Rumah Sakit 26. Membuat laporan hasil kegiatan pemantauan mutu RS kepada ketua
4	Wewenang	1. Meminta laporan pelaksanaan pemantauan program indikator mutu penjaminan mutu dan pelaksanaan <i>clinical pathways</i> dari unit kerja terkait 2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan RS Prima Husada terkait pelaksanaan pemantauan indikator mutu serta pelaksanaan <i>clinical pathway</i> dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan mutu rumah sakit 3. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan mutu dan pelaksanaan clinical pathway rumah sakit dari unit-unit kerja di lingkungan RS

		Prima Husada
5	Persyaratan	Mengikuti pelatihan eksternal peningkatan mutu RS dan keselamatan pasien

F. Uraian Tugas Kordinator Sub Komite Keselamatan Pasien

Tabel 4.6 Uraian Tugas Kooordinator Sub Komite Keselamatan Pasien di Komite Mutu

1	Nama Jabatan	Koordinator Sub Komite Keselamatan Pasien
2	Tanggung Jawab	1. Bertanggung jawab terhadap pemantauan Program Keselamatan Pasien 2. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan pemantauan indikator Keselamatan Pasien di Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 3. Bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan program Keselamatan Pasien dan kegiatan-kegiatan mutu lainnya kepada Ketua Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 4. Bertanggung jawab terhadap pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan keselamatan pasien rumah sakit 5. Bertanggung jawab dalam pemberian informasi yang berhubungan dengan kegiatan keselamatan pasien rumah sakit

3	Uraian Tugas	1. Memberi masukan pada Direktur penyusunan Kebijakan Keselamatan Pasien RS sesuai dengan standar akreditasi 2. Penyiapan draft kebijakan, pedoman, dan program kerja terkait keselamatan pasien di Rumah Sakit. 3. Menyusun program keselamatan pasien di RS 4. Menyusun indikator keselamatan pasien RS 5. Menyelenggarakan dan menyiapkan kegiatan sosialisasi internal rumah sakit tentang pencapaian indikator keselamatan pasien 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program melalui pertemuan berkala 7. Menganalisa hasil pencapaian indikator keselamatan pasien 8. Mendesiminasikan bahan rekomendasi hasil pemantauan indikator keselamatan pasien 9. Mengkoordinasikan pendokumentasian, evaluasi dan upaya tindak lanjut atas Kejadian Nyaris Cedera (KNC) / Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan Kejadian Sentinel 10. Melaksanakan koordinasi antar unit bila terjadi KTD dan KNC 11. Melakukan koordinasi tentang program Patient Safety dan manajemen resiko dengan unit terkait dalam pembuatan RCA dan FMEA 12. Membuat laporan periodik hasil pemantauan indikator keselamatan pasien 13. Membuat laporan tahunan / laporan pelaksanaan program setahun.
4	Wewenang	1. Mengusulkan konsep atau perubahan kebijakan keselamatan pasien 2. Meminta laporan pelaksanaan pemantauan indikator mutu keselamatan pasien dan penjaminan mutu dari unit kerja terkait 3. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan RS Prima Husada terkait pelaksanaan pemantauan indikator keselamatan pasien dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan keselamatan pasien 4. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan keselamatan pasien rumah sakit dari unit-unit kerja di lingkungan RS Prima Husada
5	Persyaratan Jabatan	Mengikuti pelatihan eksternal peningkatan mutu dan keselamatan pasien

G.Uraian Tugas Kordinator Sub Komite Manajemen Resiko

Tabel 4.6 Uraian Tugas Kooordinator Sub Komite Manajemen Resiko di Komite Mutu

1	Nama Jabatan	Koordinator Sub Manajemen Resiko
2	Tanggung Jawab	1. Terlaksananya program manajemen risiko rumah sakit 2. Terpenuhinya prosedur – prosedur pelaksanaan dan layanan yang menjamin pelaksanaan risiko di rumah sakit 3. Terkendalinya kondisi – kondisi yang berpotensi membahayakan pasien, staf, maupun pengunjung serta mendukung pelaksanaan manajemen risiko dirumah sakit 4. Terjaganya komitmen karyawan terhadap manajemen risiko di rumah sakit
3	Uraian Tugas	1. Menyiapkan draft kebijakan, pedoman dan program kerja terkait manajemen risiko Rumah Sakit; 2. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit terkait manajemen risiko di Rumah Sakit; 3. Membuat pedoman kerja, program kerja manajemen risiko di Rumah Sakit; 4. Menyelenggarakan dan menyiapkan kegiatan sosialisasi internal rumah sakit tentang manajemen risiko di RS 5. Memantau dan memandu penerapan manajemen risiko di tiap unit kerja; 6. Memberikan usulan atas profil risiko dan rencana penanganannya; 7. Melaksanakan dan pelaporan rencana penanganan risiko sesuai lingkup tugasnya; 8. Memberikan usulan rencana kontingensi apabila kondisi yang tidak normal terjadi; 9. Melaksanaan penanganan risiko tinggi; 10. Melaksanaan simulasi secara berkala mengenai manajemen risiko; dan 11. Melakukan pendidikan / edukasi staf tentang manajemen risiko rumah sakit 12. Penyusunan laporan pelaksanaan program manajemen risiko. 13. Melakukan monitoring perencanaan risk manajemen 14. Melakukan monitoring pelaksanaan program 15. Monitoring insiden/kecelakaan karena fasilitas 16. Melakukan evaluasi dan revisi program manajemen risiko secara berkala 17. Memberikan laporan tahunan kepada pemilik RS tentang pencapaian program 18. Melakukan pengorganisasian dan pengelolaan secara konsisten dan terus menerus

4	Wewenang	1. Mengelola tim manajemen risiko Rumah Sakit 2. Meminta laporan pelaksanaan pemantauan risiko dari tiap unit kerja 3. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan RS Prima Husada terkait pelaksanaan pemantauan risiko dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan manajemen risiko 4. Meminta data dan informasi yang berhubungan dengan manajemen risiko rumah sakit dari unit-unit kerja di lingkungan RS Prima Husada 5. Melakukan pengawasan dan melaksanakan manajemen risiko di seluruh unit kerja rumah sakit 6. Memberi masukan dan rekomendasi kepada Direktur rumah sakit dengan tugas kegiatan manajemen risiko
5	Pesyaratan	Mengikuti pelatihan eksternal Manajemen Risiko

BAB V

KEGIATAN PENINGKATAN MUTU

5.1. Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pelaporan Program Mutu

1. Direktur rumah sakit, para pimpinan klinis dan pimpinan manajerial secara bersama – sama menyusun, merencanakan, mengembangkan, serta melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
2. Representasi pemilik memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan persetujuan, dan pengawasan agar rumah sakit mempunyai kepemimpinan yang jelas, dijalankan secara efisien, serta memberikan pelayanan kesehatan dan aman serta menindaklanjuti laporan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
3. Direktur rumah sakit bertanggung jawab untuk memulai dan menyediakan dukungan berkelanjutan dalam hal komitmen rumah sakit terhadap mutu
4. Direktur rumah sakit mengembangkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta mengajukan persetujuan program kepada representasi pemilik dan melalui misi rumah sakit serta dukungan pemilik rumah sakit membentuk suatu budaya mutu di rumah sakit
5. Representasi pemilik bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
6. Direktur rumah sakit memilih pendekatan yang digunakan oleh rumah sakit untuk mengukur, menilai, serta meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Pengukuran mutu dilakukan menggunakan indikator mutu di tingkat rumah sakit dan di tingkat uni pelayanan yang merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
7. Direktur rumah sakit menetapkan bagaimana program peningkatan mutu dan keselamatan pasien diarahkan dan diatur setiap harinya
8. Direktur rumah sakit menetapkan organisasi yang mengelola dan melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
9. Direktur rumah sakit memastikan bahwa program tersebut mempunyai sumber daya termasuk sumber daya tenaga yang cukup agar berjalan efektif
10. Direktur rumah sakit menetapkan suatu struktur dan proses untuk memantau dan melakukan koordinasi menyeluruh terhadap program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Koordinasi ini mendukung pendekatan sistem untuk pemantauan kualitas dan aktivitas perbaikan sehingga mengurangi duplikasi upaya peningkatan mutu

5.2 Pemilihan Indikator Mutu Prioritas Rumah Sakit (IMP-RS)

Setiap tahun Direktur rumah sakit bersama-sama dengan para kepala bidang pelayanan dan manajemen memilih dan menetapkan pengukuran mutu pelayanan klinis prioritas rumah sakit untuk dilakukan evaluasi. Rumah Sakit harus memilih fokus perbaikan, proses serta hasil praktik klinis dan manajemen mengacu pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien, dan jenis pelayanan. Fokus perbaikan praktik klinis melibatkan komite medis dan kelompok staf medis terkait. Pemilihan indikator Prioritas Rumah Sakit ini didasarkan atas masalah yang paling banyak di RS, jumlah yang paling banyak (*High Volume*), proses berisiko tinggi (*High Process*), Ketidakpuasan pasien dan staf, kemudahan dalam pengukuran, ketentuan pemerintah/ persyaratan eksternal, sesuai dengan tujuan strategis RS, memberikan pengalaman pasien lebih baik (*patient experience*). Pengukuran mutu prioritas tersebut dilakukan menggunakan indikator- indikator mutu sebagai berikut:

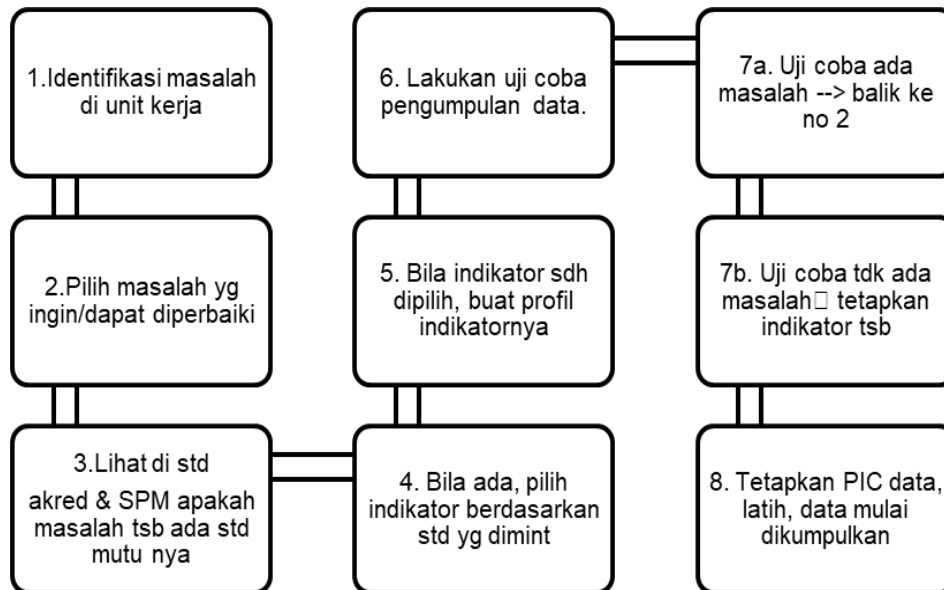
1. Indikator mutu Sasaran Keselamatan Pasien (ISKP)
2. Indikator Pelayanan Klinis Prioritas
3. Indikator sesuai tujuan strategis rumah sakit

4. Indikator terkait perbaikan system
5. Indikator terkair manahemen resiko

Indikator mutu yang sudah dipilih bila sudah tercapai terus menerus selama satu tahun tidak bermanfaat untuk melakukan perbaikan karena sudah tidak ada lagi yang perlu diperbaiki, dengan demikian sebaiknya diganti dengan indikator mutu baru. Proses pengumpulan data unit dilakukan oleh penanggung jawab data unit kemudian dilakukan supervisi berjenjang oleh Komite Mutu beserta Direktur untuk memantau, mengawasi dan mengevaluasi proses kepatuhan pengambilan data mengenai indikator mutu prioritas Rumah Sakit di unit.

5.3 Pemilihan Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP-Unit)

Bagan 5.1
Proses Pemilihan IMP-RS



Setiap unit kerja di rumah sakit memilih dan menetapkan indikator mutu prioritas unit yang digunakan untuk mengukur mutu unit kerja. Pemilihan indikator Mutu Unit Prioritas adalah tanggung jawab dari kepala ruangan di setiap unit, kemudian Komite Mutu akan melakukan koordinasi proses pemilihan indikator mutu di unit kerja tersebut sehingga indikator yang dipilih tersebut *valid*, *reliable*, *sensitive*, dan *spesifik*. Pemilihan indikator mutu prioritas unit harus memperhatikan beberapa dimensi mutu berdasarkan WHO, yakni :

1. *Effective*
2. *Efficient*
3. *Accessible*
4. *Accepted (Patient-Centered)*
5. *Equity and Safe*

Pimpinan unit kerja terlibat langsung dalam pemilihan dan penetapan yang ingin diukur di unit kerja. Indikator mutu unit kerja dapat menggunakan indikator mutu yang tercantum di dalam standar pelayanan minimal. Dalam memilih indikator mutu maka kepala unit kerja dan unit pelayanan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Prioritas pengukuran mutu pelayanan klinis di rumah sakit. Indikator mutu yang dipergunakan untuk mengukur mutu di prioritas pengukuran mutu rumah sakit, sumber data pasti dari unit, dan menjadi indikator mutu unit
2. Fokus mengukur hal-hal yang ingin diperbaiki
3. Melakukan koordinasi dengan komite medis bila evaluasi penerapan panduan

5.4 Pengumpulan Data Indikator Mutu

Pengumpulan data Indikator Mutu adalah proses mengumpulkan data atau menghimpun data berkaitan dengan indikator mutu yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan dari pengukuran indikator. Pengumpulan data dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung jawab terhadap Indikator Mutu. Tahapan pengumpulan data dimulai dengan :

1. Mengidentifikasi sumber data

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung antara lain dari survei harian dan hasil observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan secara tidak langsung antara lain dari catatan pendaftaran, rekam medik, catatan jadwal pelaksanaan operasi, lembar resep, laporan visite rawat inap, laporan hasil laboratorium, hasil survei kepuasan, dan catatan keluhan.

2. Menetapkan sampling

Dalam pengumpulan data, idealnya data dikumpulkan dari seluruh anggota populasi. Namun pada kondisi di mana anggota populasi sangat banyak maka pengumpulan data dilakukan melalui sampling yaitu mengambil sebagian dari anggota populasi yang dipilih dengan teknik sampling agar dapat mewakili populasi. Apabila jumlah anggota populasi tidak terlalu banyak maka digunakan seluruh anggota populasi. Jika pengumpulan data dilakukan pada sampel, maka perlu ditentukan dua aspek yaitu teknik sampling dan besar sampel minimal.

a. Teknik sampling, Berikut adalah beberapa contoh teknik sampling:

- 1) Sampling probabilitas (*Probability sampling*) Dalam teknik sampling ini, setiap subjek dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Beberapa teknik sampling probabilitas antara lain
- 2) Sampel acak sederhana (*simple random sampling*) Dalam teknik ini, subjek dipilih secara acak dari daftar subjek dengan menggunakan undian atau menggunakan tabel angka random. Apabila jumlah anggota populasi dapat diketahui, maka tiap anggota populasi tersebut diberi nomor urut dan dipilih sebagian dari mereka sebagai sampel dengan menggunakan tabel angka random. Contoh: memilih 200 sampel dalam 1000 anggota populasi.
- 3) Sampel acak sistematis (*systematic random sampling*) Teknik ini memilih sampel dari populasi secara acak dengan menggunakan interval yang sama.
- 4) Stratified Random Sampling, Stratified random sampling digunakan apabila populasi bersifat heterogen, yang terdiri atas beberapa subpopulasi yang bersifat homogen. Dalam hal ini perbedaan adalah dalam jumlah anggota subpopulasi. Besarnya subpopulasi dinyatakan dalam persentase terhadap populasi total. Pada masing-masing subpopulasi dilakukan pengambilan sampel secara acak sejumlah persentase dari total sampel yang diperlukan.
- 5) Multistage random sampling, Multistage random sampling dipilih apabila populasi bersifat heterogen dan dijumpai kluster/strata yang sifatnya heterogen kemudian dilakukan pemilihan secara acak kluster/strata yang akan digunakan sebagai sumber data. Sampel yang terpilih merupakan representasi dari masing-masing kluster/strata.
- 6) Cluster random sampling, Cluster random sampling digunakan apabila populasi yang bersifat *one stage* dan terdiri atas kluster-kluster yang bersifat heterogen. Kluster akan dipilih secara acak, kluster yang terpilih mewakili karakteristik populasi.

b. Sampling non probabilitas (Non-probability sampling)

- 1) Consecutive Sampling, Teknik ini memilih calon subjek/sampel berdasarkan kedatangan di tempat penelitian. Calon subjek/sampel yang

memenuhi kriteria inklusi dan tidak ada kriteria eksklusi akan digunakan sebagai sampel. Pengambilan sampel dihentikan apabila jumlah sampel terpenuhi.

- 2) Sampling berdasarkan ketersediaan (*Convenience sampling*). Dalam teknik ini, subjek diambil tanpa sistematika tertentu, pemilihan berdasarkan ketersediaan yang ada pada saat dilakukan pengukuran. Subjek diambil/terpilih sebagai sampel karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat. Teknik ini paling mudah namun validitasnya rendah
- 3) Sampling berdasarkan pertimbangan (*Judgmental sampling* atau *purposive sampling/Trigger sampling*). Teknik ini memilih sampel berdasarkan adanya pertimbangan atau trigger tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) Total sampling Apabila anggota populasi jumlahnya sedikit sesuai dengan kriteria yang digunakan maka seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Misalnya jumlah anggota populasi ≤ 30 maka seluruhnya digunakan sebagai sampel.

c. Besar sampel

Untuk menentukan besar sampel minimal, faktor yang harus dipertimbangkan adalah jumlah anggota populasi, namun selain itu semakin banyak variasi dalam populasi, maka semakin banyak besar sampel yang diperlukan.

- 1) Perhitungan besar sampel berdasarkan rumus slovin

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah
sampel minimal
N = Jumlah populasi

e = *margin of error* (biasanya ditetapkan sebesar 0.05)

Contoh :

Sehingga :

n =

$$n = \frac{1000}{1 + \frac{1000 \times 0.05^2}{2}}$$

$$n = \frac{1000}{1 + \frac{1000 \times 0.025}{2}}$$

$$n = \frac{1000}{1 + 2.5}$$

$$n = \frac{1000}{3.5}$$

$n = 285.7143$

Apabila dibulatkan maka besar sampel minimal dari 1000 populasi pada *margin of error* 5% adalah sebesar 286

2) Perhitungan besar sampel berdasarkan table Krejcie dan Morgan.

Tabel 5.1 Tabel Sampel Krejcie dan Morgan

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	230	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367
130	97	650	242	9000	368
140	103	700	248	10000	370
150	108	750	254	15000	375
160	113	800	260	20000	377
170	118	850	265	30000	379
180	123	900	269	40000	380
190	127	950	274	50000	381
200	132	1000	278	75000	382
210	136	1100	285	100000	384

2. Frekuensi pengumpulan data
- Frekuensi pengumpulan data dilaksanakan sesuai dengan profil Indikator Mutu yang terdapat pada kamus indikator.
3. Instrumen pengumpulan data
- Dalam melakukan pengumpulan data diperlukan alat bantu instrumen yang dapat berupa formulir observasi, formulir pengumpulan data dan lain sebagainya
4. Elemen data
- Dalam mengumpulkan data perlu memahami elemen data yang ingin diukur. Elemen data terdiri atas :
- a. Numerator adalah data yang akan diukur. Sehingga dalam pengukuran menjawab pertanyaan: "Apa yang akan saya amati?"
 - b. Denominator adalah data yang menggambarkan semua peluang yang ingin diobservasi dalam populasi atau sampel yang akan diukur. Sehingga dalam pengukuran menjawab pertanyaan: "Siapa yang harus saya perbaiki?"
- Pengumpulan data merupakan salah satu kegiatan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di RS Prima Husada, hal ini menjadi bagian penting dari penilaian kinerja untuk mendukung asuhan pasien dan manajemen yang lebih baik. Pengumpulan data indikator mutu dilakukan oleh setiap Penanggung jawab data unit / PIC data Unit dengan frekuensi pengumpulan data harian atau bulanan, pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi terhadap *input*, *proses*, *outcome* dan *proses & outcome* dari pelayanan kesehatan yang dijadikan sebagai indikaor mutu di masing-masing unit. Observasi dilakukan oleh PIC Data Unit kepada seluruh staff di unit sesuai dengan jumlah sampel yang sudah di tentukan.

5.5 Analisis Data Indikator Mutu

Setelah penanggung jawab data unit melakukan pengambilan data di unit, langkah selanjutnya yang dilakukan yakni melakukan analisis data yang sudah dikumpulkan. Analisis data adalah suatu proses atau upaya untuk menggabungkan dan mengubah data menjadi informasi yang dapat dipahami dan berguna dalam membuat kesimpulan atau membuat keputusan. Unit yang bertanggung jawab, dapat dibantu oleh Komite/tim mutu untuk melakukan analisis data tersebut. Analisis data dilakukan agar dapat menyediakan informasi yang berguna, selain itu analisis data capaian juga digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien. Kegiatan yang dilakukan saat analisis data meliputi :

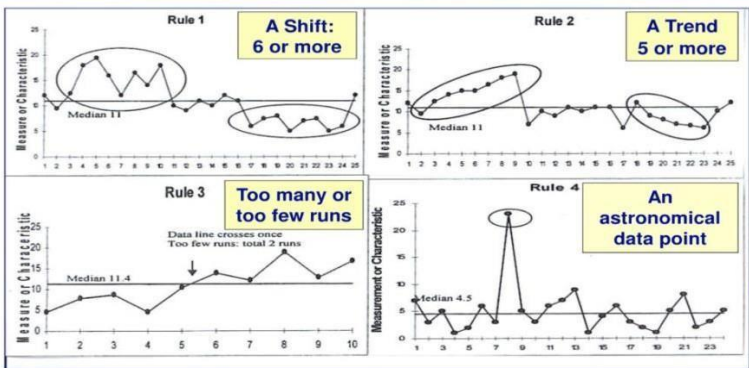
1. Penanggung jawab data unit menggabungkan perolehan data dalam satu bulan.
2. Data yang sudah terkumpul dilakukan analisis dengan melibatkan kepala ruangan & petugas yang ada yang di unit.
3. Setelah dilakukan analisis data di ubah menjadi informasi yang berguna untuk mencapai simpulan dan membuat keputusan
4. Hasil informasi dari analisis data, di presentasikan oleh penanggung jawab data unit kepada Komite Mutu dengan melibatkan para kepala bidang dan dilakukan analisis secara mendalam.
5. Dalam menganalisis data, personil Komite MUTU harus memahami manajemen informasi, mempunyai keterampilan dalam pengumpulan data, dan mengetahui cara menggunakan alat statistik sederhana dilibatkan. Begitupula dengan pimpinan lainnya yang terlibat dalam proses analisis data.
6. Hasil dari analisis data dilaporkan kepada Direktur dan diberikan kembali feedbacknya kepada pimpinan yang bertanggung jawab akan proses atau hasil yang diukur dan mampu menindaklanjuti untuk memperbaiki / meningkatkan proses klinis serta manajerial.
7. Data dibandingkan sesuai dengan tujuan analisis data. Perbandingan tersebut membantu rumah sakit dalam memahami perubahan dan penyebab perubahan yang tidak diinginkan serta membantu memfokuskan upaya perbaikan. Dalam perbandingan data dapat dilakukan melalui :
 - a. Membandingkan dengan data capaian di bulan sebelumnya, untuk mengetahui perbaikan atau perburukan capaian. Hal ini biasanya dilakukan, satu bulan sekali.
 - b. Membandingkan dengan rumah sakit sejenis seperti melalui database referensi. Hal ini dilakukan dalam jangka waktu triwulan.
 - c. Dengan standar-standar seperti yang ditentukan oleh badan akreditasi atau organisasi profesional ataupun standar-standar yang ditentukan oleh Undang-Undang atau peraturan.
 - d. Dengan praktik-praktik yang diinginkan yang dalam literature digolongkan sebagai *best practice* (praktik terbaik) atau *better practice* (praktik yang lebih baik) atau *practice guidelines* (panduan praktik klinis).
5. Analisis data dilakukan bulan, dan setiap triwulan dengan menggunakan metode PDSA (form PDSA tertera pada lampiran pedoman ini) (jika tidak tercapai sekurang - kurangnya 3x pengukuran) disertakan grafik untuk menggambarkan pencapaiannya. Analisis ini dilakukan oleh Komite MUTU
6. Data yang dianalisis adalah semua data yang terkait dengan pencapaian program Mutu yang menjadi prioritas untuk diukur dan berdampak terhadap peningkatan mutu serta efisiensi biaya pertahun.
7. Komite Mutu dengan Kepala Bidang akan melakukan koordinasi dengan Komite Medik terkait dengan audit medis, bagian keuangan rumah sakit, dan teknologi informasi rumah sakit khususnya untuk *billing system* sehingga dapat diketahui telah terjadi kendali biaya

5.6 Penyajian Data Indikator Mutu

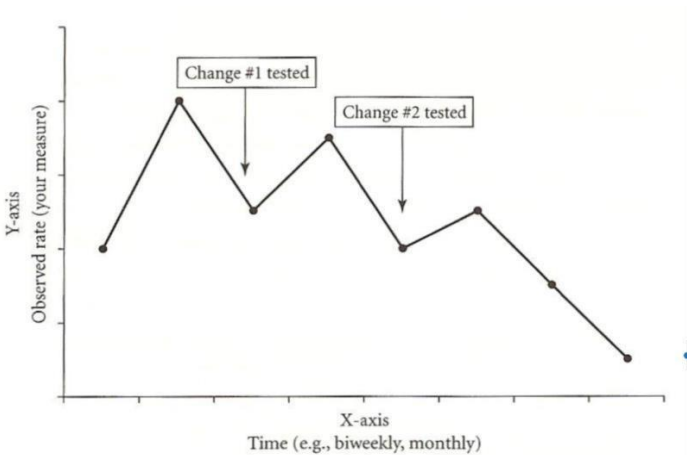
Setelah dilakukan analisis, data akan disajikan menjadi informasi untuk mempermudah pembaca memahami hasilnya. Data juga perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti, untuk memudahkan interpretasi hasil pengukuran indikator mutu. Secara garis besar ada tiga cara yang sering dipakai untuk penyajian data yaitu :

- 1. Narasi
 - Ciri dari penyajian secara tulisan adalah
 - a. Dibuat dalam bentuk narasi mulai dari pengambilan data hingga kesimpulan.
 - b. Kelemahan: kurang menggambarkan bentuk statistik bila terlalu banyak datanya.
- 2. Tabel
 - Penyajian data dalam bentuk angka yang disusun dalam kolom dan baris dengan tujuan untuk menunjukkan frekuensi kejadian dalam kategori yang berbeda.
- 3. Diagram
 - Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menggunakan beberapa jenis diagram untuk membantu analisis. Ketepatan pemilihan alat tergantung pada sifat data. Beberapa alat yang paling umum digunakan:
 - a. Diagram Run Chart

Non-Random Rules for Run Charts



Source: The Data Guide by L. Provost and S. Murray, Jossey-Bass Publishers, 2011.



Gambar 5.1 Contoh Diagram Run Chart

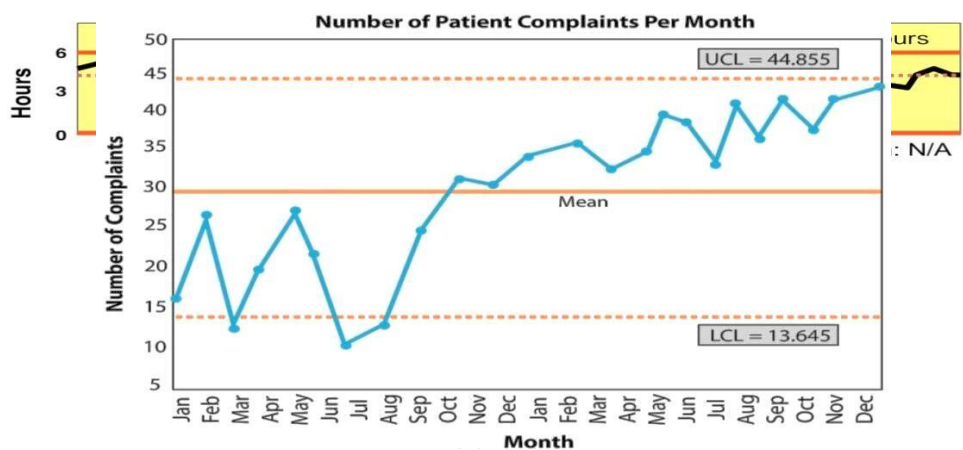
Diagram run chart digunakan untuk mengevaluasi data dari waktu ke waktu. Diagram run chart dapat menunjukkan:

- 1) Gambaran umum sebuah proses
- 2) Garis yang menunjukkan nilai sepanjang waktu
- 3) Trend naik dan turun

Diagram run chart dapat mendeteksi:

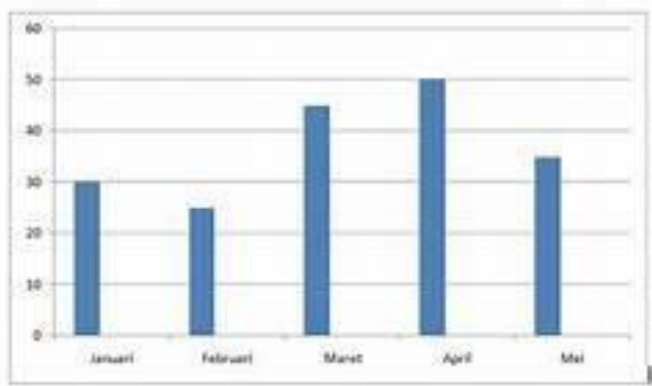
- 1) Pergeseran atau Shifts adalah jika 8 titik atau lebih berturut-turut jatuh pada satu sisi dari garis tengah. Titik pada garis rata-rata tidak masuk

- hitungan.
- 2) Tren atau Trend adalah jika 6 titik atau lebih berturut-turut bergerak ke arah yang sama. Titik garis datar tidak termasuk dalam hitungan.
 - 3) Zigzag adalah jika 14 titik atau lebih turun naik.
- b. Diagram kontrol atau Control Chart



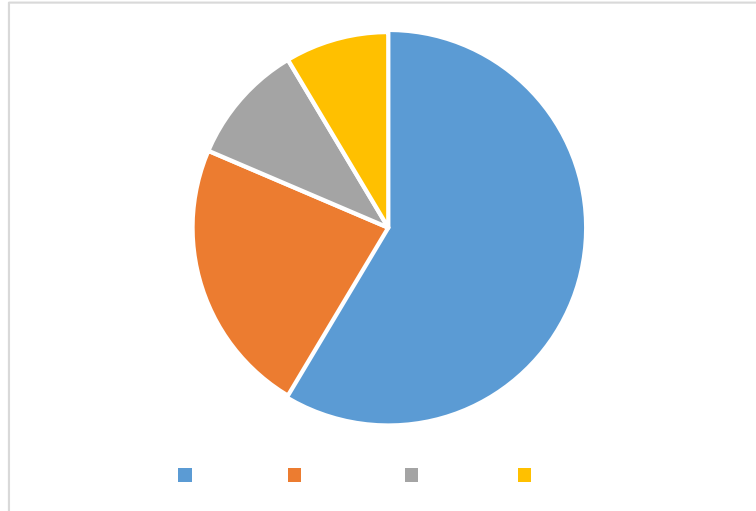
Gambar 5.2 Contoh diagram Control Chart

- Diagram kontrol ini digunakan untuk menilai stabilitas suatu proses melalui analisis variasi kinerja dari waktu ke waktu. Diagram kontrol lebih spesifik daripada diagram run chart karena dapat menilai apakah proses berada dalam kontrol atau terkendali dengan adanya garis kontrol atas (Upper control limit/ UCL) dan garis kontrol bawah (Lower control limit /LCL).
- c. Diagram batang atau Bar chart



Gambar 5.3 Contoh diagram batang

- Diagram batang sangat membantu saat data terdiri dari kategori yang berbeda. Sumbu x mendefinisikan suatu variabel dan sumbu y mendefinisikan suatu karakteristik misalnya frekuensi atau persentase. Diagram batang dimanfaatkan untuk membandingkan hasil pengukuran dari dua sampel atau populasi yang berbeda.
- d. Pie chart



Gambar 5.4 Contoh pie chart

Pie chart merupakan lingkaran yang dibagi-bagi berdasarkan proporsi subpopulasi data yang diperoleh. Pie chart menunjukkan proporsi subpopulasi dalam sebuah populasi

Setelah disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami (narasi, tabel dan grafik), informasi tersebut perlu dilakukan analisis. Analisis dapat dilakukan dengan cara:

1. Pencapaian dibandingkan secara serial (dari waktu ke waktu) Pencapaian indikator dibandingkan antara periode berjalan dengan periode sebelumnya/berikutnya sehingga dapat diketahui adanya kesenjangan/kenaikan maupun penurunan capaian kinerja, analisis dilakukan dengan cara melihat trend.
2. Pencapaian dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.
3. Pencapaian dibandingkan dengan pencapaian Rumah Sakit sejenisnya Pencapaian indikator dibandingkan dengan pencapaian Rumah Sakit Lain lainnya sebagai bentuk benchmark. Perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan pencapaian dengan trend pencapaian. Trend pencapaian dikatakan bagus bila grafik menunjukkan peningkatan yang lebih baik daripada trend peningkatan lain.
4. Pencapaian dibandingkan dengan standar dan referensi yang digolongkan sebagai best practice/better practice maupun practice guidelines.

5.7 Pelaporan dan Komunikasi Capaian Indikator Mutu

Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan dan mengkomunikasikan hasil capaian Indikator Mutu secara berkala. Pelaporan dan komunikasi tersebut diperlukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengambilan keputusan untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Kegiatan ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti karena kesalahan dalam pelaporan akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Penyampaian hasil pencapaian Indikator Mutu dikomunikasikan kepada seluruh stake holder terkait. Penyampaian hasil dilakukan secara berkala sesuai profil Indikator Mutu. Mekanisme pelaporan dan komunikasi Indikator Mutu dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi, namun dalam hal kondisi tidak dapat mengakses aplikasi, mekanisme pelaporan dan komunikasi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelaporan Internal
 - a. Bulanan
 - 1) Laporan dari unit pelayanan ke Komite/Tim Mutu.
 - 2) Laporan Komite/Tim Mutu ke Direktur Rumah sakit
 - b. Triwulan

Laporan Direktur Rumah Sakit ke Dewan Pengawas RS atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/ Provinsi.
 - c. Pelaporan Eksternal

- Rumah Sakit melaporkan hasil pengukuran indikator mutu kepada Kementerian Kesehatan secara berkala sesuai dengan profil indikator melalui aplikasi web-based (<http://mutufasyankes.kemkes.go.id>).
2. Hasil analisis akan dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit
 3. Direktur rumah sakit mengukur keberhasilan program Mutu prioritas melalui :
 - a. Pengukuran capaian-capaian indikator area klinis dan area manajemen
 - b. Pengukuran kepatuhan penerapan sasaran keselamatan pasien
 - c. Pengukuran kepatuhan pelaksanaan PPK-CP sehingga mengurangi variasi dalam pemberian pelayanan
 - d. Pengukuran penggunaan sumber daya termasuk biaya yang dipergunakan untuk perbaikan di program prioritas rumah sakit
 4. Sehingga melalui pengukuran-pengukuran tersebut di atas dapat diketahui dampak perbaikan di rumah sakit secara keseluruhan termasuk efisiensi penggunaan sumber daya.

5.6 Validasi data Indikator Mutu

Setelah hasil pengukuran di analisis dan dilaporkan kepada Direktur Rumah Sakit, selanjutnya data akan di validasi kebenarannya, untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan baik dan valid. Validasi data dilakukan setiap triwulan, dengan penanggung jawab adalah Komite Mutu. Direktur Rumah Sakit menetapkan regulasi validasi data indikator mutu yang baru atau mengalami perubahan profil indikator/ pergantian PIC unit, data yang akan di publikasikan dan melakukan perbaikan berdasarkan hasil validasi data. Regulasi validasi data yang ditetapkan Rumah Sakit meliputi :

1. Pengukuran Indikator mutu baru
2. Bila data akan dipublikasi ke masyarakat baik melalui website rumah sakit atau media lain
3. Ada perubahan pada pengukuran yang selama ini sudah dilakukan, misalnya perubahan profil indikator, instrumen pengumpulan data, proses agregasi data, atau perubahan staf pengumpul data atau validator
4. Bila terdapat perubahan hasil pengukuran tanpa diketahui sebabnya
5. Bila terdapat perubahan sumber data, misalnya terdapat perubahan sistem pencatatan pasien dari manual ke elektronik
6. Bila terdapat perubahan subyek data seperti perubahan umur rata rata pasien, perubahan protokol riset, panduan praktik klinik baru diberlakukan, serta adanya teknologi dan metodologi pengobatan baru.
7. Bila data akan dilaporkan ke Direktur dan Dewan pengawas secara regular setiap 3 (tiga) bulan.

Salah satu jenis validasi yang merekomendasikan adalah metode *reproducibility* yaitu diulangnya pengukuran oleh orang yang berbeda, menggunakan formulir/checklist/alat yang sama dan dilakukan kondisi yang sama dan pada populasi/sampel yang sama. Berikut adalah langkah-langkah uji validasi data dengan menggunakan metode kesesuaian hasil pengukuran (*Measure Result Agreement*) :

1. Pengumpulan data
Pengumpulan data dilakukan oleh petugas pengumpul data dengan cara mengumpulkan data dari Populasi atau Sampel dari sumber data, dengan panduan Profil Indikator dan menggunakan Formulir Pengumpulan data yang telah disiapkan. Besar sampel dapat dilihat pada Tabel dibawah ini, Penentuan Besar Sampel Validasi untuk Petugas Pengumpul Data.
2. Validasi Data
Validasi data dilakukan oleh petugas validasi data dengan cara mengumpulkan data secara acak/random sampel yang akan diukur dari seluruh populasi atau sampel sumber data yang sama yang digunakan oleh pengumpul data, dengan panduan kamus, dan formulir pengumpulan data yang sama dengan yang digunakan oleh pengumpul data. Besar sampel dapat dilihat pada Tabel 5.2 Penentuan Besar Sampel untuk Petugas Validasi. Petugas validasi data tidak

perlu mengumpulkan semua data yang dikumpulkan pengumpul data.

Tabel 5.2 Pengukuran Sampel Validasi Data Indikator Mutu

Petugas Pengumpul Data		Petugas Validasi Data	
Populasi	Sampel	Populasi	Sampel
≥640	128 sampel	≥480	48 populasi
320-639	20% dari total populasi	161-480	48 sampel sampel
64-319	64 sampel	17-160	Min 16 / 10%
<64	100% populasi	1-16	100% populasi

- a. Hitung kesesuaian antara hasil petugas pengumpul data dan petugas validasi data. Jumlah Kesesuaian Data dibagi Jumlah Sampel x 100%.
- Jumlah kesesuaian data

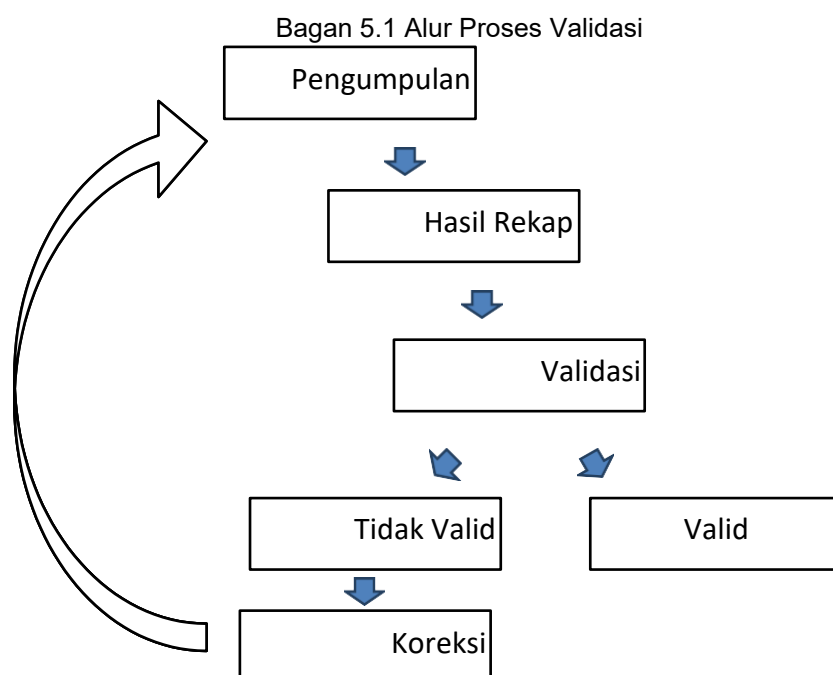
.

=

Jumlah sampel

x 100%

- Kesesuaian hasil pengukuran dapat dipercaya atau valid jika mencapai 90%
- b. Hasil penghitungan validitas tersebut terdapat dua kemungkinan antara lain:
 - 1) Jika mencapai 90% maka hasil pengukuran dapat dipercaya atau valid.
 - 2) Jika hasilnya $< 90\%$ dan terdapat perbedaan atau ketidakcocokan, maka pengumpul data dan validator mencari penyebab perbedaan data dan melakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, kemudian dilakukan pengumpulan data ulang menggunakan sampel baru dan langkah-langkah yang sama sejak awal
 3. Faktor-faktor penyebab data tidak valid adalah sebagai berikut :
 - a. Pemahaman pengumpul data dan petugas validasi data belum memadai.
 - b. Kamus indikator tidak jelas sehingga menimbulkan salah interpretasi.
 - c. Perbedaan pemahaman tentang definisi operasional.
 - d. Keterbatasan waktu pengumpulan data.
 - e. Kesalahan dalam melakukan penginputan data.
 - f. Penggunaan sumber data yang berbeda.
 - g. Kelalaian.
 - h. Formulir pengumpulan data belum terdesain dengan baik.
 4. Untuk mengurangi kesalahan, meningkatkan validitas mengurangi *random error* dalam pengumpulan data, dapat dilakukan berbagai upaya antara lain :
 - a. Standarisasi pengukuran (menggunakan definisi operasional yang sama, menggunakan elemen data yang sama).
 - b. Pelatihan pengumpul data dan validator (dilatih dengan cara yang sama seperti pengumpul data).
 - c. Standarisasi instrumen/alat ukur (menggunakan instrumen/alat yang sama misalnya form atau kuesioner).
 - d. Mengulang pengukuran (mengumpulkan data ulang oleh orang yang berbeda dengan sampel yang sama).
 5. Proses validasi data yang akan dipublikasi di web site atau media lainnya agar diatur tersendiri, dan dapat menjamin kerahasiaan pasien dan keakuratan data (jelas definisinya) dan dilakukan tindakan koreksi
 - a. Proses validasi data mencakup namun tidak terbatas pada
 - b. tersebut diatas, oleh karena itu, dalam melakukan validasi data, rumah sakit dapat menggunakan cara/proses lain sesuai dengan referensi ilmiah terkini.
 - c. Proses validasi data yang akan di publikasi diatur tersendiri dan dapat menjamin kerahasiaan pasien dan keakuratan data.



BAB VI SISTEM MANAJEMEN DATA

6.1 Sistem Manajemen Data Mutu

Rumah sakit menyediakan teknologi dan dukungan lainnya untuk mendukung sistem manajemen data pengukuran mutu terintegrasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Pengukuran fungsi klinis dan fungsi manajemen di rumah sakit akan menghasilkan akumulasi data serta informasi. Untuk memahami seberapa baik kemampuan rumah sakit bergantung pada hasil analisis data dan informasi yang terkumpul dibanding dengan rumah sakit lain. Pada rumah sakit besar dan kompleks sifatnya dibutuhkan teknologi dan/atau staf yang mempunyai kompetensi mengelola data. Rumah sakit memahami prioritas pengukuran dan perbaikan sebagai dukungan yang penting. Rumah sakit mempunyai regulasi sistem manajemen data, antara lain meliputi:

1. rumah sakit perlu mempunyai sistem manajemen data yang didukung dengan teknologi informasi yang mulai dari pengumpulan, pelaporan, analisis, validasi, serta publikasi data untuk internal rumah sakit dan eksternal rumah sakit. Publikasi data tetap harus memperhatikan kerahasiaan pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. data yang dimaksud meliputi data dari indikator mutu unit dan indikator mutu prioritas rumah sakit
3. data dari pelaporan insiden keselamatan pasien
4. data hasil monitoring kinerja staf klinis (bila monitoring kinerja menggunakan indikator mutu)
5. data hasil pengukuran budaya keselamatan
6. integrasi seluruh data di atas baik di tingkat rumah sakit dan unit kerja meliputi:
 - a. pengumpulan,
 - b. pelaporan,
 - c. analisis.
 - d. validasi, dan
 - e. publikasi indikator mutu.
7. Rumah sakit seyogianya mempunyai sistem manajemen data secara elektronik sehingga memudahkan Komite MUTU dalam mengelola data tersebut.
8. Rumah sakit memiliki peraturan yang mengatur tentang keamanan dan kerahasiaan saat berkontribusi pada *database* eksternal, yang diatur dalam peraturan tersendiri

6.2 Alur SIMRS Pengendali Mutu

1. Lakukan **login ke SIMRS** dengan menggunakan user name & password sesuai dengan akun SIMR Mutu yang dimiliki oleh PIC mutu unit.

 SIMRS Login





Selamat datang di aplikasi SIMRS

■ Qualified Medical Services

■ Only Best Professionals Treat Our I

Silahkan masukkan User Name dan Password untuk masuk ke dalam aplikasi

Login Info

User Name :

Password :

Login

Alifia.d

1234

Copyright© 2016 DIMESTA

2. Setelah berhasil login pada menu **Pengendali Mutu**, klik pada menu **Transaksi**. Lakukan **input data** hasil observasi sesuai judul indikator (Kejadian / angka / dll) dengan pilihan jenis pengukuran sebagai berikut :
 - a. Parameter : merupakan indikator yang memiliki persyaratan kelengkapan saat melakukan observasi / pengambilan data. Namun jenis transaksi parameter ini jarang digunakan pada indikator di unit.

Contoh indikator yang menggunakan jenis pengukuran parameter :

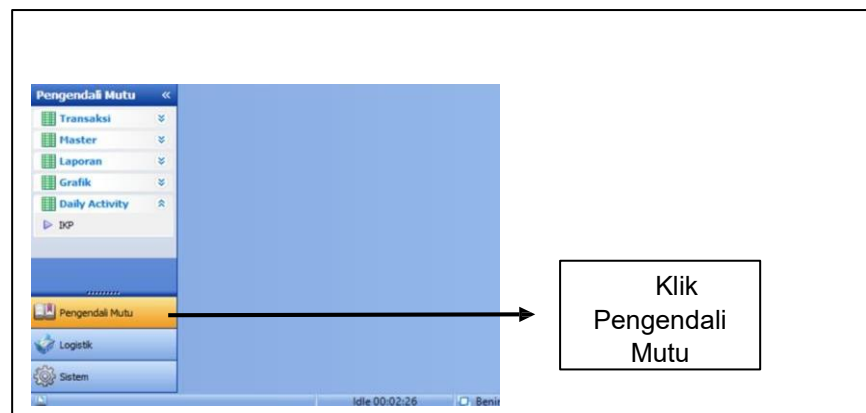
- 1) Ketidakpatuhan petugas dalam melengkapi SBAR
- 2) Ketidakpatuhan pengisian rekam medis pasien KRS ≥ 24 Jam

- b. Insiden / Kejadian : merupakan indikator yang ketidakpatuhannya tidak dapat di toleransi.

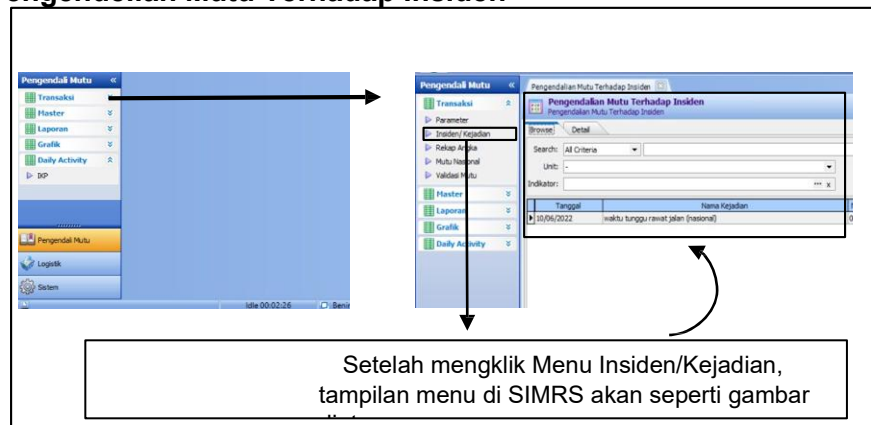
Contoh indikator yang menggunakan jenis pengukuran Insiden / Kejadian :

- 1) Kejadian tidak dilakukan IMD pada bayi baru lahir
 - 2) Kejadian salah input *e-resep*
 - 3) Kejadian adanya benda asing dalam makanan
 - 4) Kejadian tidak dilakukannya asesmen tahap terminal
 - 5) Kejadian adanya uang muka untuk pasien gawat darurat
- Cara penginputan data dengan jenis pengukuran Insiden/Kejadian yakni,

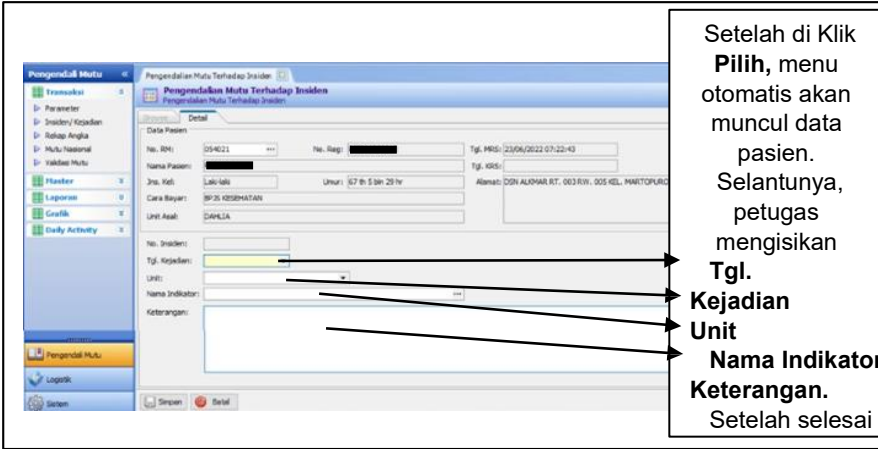
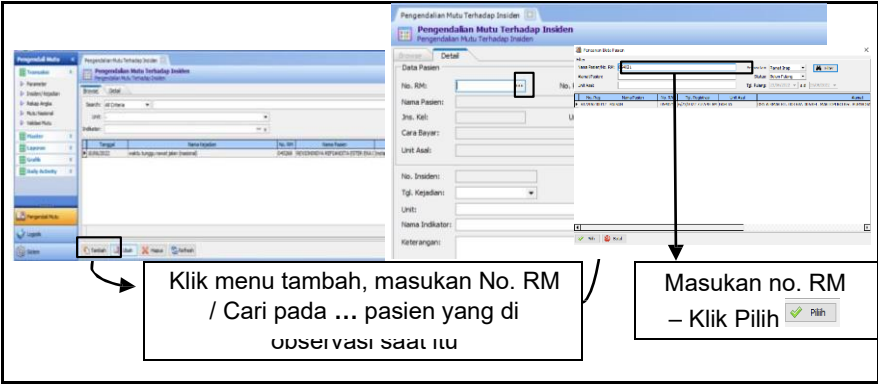
- 1) Pastikan kursor mengarah pada menu **Pengendalian Mutu**



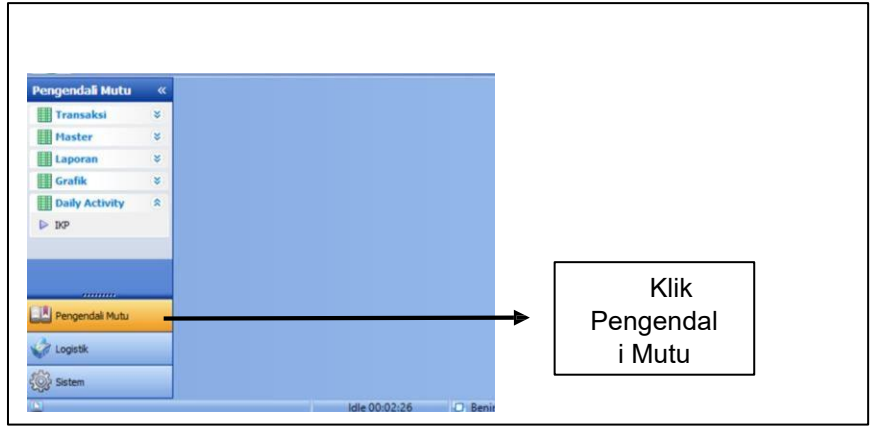
- 2) Klik **Transaksi** – pilih **Insiden/Kejadian** sampai muncul menu **Pengendalian Mutu Terhadap Insiden**



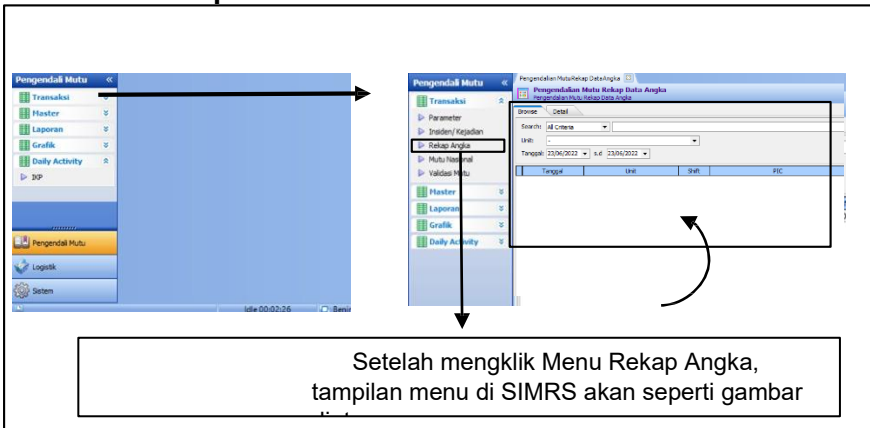
- 3) Selanjutnya, klik menu **Tambah**  masukan **No. RM** – masukan **Tgl. Kejadian** – masukan **Unit** asal – Masukan **nama indikator** – Masukan **keterangan** (berisi kronologi singkat kejadian)



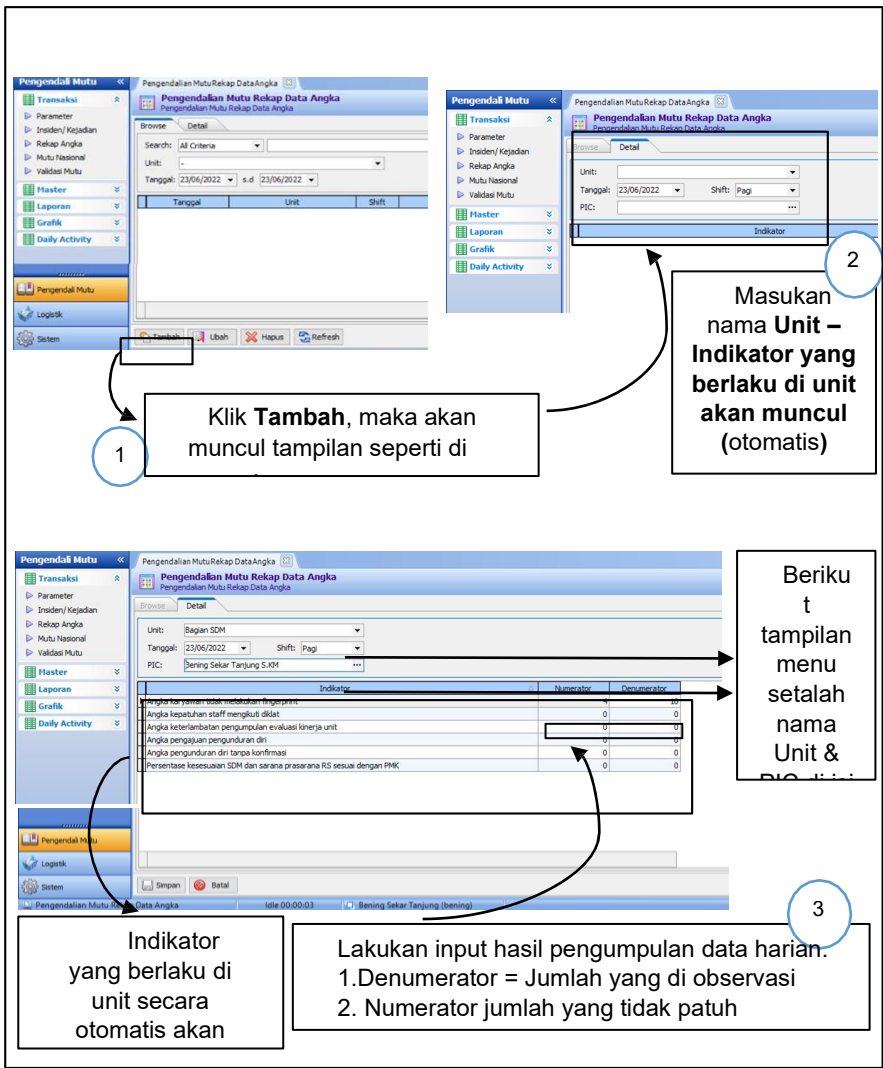
- 4) Setelah semua data di masukan, Klik **Simpan**. Penginputan yang dimasukan akan ter *Record* di SIMRS pengendali mutu.
- c. Rekap Angka : Merupakan indikator yang ketidakpatuhannya dapat di toleransi, dan memiliki nilai denumerator & Enumerator. Contoh indikator yang menggunakan jenis pengukuran Rekap Angka, yaitu :
- 1) Angka ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan / penolakan tindakan
 - 2) Angka pulang atas permintaan sendiri
 - 3) Angka kerusakan sampel darah
 - 4) Angka keterlambatan penyediaan darah >60 menit
 - 5) Angka keterlambatan penyediaan linen
- Cara penginputan data dengan jenis pengukuran Rekap Angka yaitu :
- 1) Pastikan kursor mengarah pada menu **Pengendalian Mutu**



- 2) Klik **Transaksi** – pilih **Rekap Angka** sampai muncul menu **Pengendalian Mutu Terhadap Insiden**



- 3) Selanjutnya, Klik  **Tambah** - pilih nama **Unit** (dengan otomatis semua judul indikator yang berlaku di unit akan muncul) – masukan **Nama PIC** – masukan **Angka Numerator** (jumlah yang tidak patuh) & **Angka Denominator** (jumlah pelayanan/petugas/pasien yang di



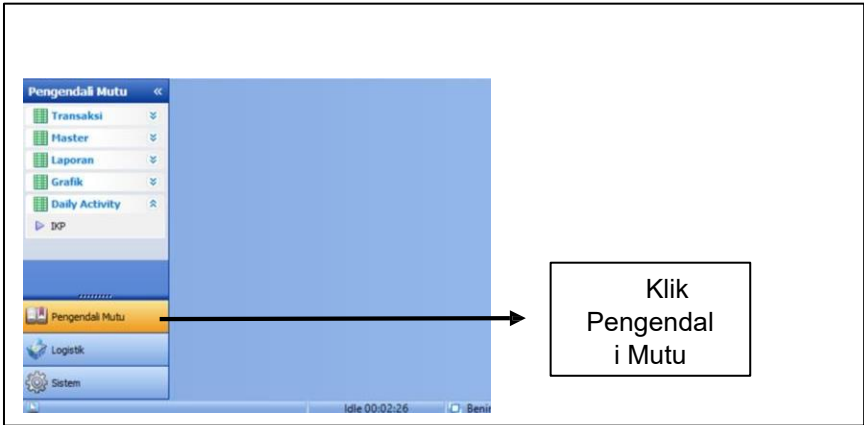
observasi pada waktu yang sama).

- 4) Setelah semua data di masukan, Klik **Simpan**. Penginputan yang dimasukan akan ter *Record* di SIMRS pengendali mutu.
- d. Mutu Nasional : merupakan menu yang digunakan khusus untuk menginput Indikator Nasional.

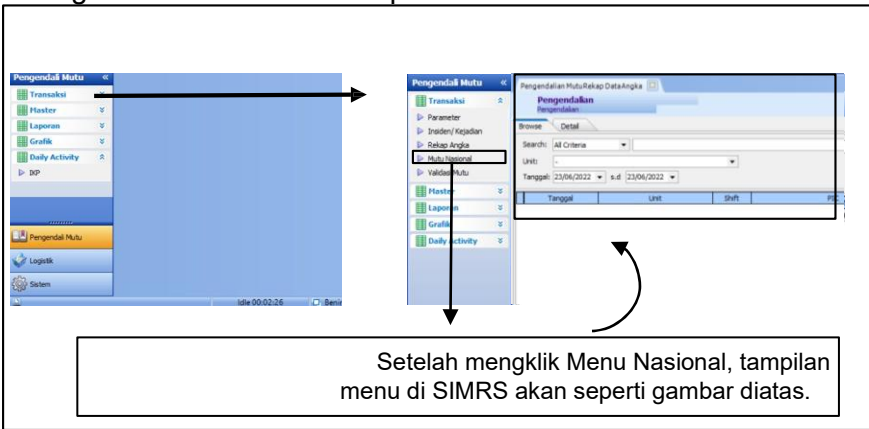
Contoh Indikator Nasional yaitu :

- 1) Angka Kepatuhan identifikasi pasien
- 2) Angka Kepatuhan penggunaan APD

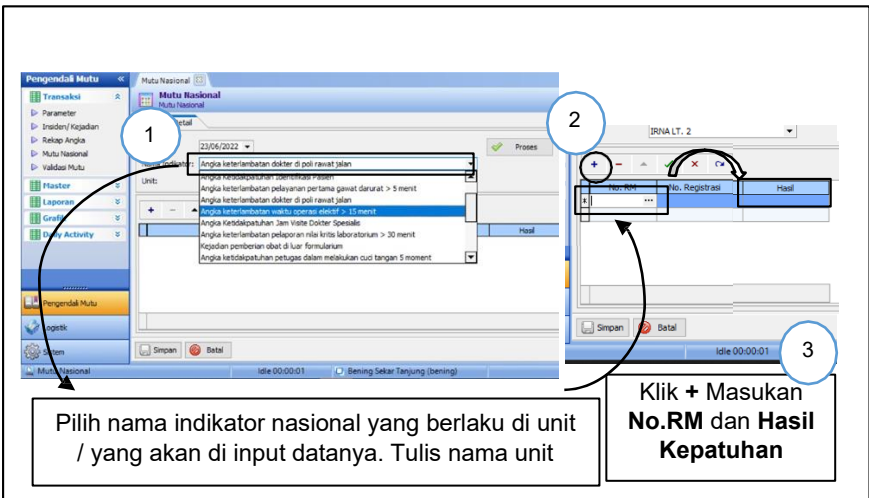
- 3) Angka Kepatuhan Hand Hygine
 - 4) Kejadian pemberian obat di luar formularium
 - 5) Angka Kepatuhan jam Visite dokter
- Cara penginputan data dengan jenis pengukuran Rekap Angka yaitu :
- 1) Pastikan kursor mengarah pada menu **Pengendalian Mutu**



- 2) Klik **Transaksi** – pilih **Mutu Nasional** sampai muncul menu Pengendalian Mutu Terhadap Insiden



- 3) Pilih **Nama Indikator** yang akan di input – pilih **Nama Unit** – pilih tambah **+** Masukan **No.RM** pasien – masukan **Hasil : Patuh / Tidak Patuh**



- 4) Setelah semua data di masukan, Klik **Simpan**. Penginputan yang dimasukan akan ter *Record* di SIMRS pengendali mutu.

BAB VII

METODE PERBAIKAN MUTU

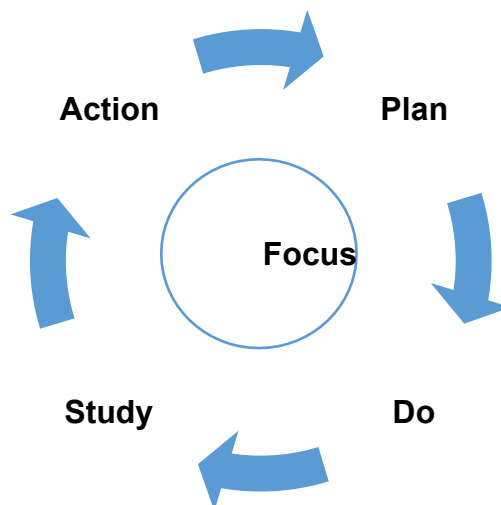
7.1 Metode Perbaikan FOCUS PDSA

Untuk meningkatkan perbaikan mutu pelayanan kesehatan maka disusun strategi sebagai berikut :

1. Setiap petugas harus memahami dan menghayati konsep dasar dan prinsip mutu pelayanan sehingga dapat menerapkan langkah-langkah upaya peningkatan mutu di masing-masing unit kerjanya.
2. Menciptakan budaya mutu di Rumah Sakit Prima Husada termasuk di dalamnya menyusun program mutu dengan pendekatan PDSA cycle.

PDSA adalah 4 (empat) proses interaktif dalam penyelesaian masalah yang umum digunakan dalam pengendalian mutu. Metode ini dapat digunakan dalam lingkungan pelayanan kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan. RS Prima Husada menggunakan Siklus PDSA. Gambar dibawah ini menunjukkan lingkaran FOCUS PDSA yang diharapkan di Rumah SAKIT Prima Husada.

Gambar 7.1 Lingkaran FOCUS PDSA



Penjelasan lingkaran upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan (*Plan*)

Perencanaan merupakan suatu upaya menjabarkan cara penyelesaian masalah yang ditetapkan ke dalam unsur-unsur rencana yang lengkap serta saling terkait dan terpadu sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan cara penyelesaian masalah. Hasil akhir yang dicapai dalam perencanaan adalah tersusunnya rencana kerja berbagai upaya penyelesaian masalah yang terkait dengan mutu. Pemimpin rumah sakit akan menetapkan dan membuat perkiraan hal-hal yang akan dimonitor. Komite MUTU bertanggung jawab dalam menyusun Pedoman MUTU dan menghubungkan dengan bagian terkait dalam penyusunan frekuensi pemantauan, penetapan bagaimana cara dan kapan seharusnya mengumpulkan data, menggunakan alat statistik untuk analisa data serta format dan tata cara pencatatan. Komite MUTU juga mengkordinasikan hal-hal terkait sumber daya yang digunakan, waktu untuk implementasi dan mendapat persetujuan dari pimpinan rumah sakit.

- b. Pelaksanaan (*Do*) Tahapan kedua yang dilakukan yaitu melaksanakan rencana yang telah disusun, jika pelaksanaan rencana tersebut membutuhkan keterlibatan staf lain diluar anggota tim , perlu terlebih dahulu diselenggarakan orientasi, sehingga staf pelaksana tersebut dapat memahami dengan lengkap rencana yang akan dilaksanakan. Setiap bagian harus mengimplementasikan perencanaan yang telah disetujui dan menetapkan orang yang bertanggung

- jawab untuk setiap tugas. Apabila diperlukan, Komite MUTU akan memberikan pelatihan yang sesuai serta melakukan supervisi ke unit terkait pengumpulan data mutu.
- c. Pembelajaran (*Study*) Tahapan ke tiga yang dilakukan ialah secara berkala memeriksa kemajuan dan hasil yang telah dicapai. Lewat hasil yang dicapai tersebut Orang yang bertanggung jawab dalam pemantauan program mutu (*Person in Charge/PIC*) harus mengumpulkan data dan menganalisa data tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah disetujui. Apabila ada kegagalan atau kinerja yang buruk, PIC dapat merekomendasikan tindakan perbaikan dan diberikan kepada pimpinan untuk mendapat persetujuan. Apabila telah disetujui, maka mereka harus mengimplementasikan tindakan perbaikan tersebut.
 - d. Perbaikan (*Action*) Tahapan terakhir yang dilakukan adalah melaksanakan perbaikan rencana kerja. Lakukanlah penyempurnaan rencana kerja atau bila perlu mempertimbangkan pemilihan dengan cara penyelesaian masalah lain. Untuk selanjutnya rencana kerja yang telah diperbaiki tersebut dilaksanakan kembali. Pemantauan kemajuan serta hasil yang dicapai juga perlu dilakukan untuk menyusun rencana langkah selanjutnya. ketika hasil yang diperoleh positif, prosedur kemudian diimplementasikan sebagai sebuah “Standar Prosedur”.

Jika terjadi kegagalan, maka sebuah rencana baru harus segera disusun sesuai dengan arahan dan prioritas yang ditetapkan oleh pimpinan dan kembali ke awal sesuai lingkaran PDSA. Semua perencanaan dan upaya perbaikan akan disebarluaskan kepada seluruh staf sesuai dengan perencanaan komunikasi. Penyebarluasan informasi dapat dilakukan melalui internet dan presentasi laporan bagi staf terkait.

7.2 Strategi Komunikasi

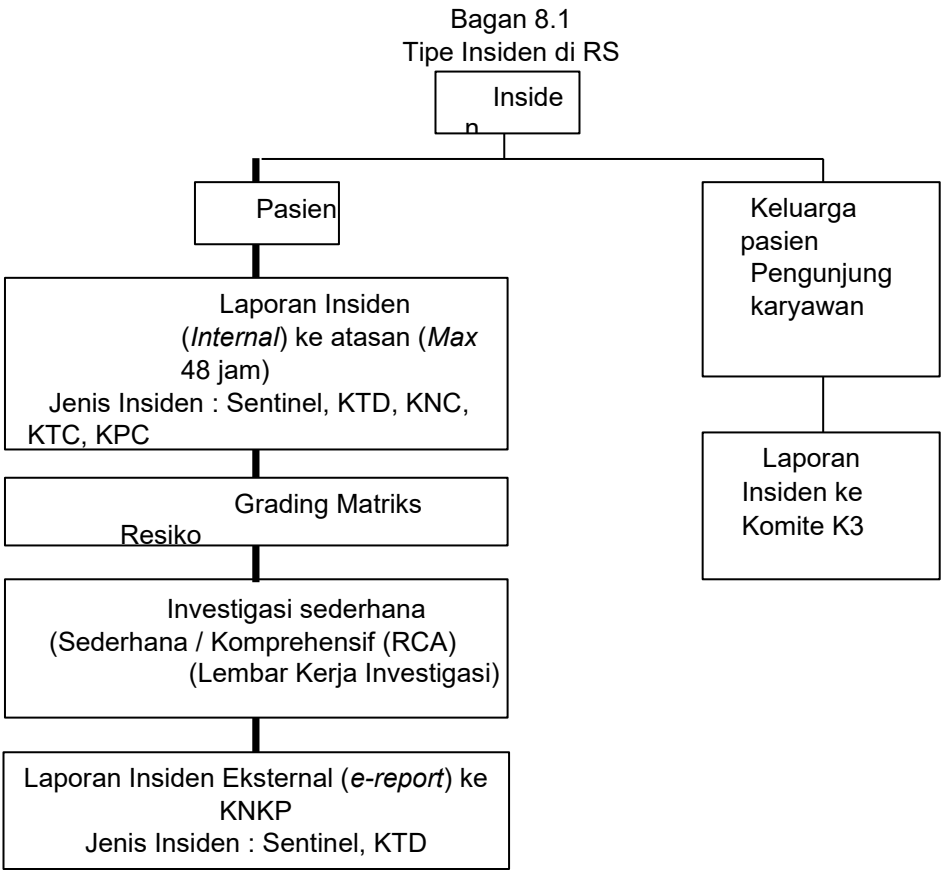
Dalam upaya melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Rumah Sakit Prima Husada menetapkan jalur komunikasi dalam upaya penyebaran informasi pada seluruh staf rumah sakit . Adapun strategi komunikasi yang diterapkan sebagai berikut:

1. Komunikasi kepada Pimpinan / Direktur
 - a. Prosedur dan kebijakan
 - b. Laporan tiga bulanan, enam bulan dan tahunan
2. Komunikasi Kepada Staff
 - a. Instruksi kerja (Tupoksi Kerja/Pedoman Kerja)
 - b. Rapat koordinasi, pertemuan mingguan/bulanan/triwulan dan pertemuan bagian/unit. Aktifitas ini membutuhkan kehadiran seluruh staf untuk memudahkan penyebaran informasi. Daftar kehadiran digunakan untuk memonitor kehadiran seluruh staf.
 - c. Notulen rapat disebarluaskan kepada seluruh staf terkait.
 - d. Internet; seluruh pimpinan rumah sakit dan dokter diberikan akses sehingga memungkinkan percepatan penyebaran informasi.
 - e. Pedoman praktek klinis dan alur klinis, merupakan alat untuk mengkomunikasikan standar pelayanan

BAB VIII
KEGIATAN KESELAMATAN PASIEN

8.1 Insiden Keselamatan Pasien

Insiden keselamatan pasien merupakan setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Berikut merupakan contoh insiden yang beresiko terjadi di Rumah sakit.



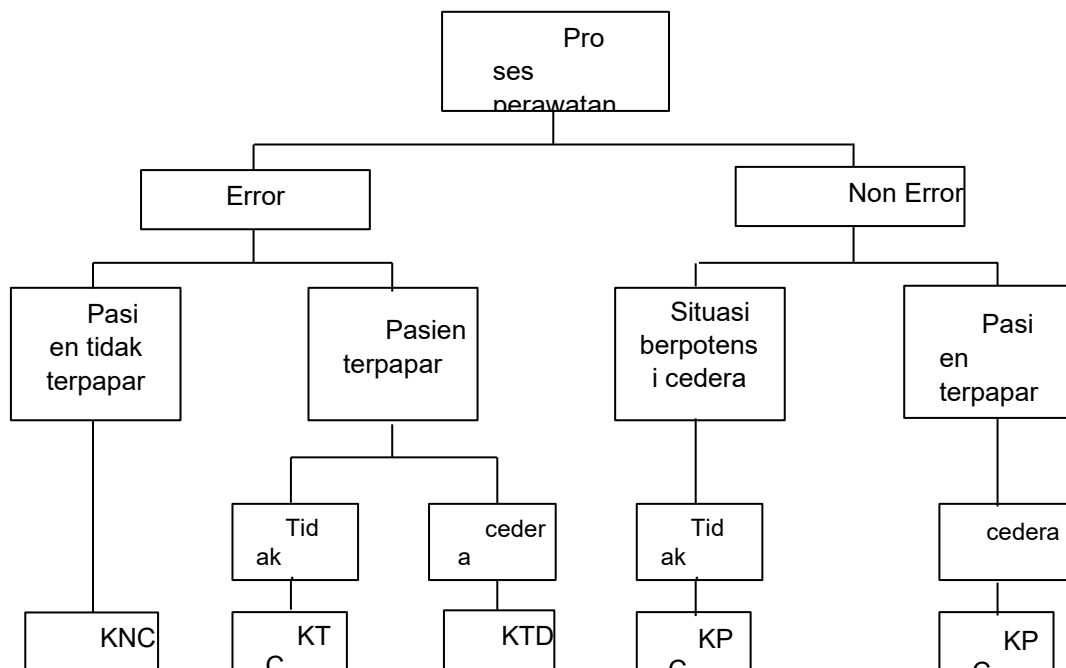
Paporan insiden di Rumah sakit meliputi insiden yang terjadi pada pasien dan insiden yang terjadi pada keluarga pasien, pengunjung ataupun karyawan. Namun dalam pelaporannya masing-masing insiden berbeda. Komite mutu akan menindaklanjuti pelaporan insiden terkait pasien dan komite K3 akan menindaklanjuti insiden terkait keluarga pasien, pengunjung, maupun karyawan. Pelaporan insiden keselamatan pasien sudah di atur dalam permenkes nomor 11 tahun 2017 sebagai berikut :

1. Setiap rumah sakit harus melakukan penanganan insiden untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
2. Penanganan insiden di rumah sakit dapat dilakukan melalui pembentukan tim keselamatan pasien yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sebagai pelaksana kegiatan penanganan insiden
3. Dalam melakukan penanganan insiden tim keselamatan pasien melakukan kegiatan berupa pelaporan, verifikasi, investigasi dan analisis insiden tanpa menyalahkan, menghukum dan memermalukan seseorang.
4. Setiap insiden harus dilaporkan secara :
 - a. Internal
 - 1) kepada tim keselamatan pasien dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam dengan menggunakan format laporan sebagai mana tercantum pada lampiran.
 - 2) Laporan akan diverifikasi oleh tim keselamatan pasien (unsur manajemen fasilitas pelayanan dan unsur klinis di fasilitas pelayanan)

- 3) Tim keselamatan pasien melakukan investigasi dalam bentuk wawancara dan pemeriksaan dokumen
 - 4) Tim keselamatan pasien menentukan derajat insiden (*grading*) dan melakukan *Root Cause Analysis* (RCA) dengan metode baku untuk menemukan akar masalah
- b. Eksternal
- 1) Kepada tim Komite Nasional Keselamatan Pasien (KNKP) sesuai dengan laporan pada formulir yang terlampir
 - 2) Insiden yang dilaporkan yakni : KTD dan sentinel
 - 3) Pelaporna insiden disampaikan setelah dilakukan analisis, serta mendapat rekomendasi dan solusi dari tim keselamatan pasien rumah sakit
 - 4) Setelah menerima pelaporan insiden KNKP akan melakukan pengkajian dan memberikan umpan balik (*feedback*) berupa rekomendasi untuk mencegah berulangnya kejadian yang sama di rumah sakit

8.2 Jenis-Jenis Insiden Keselamatan Pasien

Bagan 8.2
Jenis Insiden



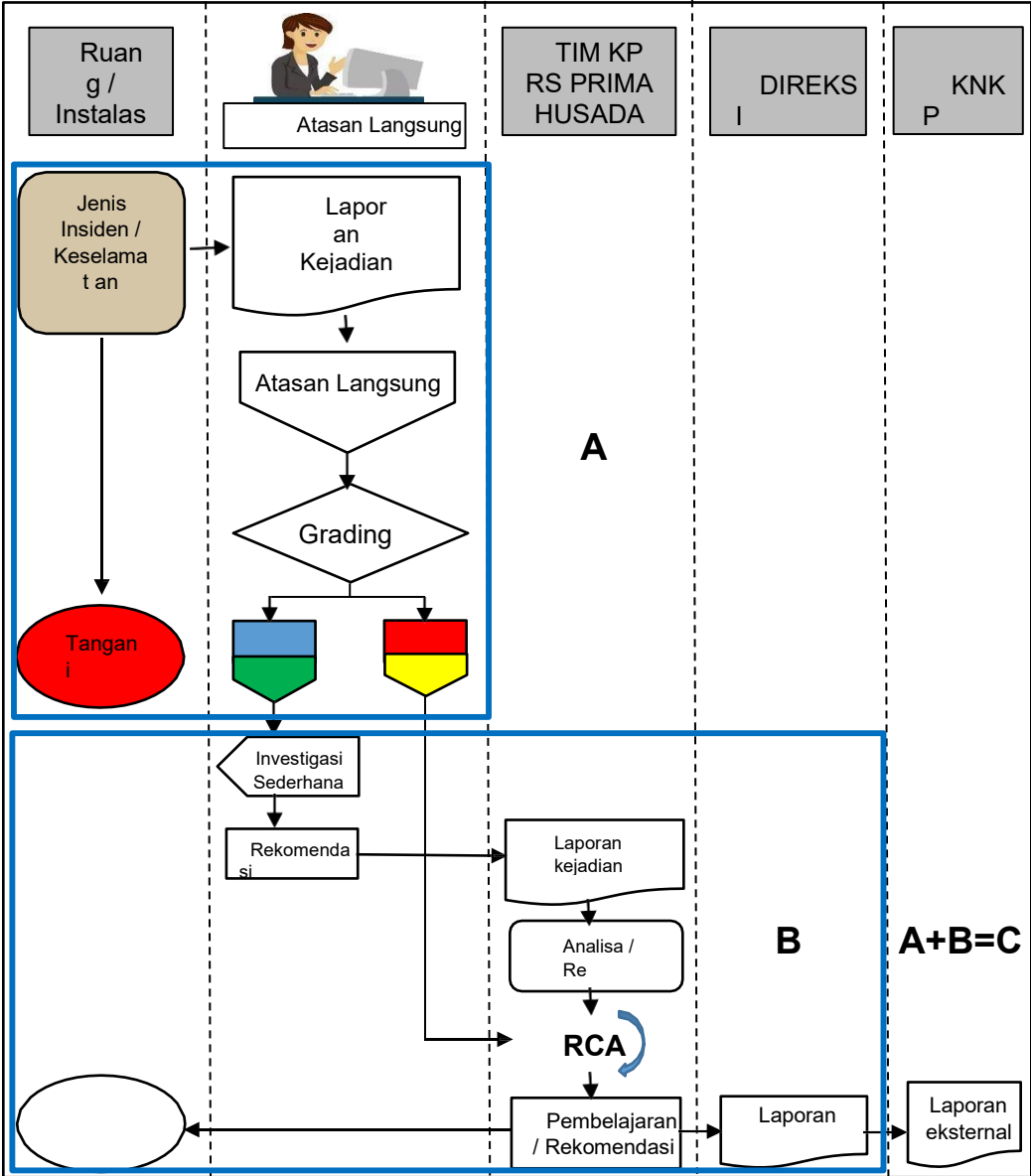
Setiap Rumah sakit harus melakukan penanganan seluruh jenis insiden di rumah sakit, tidak terkecuali kejadian sentinel. Kejadian sentinel merupakan suatu Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat yang temporer dan membutuhkan intervensi untuk mempertahankan kehidupan, baik fisik maupun psikis, yang tidak terkait dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien.

Kejadian sentinel yang berdampak luas / nasional dilaporkan sesegera mungkin paling lama 1 (satu) jam setelah diketahuinya kejadian sentinel. Palaporan dapat dilakukan secara lisan melalui media telepon kemudian dilengkapi dengan laporan tertulis. Laporan bersifat rahasia tanpa menyebutkan identitas pasien dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan, paling sedikit memuat :

1. Lokasi kejadian
2. Kronologis kejadian
3. Waktu kejadian
4. Akibat kejadian
5. Jumlah pasien yang mengalami kematian atau cedera berat akibat kejadian sentinel

8.3 Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

Bagan 8.3
Alur Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien



1. Apabila terjadi suatu insiden (KNC/KTD/KPC) di sekitar ruangan Rumah sakit, petugas wajib segera menindaklanjuti (di tangani) untuk mengurangi dampak atau akibat yang tidak diharapkan.
2. Setelah menindaklanjuti, petugas yang mengetahui insiden tersebut segera membuat laporan insidennya dengan mengisi formulir insiden (terlampir) pada akhir kerja / shift kepada kepala ruangan (paling lambat 2 x 24 jam), diharapkan tidak menunda laporan.
3. Setelah mengisi form laporan, petugas segera menyerahkan kepada kepala ruang.
4. Kepala ruang memeriksa laporan insiden yang diberikan petugas, dan melakukan grading resiko terhadap insiden yang dilaporkan
5. Hasil grading akan menentukan bentuk investigasi dan analisa yang dilakukan sebagai berikut :
 - a. Cara melakukan grading : melihat tabel probabilitas & tabel dampak sehingga kan ditemukan warna grading pada tabel derajat resiko. Berikut tabel yang digunakan untuk melakukan grading

Tabel 8.1
Probabilitas / Frekuensi / Likelihood

Level	Frekuensi	Kejadian Aktual
1	Sangat Jarang	Dapat Terjadi dalam lebih dari 5 tahun
2	Jarang	Dapat terjadi dalam 2 – 5 tahun
3	Mungkin	Dapat terjadi dalam 1 – 2 tahun
4	Sering	Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun
5	Sangat Sering	Terjadi dalam minggu / bulan

Tabel 8.2
Dampak Klinis / Consequences / Severity

Level	Deskripsi	Contoh Deskripsi
1	Insignificant	Tidak cedera, kerugian keuangan kecil
2	Minor	Dapat dibatasi dengan pertolongan pertama, kerugian uang sedang
3	Moderate	Berkurangnya fungsi motoric/sensorik/psikologis atau intelektual secara semipermanent / reversible / tidak berhubungan dengan penyakit, setiap kasus yang memperpanjang perawatan
4	Major	Cedera luas, kehilangan fungsi utama permanent (motoric, sensorik, psikologis, intelektual) permanen . irreversible / tidak berhubungan dengan penyakit, kerugian besar
5	Cathastropic	Kematian yang tidak berhubungan dengan pekerjaan penyakit, kerugian keuangan sangat besar

Tabel 8.3
Matrik Grading

Frekuensi / Likelihood	Potensial consequences				
	Insignificant	Minor	Moderate	Major	Cathastropic
Sangat sering terjadi (Tiap mgg/bln) 5	Moderate	Moderate	High	Extreme	Extreme
Sering terjadi (Tiap beberapa X/bln) 4	Moderate	Moderate	High	Extreme	Extreme
Mungkin terjadi (1-2x / thn) 3	Low	Moderate	High	Extreme	Extreme
Jarang terjadi (>2-5x / thn) 2	Low	Low	Moderate	High	Extreme
Sangat jarang sekali (>5 x / thn) 1	Low	Low	Moderate	High	Extreme

Tabel 8.4

Tindakan sesuai dengan hasil grading	
Level	Tindakan
<i>Extreme</i>	Resiko ekstrim, dilakukan RCA paling lama 45 hari. Membutuhkan tindakan segera, pertahian sampai ke Direktur
<i>High</i>	Resiko tinggi, dilakukan RCA paling lama 45 hari Keji dengan detail & perlu tindakan segera Membutuhkan perhatian Top Manajemen
<i>Moderate</i>	Resiko sedang, dilakukan investigasi sederhana paling lama 2 minggu Manajer / pimpinan klinis sebaiknya menilai dampak terhadap biaya dan kelola resiko
<i>Low</i>	Resiko rendah, dilakukan investigasi sederhana paling lama 1 minggu diselesaikan dengan prosedur rutin

- b. Berikut merupakan langkah yang harus dilakukan setelah menentukan grading pada insiden yang terjadi.
 - 1) Grade Biru : Investigasi sederhana oleh atasan langsung, waktu maksimal 1 minggu
 - 2) Grade Hijau : Investigasi sederhana oleh atasan langsung, waktu maksimal 2 minggu
 - 3) Grade Kuning : Investigasi komprehensif / analisis akar maslaah / RCA oleh Tim KPRS, waktu maksimal 45 hari
 - 4) Grade Merah : Investigasi Komprehensif / analisis akar masalah / RCA oleh tim KPRS, waktu maksimal 45 hari
6. Setelah selesai melakukan investigasi sederhana, laporan hasil investigasi dan laporan insiden akan dilaporkan kepada Tim Keselamatan Pasien Rumah sakit (KPRS)
7. Tim KPRS akan melakukan regrading melalui analisa kembali hasil investigasi dan laporan insiden untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan (komprehensif / RCA)
8. Setelah melakukan regrading, untuk hasil grading Kuning / Merah akan dilakukan Investigasi komprehensif / RCA oleh Tim KPRS
9. Setelah melakukan investigasi komprehensif / RCA, Tim KPRS akan membuat laporan dan rekomendasi untuk “perbaikan” serta “pembelajaran” berupa : petunjuk / *safety alert* untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali
10. Hasil rekomendasi dan rencana kerja dari investigasi komprehensif / RCA akan dilaporkan kepada Direksi
11. Rekomendasi untuk “perbaikan dan pembelajaran” diberikan kepada unit sebagai umpan balik dari pelaporan insiden. Unit terkait akan melakukan sosialisasi kepada seluruh sttaf di unit / unit lainnya
12. Tim KPRS akan melakukan monitoring dan evaluasi dari hasil perbaikan yang dilakukan di unit
13. Untuk hasil investigasi dari insiden KTD / Sentinel akan dilakukan pelaporan ke KPPRS (Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit / Eksternal) melalui *e-reporting* dengan *website* resmi.

8.4 Budaya Keselamatan Pasien

Budaya keselamatan suatu organisasi adalah hasil dari nilai-nilai individu dan kelompok, sikap, persepsi, kompetensi, dan pola perilaku yang menentukan komitmen terhadap, dan gaya serta kemampuan, manajemen pelayanan kesehatan dan keselamatan organisasi. Organisasi dengan budaya keselamatan positif dicirikan oleh komunikasi atas dasar saling percaya, dengan persepsi yang sama tentang pentingnya keselamatan, dan yakin akan manfaat langkah-langkah pencegahan. Penerapan budaya keselamatan antara lain:

1. Staf klinis memperlakukan satu sama lain secara hormat .

2. Melibatkan dan memberdayakan pasien dan keluarga
3. Staf klinis pemberi asuhan bekerja sama dalam tim yang efektif dan mendukung proses kolaborasi interprofesional
4. Asuhan berfokus pada pasien

Perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan meliputi :

1. Perilaku yang tidak layak (*inappropriate*) seperti kata-kata atau bahasa tubuh yang merendahkan atau menyinggung perasaan sesama staf, misalnya mengumpat dan memaki.
2. Perilaku yang mengganggu (*disruptive*) misalnya perilaku tidak layak yang dilakukan secara berulang, bentuk tindakan verbal atau nonverbal yang membahayakan atau mengintimidasi staf lain, dan “celetukan maut” adalah komentar sembrono di depan pasien yang berdampak menurunkan kredibilitas staf klinis lain. Contoh mengomentari negatif hasil tindakan atau pengobatan staf lain di depan pasien, misalnya “obatnya ini salah, tamatan mana dia...?”, melarang perawat untuk membuat laporan tentang KTD, memarahi staf klinis lainnya di depan pasien, kemarahan yang ditunjukkan dengan melempar alat bedah di kamar operasi, serta membuang rekam medis di ruang rawat.
3. Perilaku yang melecehkan (*harassment*) terkait dengan ras, agama, dan suku termasuk gender.
4. Pelecehan seksual

Pengukuran budaya keselamatan perlu dilakukan oleh rumah sakit, dimana budaya keselamatan merupakan budaya organisasi yang mendorong setiap individu/ staf untuk melaksanakan keselamatan di seluruh area rumah sakit. Budaya keselamatan mencakup mengenali dan menunjukan masalah yang terkait dengan sistem yang mengarah pada perilaku yang tidak aman, dimana perlu dilakukan evaluasi rutin yang dapat menggunakan metode survei resmi, wawancara staf, analisis data dan diskusi kelompok.

Pengukuran budaya keselamatan dengan metode survei melibatkan staf yang ada di semua unit yang akan diukur dengan sampling secara proposional sehingga hasilnya akurat. Metode survey minimal dilakukan satu tahun sekali . Survey dilakukan dengan memberikan kuesioner penerapan budaya keselamatan dari KARS pada staf yang ada di unit kerja yang terkait. Selanjutnya kuesioner yang telah diisi divalidasi, diolah dan dianalisis sehingga diketahui penerapan budaya keselamatan di unit tersebut dan tingkat rumah sakit. Hasil evaluasi penerapan budaya keselamatan disampaikan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi serta untuk tindak lanjut perbaikan dalam penerapan budaya keselamatan. Contoh kuesioner budaya keselamatan pasien akan dilampirkan pada halaman dibawah.

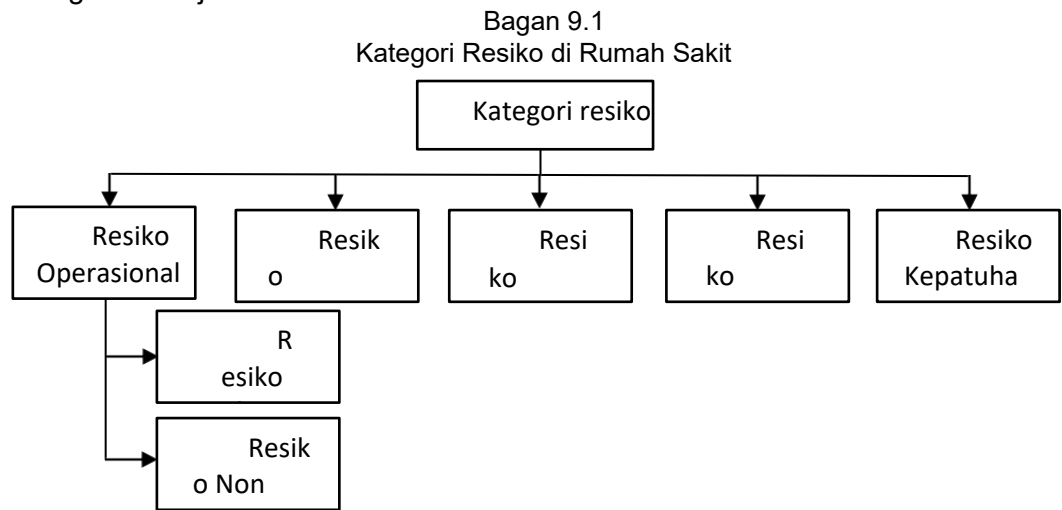
BAB IX
KEGIATAN
MANAJEMEN
RESIKO

9.1 Manajemen Resiko

Untuk dapat menanggulangi semua risiko yang mungkin terjadi, diperlukan sebuah proses yang dinamakan sebagai manajemen risiko . Adapun beberapa definisi manajemen risiko dari berbagai literatur yang didapat, antara lain :

1. Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia di rumah sakit.
2. Manajemen Risiko adalah suatu kegiatan untuk mengantisipasi, mengurangi, mencegah terulangnya kejadian pada pelanggan internal dan eksternal dengan identifikasi, analisis, evaluasi, pengelolaan dan monitoring risiko.
3. Manajemen Risiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk mewujudkan peluang peluang sambil mengelola efek yang tidak diharapkan. (AS/NZS 4360:2004)
4. Manajemen Risiko merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi berkaitan dengan risiko. (ISO 31000:2009)
5. Manajemen Risiko merupakan proses formal dimana faktor-faktor risiko secara sistematis diidentifikasi, diukur, dan dicari.

Di rumah sakit resiko dikategorikan menjadi beberapa jenis, berikut merupakan kategori manajemen resiko :



Kategori resiko di Rumah sakit dibagi menjadi 5, yaitu :

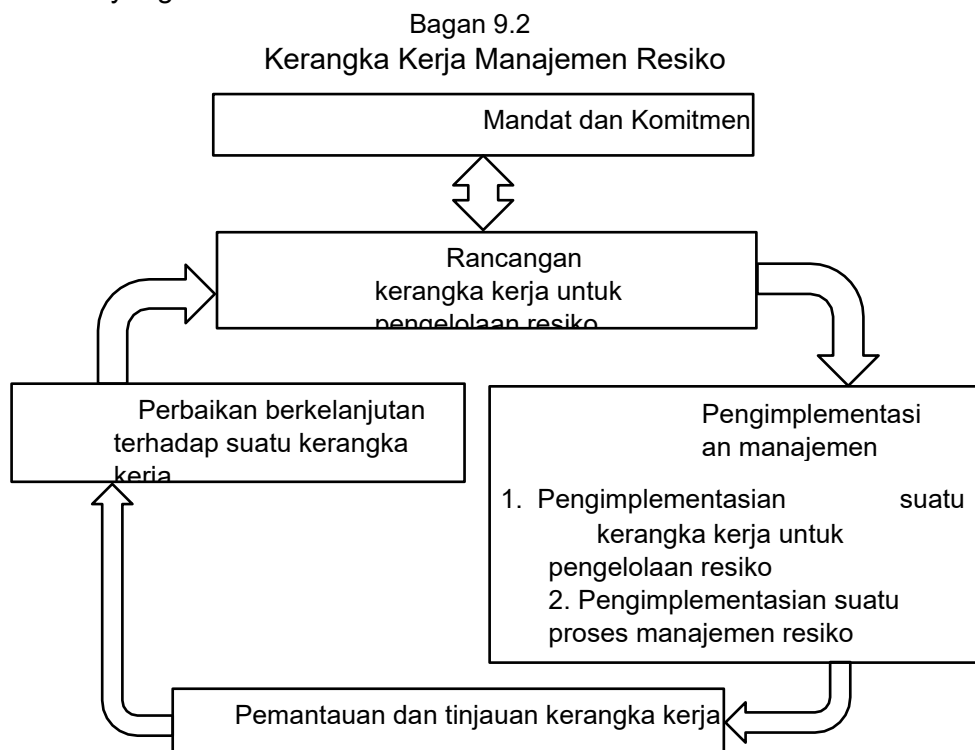
1. Resiko operasional : resiko yang terjadi saat Rumah sakit memberikan pelayanan kepada pasien baik klinis maupun non klinis.
 - a. Resiko klinis : resiko operasional yang berkaitan dengan pelayanan kepada pasien (*patient safety*) meliputi resiko yang berhubungan dengan perawatan klinis & pelayanan penunjang seperti kesalahan diagnostic, bedah atau pengobatan.
 - b. Resiko non klinis : resiko operasional antara lain resiko PPI (sterilisasi, laundry, gizi, kamar jena-zah dll), resiko MFK (terkait dng fasilitas dan lingkungan, seperti kondisi bangunan yg membahayakan, resiko yg terkait dengan ketersediaan sumber air & listrik, dll. Unit klinis maupun non klinis dapat memiliki resiko yg lain sesuai dengan proses bisnis atau kegiatan yang dilakukan di unitnya. Misalnya unit humas dapat mengidentifikasi resiko reputasi dan resiko keuangan
2. Resiko keuangan : resiko kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku
3. Resiko reputasi : citra rumah sakit yang dirasakan oleh masyarakat, Jika reputasi rumah sakit rusak, maka kerugian dalam waktu cepat dapat dirasakan, seperti pasien yang mulai ragu menggunakan jasa pelayanan rumah sakit.
4. Resiko strategis : terkait dengan rencana strategis termasuk tujuan strategis

Rumah sakit.

5. Resiko kepatuhan : terhadap hukum dan regulasi Dalam kasus ekstrim, sebuah risiko kepatuhan dapat juga berdampak pada masa depan bisnis rumah sakit, akan menjadi risiko strategis juga

9.2 Kerangka Kerja Manajemen Resiko

Keberhasilan manajemen risiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan di Rumah sakit. Kerangka kerja membantu Rumah sakit mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen. Tujuan dari kerangka kerja manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa informasi tentang risiko yang berasal dari proses manajemen risiko dapat dilaporkan dengan baik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemenuhan akuntabilitas yang relevan di semua unit yang ada di Rumah sakit.



Bagian awal dari manajemen risiko adalah memastikan adanya mandate dan komitmen yang kuat dan berkelanjutan oleh seluruh struktur manajemen risiko dan seluruh pemangku kepentingan turut serta dalam melakukan perencanaan strategis untuk mencapai komitmen di semua tingkatan. Untuk mencapai komitmen di semua tingkatan, seluruh struktur manajemen risiko dan seluruh pemangku kepentingan harus melakukan :

1. Mendefinisikan dan mendukung kebijakan manajemen risiko
2. Memastikan bahwa budaya dan kebijakan manajemen risiko di Rumah sakit berjalan selaras
3. Menentukan indikator kinerja manajemen risiko yang sejalan dengan indikator kinerja di Rumah sakit
4. Menyelaraskan tujuan manajemen risiko dengan tujuan strategi Rumah sakit
5. Memastikan kepatuhan hukum dan peraturan
6. Menetapkan akuntabilitas dan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi di Rumah sakit
7. Memastikan bahwa sumberdaya yang diperlukan dialokasikan untuk manajemen risiko
8. Menyampaikan manfaat manajemen risiko kepada semua stakeholder
9. Memastikan bahwa kerangka kerja mengelola risiko sesuai

Setelah Rumah sakit menentukan mandat dan memiliki komitmen untuk menjalankan manajemen risiko yang selaras di semua tingkatan dan *stakeholder* .

langkah selanjutnya yg dilakukan yakni membuat rancangan kerangka kerja untuk mengelola resiko di Rumah sakit.

1. Pemahaman organisasi dan konteksnya
2. Penetapan kebijakan manajemen resiko
3. Akuntabilitas
4. Integrasi ke dalam proses organisasi
5. Sumberdaya
6. Penetapan mekanisme komunikasi dan pelaporan internal
7. Penetapan mekanisme komunikasi dan pelaporan eksternal

Setelah terbentuk rancangan kerangka kerja untuk pengelolaan resiko di rumah sakit, selanjutnya akan dilakukan yakni mengimplementasikan kerangka kerja manajemen resiko untuk mengelola resiko yang ada di setiap unit kerja. Dalam melaksanakan kerangka kerja yang dibuat dapat dilaksanakan dengan :

1. Menerapkan kerangka kerja untuk mengelola resiko
 - a. Menentukan waktu yang tepat dan strategi untuk menetapkan kerangka kerja
 - b. Menetapkan kebijakan dan proses manajemen resiko pada setiap proses pelayanan di Rumah sakit
 - c. Mematuhi persyaratan hukum dan peraturan
 - d. Memastikan bahwa pengambilan keputusan termasuk pengembangan dan penetapan tujuan, sejalan dengan hasil dari proses manajemen resiko
 - e. Berkomunikasi dan berkonsultasi dengan para pihak terkait untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen resiko tetap sesuai

2. Menerapkan proses manajemen resiko

Manajemen resiko harus dilaksanakan dengan memastikan bahwa proses manajemen resiko diterapkan melalui rencana manajemen resiko di semua tingkat dan fungsi Rumah sakit yang relevan sebagai bagian dari praktis dan proses

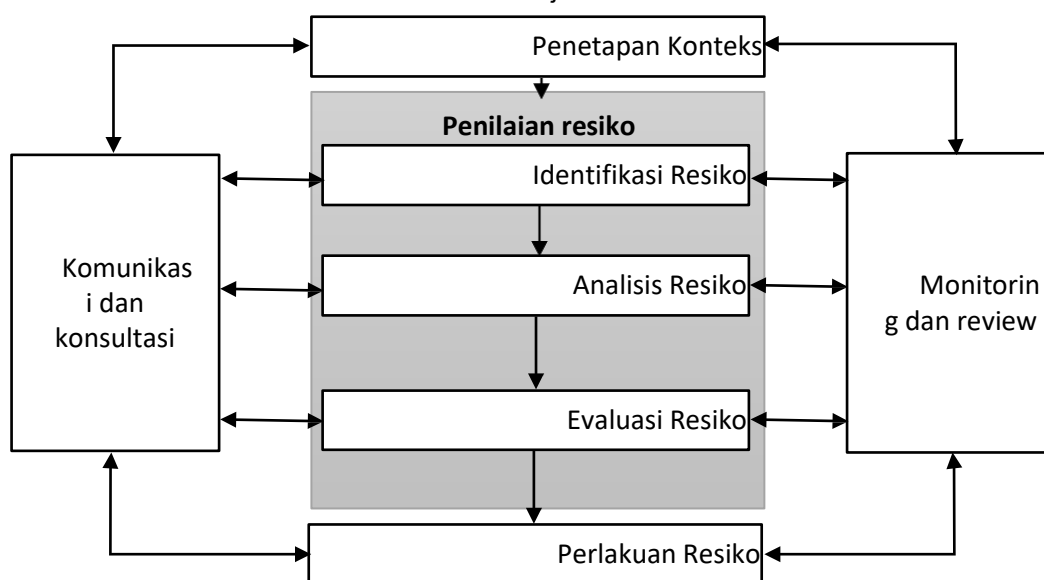
Untuk memastikan pengimplementasian manajemen resiko di Rumah sakit berjalan secara efektif dan berkelanjutan, Rumah sakit harus melakukan kegiatan *monitoring* dan *review* kerangka manajemen resiko yang dapat dilakukan melalui:

1. Mengukur kinerja penerapan manajemen resiko melalui indikator dan dilakukan *review* secara berkala
2. Mengukur secara berkala hasil positif berupa kemajuan maupun hasil negative berupa penyimpangan dari rencana manajemen resiko yang sudah ditentukan
3. Meninjau kesesuaian kerangka kerja manajemen resiko maupun kebijakan tentang manajemen resiko dengan kondisi *eksternal* dan *internal* Rumah sakit
4. *Review* efektivitas kerangka kerja manajemen resiko

9.3 Proses Manajemen Resiko

Proses manajemen resiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen Rumah sakit yang masuk menjadi bagian dari budaya kerja Rumah sakit, praktek terbaik yang dilakukan oleh Rumah sakit dan proses bisnis di Rumah sakit. Berikut merupakan proses manajemen resiko.

Bagan 9.3
Proses manajemen resiko



Proses manajemen resiko terbagi menjadi 5 (lima) kegiatan yaitu :

1. Komunikasi dan konsultasi

Merupakan proses interaktif dalam hal menukar informasi dan pendapat yang mencakup berbagai pesan mengenai resiko dan pengelolaannya. Proses ini berjalan secara internal di Rumah sakit, maupun di setiap unit atau *stakeholder eksternal*.

Konsultasi di artikan sebagai proses komunikasi di Rumah sakit, yang biasanya dilakukan oleh setiap unit dengan pimpinan Rumah sakit mengenai isu tertentu, terkait dengan pengambilan keputusan termasuk penerpan manajemen resiko. Bentuk komunikasi dan konsultasi dapat berupa :

- Rapat berkala
- Rapat insidental
- Seminar/sosialisasi/*workshop*
- Forum pengelola resiko

Selain bentuk diatas, komunikasi dan konsultasi juga dapat dilakukan melalui media elektronik. Pelaksanaan komunikasi dna konsultasi merupakan tanggung jawab pemilik resiko.

2. Penetapan Konteks

Penerapan konteks merupakan suatu teknik untuk mengartikan tujuan dan mendefinisikan parameter *eksternal* dan *internal* untuk diperhitungkan ketika mengelola resiko, kemudian menetapkan ruang lingkup dan kriteria resiko untuk prosedur selanjutnya. Dalam menentukan konteks perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Konteks *Eksternal*

Merupakan situasi yang berasal dari luar Rumah sakit yang dapat mempengaruhi cara pengelolaan resiko di lingkungan rumah sakit. Konteks *eksternal* dapat meliputi :

- Hukum, social, budaya, politik, regulasi, keuangan, teknologi, lingkungan ekonomi, alam dan persaingan dengan Rumah sakit lain dalam lingkup nasional, regional maupun internasional
- Hubungan, persepsi dan nilai-nilai pemangku kepentingan *eksternal*, dll

b. Konteks *Internal*

Merupakan segala sesuatu dari dalam Rumah sakit yang dapat mempengaruhi cara Rumah sakit dalam mengelola resiko yang ada. Kontek *internal* dapat berupa :

- Tata kelola, struktur, peran dan akuntabilitas Rumah Sakit
- Kebijakan, sasaran dan strategi

3. Kemampuan dan pemahaman tentang sumber daya (modal, waktu, staff, prosedur, sistem dan teknologi)
4. Hubungan, persepsi dan nilai-nilai pemangku kepentingan internal dan budaya organisasi
5. Sistem informasi, arus informasi dan prosedur pengambilan keputusan

3. Penilaian Resiko

Penilaian resiko terdiri dari 3 (tiga) proses yakni : identifikasi resiko, analisis resiko dan evaluasi resiko.

a. Identifikasi resiko

Setiap unit kerja di Rumah sakit harus melakukan identifikasi sumber resiko, area dampak, peristiwa (termasuk perubahan keadaan), penyebabnya dan konsekuensi potensi resiko. Tujuan dilakukan identifikasi resiko yakni untuk menghasilkan daftar lengkap resiko berdasarkan peristiwa yang mungkin terjadi di unit, sehingga Rumah sakit dapat melakukan kegiatan *preventif* untuk menurunkan, mencegah agar resiko yang diidentifikasi tidak terjadi. Metode identifikasi resiko dapat dilakukan dengan beberapa metode, Rumah sakit prima husada menggunakan metode *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA). Untuk melaksanakan identifikasi resiko di lingkungan unit kerja dapat dilakukan langkah-langkah berikut :

- 1) Memahami dan mengidentifikasi kegiatan utama unit kerja
- 2) Mengidentifikasi tujuan dari masing-masing kegiatan
- 3) Mengumpulkan data dan informasi tentang resiko yang mungkin terjadi di unit kerja, baik resiko yang sudah pernah terjadi maupun yang belum pernah terjadi
- 4) Mencari penyebab dari resiko-resiko yang telah teridentifikasi untuk mendapatkan penyebab utamanya
- 5) Mengidentifikasi apakah penyebab tersebut sifatnya dapat dikendalikan (*controllable*) atau atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) bagi unit kerja.
- 6) Mengidentifikasi dampak jika resiko tersebut terjadi
- 7) Mengisi hasil butir a-f dalam formulir identifikasi resiko dan memperbaharui setiap saat terjadi pernyataan resiko.

Identifikasi pernyataan resiko dapat dilakukan dengan mendasarkan pada hasil penilaian resiko sebelumnya dengan penyelarasan terhadap perkembangan situasi lingkungan *internal* dan *eksternal* yang terjadi. Untuk menjamin identifikasi resiko yang komprehensif, resiko disusun sesuai dengan kondisi lingkungan di Rumah sakit. Kategori resiko minimal di Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 9.1 Kategori resiko

Kategori Resiko	Definisi
Resiko keuangan	Resiko disebabkan oleh segala sesuatu yang menimbulkan tekanan terhadap pendapatan dan belanja di Rumah sakit
Resiko Kepatuhan	Resiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi baik internal maupun eksternal yang berdampak langsung terhadap organisasi
Resiko Legal	Resiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang –undangan dan ketentuan lain yang berlaku
Resiko Fraud	Resiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada Rumah sakit

Resiko Reputasi	Resiko yang disebabkan oleh menurunnya kepercayaan public / masyarakat yang bersumber dari persepsi negatif pelayanan rumah sakit
Resiko Operasional	Resiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia dan kegagalan sistem. Adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi

Selain memperhatikan kategori resiko, kategori dampak juga sangat penting dalam menjami identifikasi resiko yang komprehensif. Kategori dampak disusun sesuai dengan kondisi lingkungan di Rumah sakit. Kategori dampak minimal di Kementerian Kesehatan tertera pada tabel berikut :

Tabel 9.2 Kategori Dampak

Skor	Derajat (Tingkat)	Dampak Keuangan	Tuntutan Ganti Rugi	Penundaan Pelayanan	Dampak pada Kesehatan & Keselamatan	Reputasi	Dampak pada pihak terkait
1	Sangat rendah	≤ 3 % Anggaran	≤ Rp 1 juta	≤ 1 hari	Luka kecil pada orang atau beberapa orang	Diketahui oleh seisi kantor	Hanya berdampak pada satu pihak
2	Rendah	> 3 – 5 % Anggaran	> Rp 1 – 5 juta	> 1 – 2 hari	Luka kecil berarti pada orang atau beberapa orang	Dimuat oleh media massa lokal namun cepat dilupakan masyarakat	Berdampak pada 2 - 3 pihak
3	Sedang	> 5 – 8 % Anggaran	> Rp 5 – 25 juta	> 2 – 3 hari	Luka berarti pada orang atau beberapa orang	Dimuat oleh media massa lokal & media sosial namun cepat dilupakan masyarakat	Berdampak pada 3 - 4 pihak
4	Tinggi	> 8 - 12 % Anggaran	> Rp 25 – 50 juta	> 3 – 5 hari	Luka serius pada orang atau beberapa orang	Dimuat di media nasional dan media online dan diingat sementara oleh masyarakat	Berdampak pada 4- 5 pihak
5	Sangat Tinggi	> 12 % Anggaran	> Rp 50 juta	> 5 hari	Luka berganda atau kematian atau cacat permanen	Imuat oleh media nasional/ internasional dan media sosial/media online diingat lama oleh masyarakat	Berdampak pada lebih 5 pihak

b. Analisis Resiko

Pada proses ini, unit menganalisis resiko mana yang akan dilakukan evaluasi, perlu ditangani. Selain itu, unit juga harus menentukan strategi dan metode yang akan digunakan untuk penanganan yang paling tepat. Kegiatan analisis resiko yang dilakukan oleh Rumah sakit adalah mengkaji penyebab dan sumber resiko , akibat yang akan ditimbulkan jika kemungkinan resiko yang di identifikasi terjadi.

Suatu insiden dapat menimbulkan permasalahan yang bermacam-macam sehinga dapat mempengaruhi berbagai tujuan yang ditentukan oleh Rumah sakit. Untuk melaksanakan analisis resiko di Rumah sakit, langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut :

- 1) Rumah sakit harus memiliki hasil identifikasi resiko setiap unit kerja
- 2) Hasil identifikasi di evaluasi atas kecukupan disain dan penyelenggaraan sistem pengendalian internal yang sudah ada
- 3) Ukur tingkat probabilitas terjadinya resiko

Tabel 9.3 Probabilitas resiko

Level kemungkinan (probabilitas)	Kriteria Kemungkinan (Probabilitas)
Hampir tidak terjadi 1	Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi yang luar biasa Persentase 0-10%
Jarang Terjadi 2	Peristiwa diharapkan tidak terjadi Persentase > 10-30%

Kadang Terjadi 3	Peristiwa kadang-kadang terjadi Persentase > 30-50%
Sering Terjadi 4	Peristiwa sangat mungkin terjadi pada sebagian kondisi Persentase >50-90% dalam 1 periode
Hampir Pasti Terjadi 5	Peristiwa selalu terjadi hampir pada setiap kondisi Persentase >90% dalam 1 periode

4) Ukur tingkat besaran dampak resiko yang terjadi

Tabel 9.4 Dampak (Konsekuensi)

Level Dampak	Area Dampak
Sangat Rendah 1	Tidak berdampak pada pencapaian tujuan instansi / kegiatan secara umum
	Agak mengganggu pelayanan
	Dampak dapat ditangani pada tahap rutin
	Kerugian kurang material dan tidak dipengaruhi <i>stakeholder</i>
Rendah 2	Mengganggu pencapaian tujuan instansi / kegiatan meskipun tidak signifikan
	Cukup mengganggu jalannya pelayanan
	Mengancam efisiensi dan efektivitas beberapa aspek program
	Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi <i>stakeholder</i>
Sedang 3	Mengganggu pencapaian tujuan instansi/kegiatan secara signifikan
	Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan
	Mengganggu administrasi program
	Kerugian keuangan cukup besar
Tinggi 4	Sebagian tujuan instansi / kegiatan gagal dilaksanakan
	Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu
	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi
	Kerugian besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan
Sangat Tinggi 5	Sebagian besar tujuan instansi / kegiatan gagagl dilaksanakan
	Terganggunya pelayananlebih dari 1 minggu
	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholder</i>
	Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun non keuangan

c. Hitung tingkat / level resiko, yaitu perkalian probabilitas dengan dampak. Level resiko ditentukan berdasarkan atas 2 (dua) elemen atau dimensi, yaitu level kemungkinan terjadinya resiko (probabilitas) dan level

dampak (konsekuensi) resiko. Kedua dimensi tersebut harus dikombinasikan dan diperhitungkan secara bersamaan dalam penentuan level resiko. Penentuan level resiko beserta dengan urutan prioritasnya menggunakan matriks analisis resiko sebagai berikut :

Tabel 9.5 Matriks Analisis Resiko

Matriks Analisis Resiko			Dampak				
			1	2	3	4	5
			Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
P R O B A B I L I T A S	5	Hampir pasti terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering terjadi	4	8	12	16	20
	3	Mungkin terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Terjadi	1	2	3	4	5

- d. Buat peringkat resiko untuk menentukan apakah resiko tersebut termasuk resiko sangat rendah, rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi. Berikut merupakan tabel peringkat resiko.

Tabel 9.6 Peringkat Resiko

Warna	Level dimulai dari status resiko	Level	Deskripsi Status Resiko
	>15	5	Sangat tinggi
	10 - 14	4	Tinggi
	5 - 9	3	Sedang
	3 - 4	2	Rendah
	1 - 2	1	Sangat Rendah

- e. Isikan hasil langkah (a) s.d (f) ke dalam formulir analisis resiko

Tabel 9.7 Peringkat Analisis Resiko

No		Tujuan		Pernyataan Risiko	Sebab		Dampak	Pengendalian yang ada					P	D	TR	PR	Pemilik Risiko	
									Desain		Efektifitas							
									A	T	TE	KE						E
1																		
2																		

Keterangan :

No : di isi dengan nomor urut

Kegiatan : di isi dengan nama kegiatan utama

Tujuan Kegiatan : di isi dengan tujuan kegiatan

Kode resiko : di isi dengan kode / nomor resiko

Pernyataan resiko : di isi dengan pernyataan resiko, potensi, yang di Identifikasi

Sebab : berdampak terhadap pencapaian tujuan

UC / C : di isi dengan kategori penyebab, apakah *uncontrollable* (UC) *controllable* (UC)

Dampak : di isi dengan uraian dampak, jika kolom (pernyataan resiko) terjadi

A	: di isi tanda centang (√), jika ada kegiatan pengendalian tersebut dalam kolom (uraian)
T	: di isi tanda centang (√), jika tidak ada kegiatan Pengendalian
TE	: di isi tanda centang (√), jika kegiatan pengendalian yang ada tidak efektif mengurangi resiko
KE	: di isi tanda centang (√), jika kegiatan pengendalian yang ada kurang efektif mengurangi resiko
E	: di isi tanda centang (√), jika kegiatan pengendalian yang ada efektif mengurangi resiko
P	: di isi dengan tingkat probabilitas (P), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya resiko. Tingkat kemungkinan terjadinya resiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
D	: di isi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat dampak resiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD)
TR	: di isi dengan tingkat resiko yaitu perkalian antara probabilitas & dampak
PR	: di isi dengan peringkat resiko, apakah “sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi
Pemilik Resiko	: di isi dengan siapa yang bertanggung jawab atas resiko (pemilik resiko)

- f. Dari resiko-resiko tersebut di atas, selanjutnya dibuat peta resiko (gambaran total resiko dan distribusi posisinya dalam grafik dengan frekuensi pada sumbu horizontal (x) dan konsekuensi pada sumbu vertikal (y))

4. Evaluasi resiko

Evaluasi resiko adalah proses membandingkan antara hasil analisa resiko dengan kriteria resiko untuk menentukan apakah resiko dapat diterima atau ditoleransi. Tujuan evaluasi resiko adalah untuk membantu dalam membuat keputusan, berdasarkan hasil analisis resiko, berkaitan dengan resiko yang memerlukan prioritas penanganannya.

Evaluasi resiko menggunakan perbandingan tingkat resiko yang ditemukan selama prosedur analisis dengan kriteria resiko yang dibuat ketika konteksnya ditetapkan. Evaluasi resiko juga dapat menyebabkan keputusan untuk tidak memperlakukan resiko dengan cara lain selain mempertahankan pengendalian yang ada.

5. Perlakuan resiko (Penanganan Resiko)

Penanganan resiko menggunakan pemilihan salah satu atau lebih untuk memilih memodifikasi resiko dan melaksanakan pilihan tersebut. Penanganan resiko terdiri dari atas :

- a. Menilai penanganan resiko
- b. Memutuskan apakah tingkat resiko residual yang ada
- c. Jika tidak ditoleransi, menghasilkan penanganan resiko yang baru
- d. Menilai efektivitas penanganan itu

6. *Monitoring* dan *review*

Merupakan tahap untuk memastikan bahwa seluruh tahapan proses dan fungsi panajemen resiko berjalan dengan baik. *Monitoring* adalah pemantauan rutin terhadap kinerja actual proses manajemen resiko dibandingkan dengan rencana yang dihasilkan.

Review adalah peninjauan atau pengkajian berkala atas kondisi saat ini dengan fokus tertentu. Pelaksanaan *monitoring* dan *review* secara berkelanjutan bertujuan untuk memberikan jaminan yang terhadap pencapaian sasaran penerapan sistem manajemen resiko secara keseluruhan.

9.4 Pencatatan dan Pelaporan

Pelaksanaan manajemen resiko di RS. Prima Husada dibuat dalam bentuk laporan berupa :

1. profil resiko yang dilaksanakan setiap tahunana pada saat penyusunan rencana kerja.
2. Setiap maisng-masing unit kerja membuat informasi mengenai resiko kunci yang di kelola, rencana mitigasi / pengelolaan, dan realisasi mitigasi / pengelolaan resiko yang dijalankan

BAB X

EVALUASI, TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN

10.1 Evaluasi

Hasil evaluasi dilakukan dan dilaporkan secara :

1. Evaluasi harian, yaitu melalui sensus harian, briefing dan kegiatan morning meeting dilaporkan oleh PJ Mutu Unit
2. Evaluasi bulanan, yaitu melalui laporan bulanan, dan pembahasan dalam rapat, dimana resume rapat selalu ditanda tangani oleh Direktur selaku pimpinan Rapat dan Penanggung Jawab utama Program Mutu Rumah sakit
3. Triwulan, yaitu melalui laporan bulanan, dan pembahasan dalam rapat, dimana resume rapat selalu ditanda tangani oleh Direktur selaku pimpinan Rapat dan Penanggung Jawab utama Program Mutu di RS dan dilaporkan ke Direktur PT Disa Prima Medika ntuk kemudian ditindaklanjuti kembali berdasarkan *feed back* yang didapat dari Direktur PT Disa Prima Medika
4. Evaluasi tahunan, yaitu laporan evaluasi secara global yang dipakai untuk merumuskan strategi apa yang akan ditempuh untuk tahun berikutnya. Dirumuskan secara bersama - sama oleh Direksi RS, Para Manager Bidang/Bagian di RS dalam pembahasan rapat kerja akhir tahun. Kemudian disusun oleh Manager Mutu & Direktur RS menjadi program Mutu RS. Program Mutu yang telah disusun diajukan ke Direktur PT Disa Prima Medika untuk disetujui terlebih dahulu sebelum diberlakukan untuk dijalankan di RS Prima Husada

10.2 Tindak Lanjut

1. Tindaklanjuti dilakukan sesuai dengan rekomendasi tindaklanjuti yang telah disetujui baik oleh Direktur RS Prima Husada dan Direktur PT Disa Prima Medika.
2. Setiap akhir tahun Direktur bersama Wakil Direktur dan Manager Bidang/Bagian di Rumah Sakit mengevaluasi apakah program dimasing- masing Unit masih harus dilakukan pemantauan, peningkatan mutu atau dijadikan kegiatan rutin Bagian/Bidang, sehingga mutu pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada dapat terus berkembang sesuai dengan pengembangan pelayanan di rumah sakit.

10.3 Pelaporan

10.3.1 Pencatatan

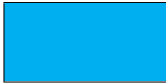
1. Laporan indikator mutu Rumah sakit dan indikator mutu unit
 - a. Pencatatan data indikator mutu dilakukan pada *e-worksheet* menggunakan sistem manajemen data dengan menggunakan *google sheet*. Selain itu Pencatatan data juga dilakukan melalui SIMRS.
 - b. Penginputan data dilakukan secara harian oleh para penanggung jawab mutu unit
2. Laporan kejadian IKP
 - a. Pencatatan kejadian IKP dilakukan melalui *google-form* menggunakan sistem manajemen data. Selain itu juga dilakukan pelaporan menggunakan SIMRS.
 - b. Penginputan data pada *google form* dilakukan sesuai dengan tanggal terjadinya insiden si unit kerja oleh kepala ruangan. Sedangkan untuk berkas pendukung laporan tetap menggunakan formulir IKP internal yang wajib di isi dan dilengkapi oleh unit dimana terjadinya insiden dan unit yang menjadi penyebab terjadi insiden
3. Laporan Pengukuran budaya keselamatan pasien
 - a. Pengisian survei dilakukan menggunakan *google form* dalam bentuk kuesioner

- b. Penginputan data dilakukan dalam Ms. Excel dan ditambahkan dalam bentuk grafik batang
- c. Waktu pengukuran Budaya keselamatan pasien dilakukan 2x dalam setahun pada TW 1 dan TW 3

10.3.2 Pelaporan

1. Laporan bulanan indikator mutu rumah sakit
 - a. Data dari unit dikumpulkan setiap bulan oleh penanggung jawab data unit (PIC) mutu di unit kerja.
 - b. Data diverifikasi oleh kepala ruangan kemudian diberikan kepada sekretaris mutu dalam bentuk excel dan presentasi laporan mutu unit kepada ketua mutu.
 - c. Data yang di presentasikan akan diberikan kepada ketua mutu untuk diverifikasi dan disetujui
 - d. Data yang telah dilakukan verifikasi dan divalidasi disusun dalam bentuk laporan bulanan indikator mutu oleh sekretaris mutu
 - e. Laporan bulanan indikator mutu diberikan kepada direktur rumah sakit untuk disetujui
 - f. Direktur rumah sakit memberikan *feed back* atas laporan tersebut kepada komite mutu untuk kemudian diberikan kepada unit terkait untuk proses tindak lanjut capaian.
2. Laporan triwulan indikator mutu rumah sakit
 - a. Data dari unit akan dikumpulkan setiap triwulan oleh penanggung jawab / PIC Mutu di unit kerja.
 - b. Data diverifikasi oleh kepala unit kemudian dibuat analisa dan rencana tindak lanjut pada indikator yang tidak tercapai
 - c. Data yang dilakukan diverifikasi dan divalidasi disusun dalam bentuk laporan triwulan oleh sekretaris mutu
 - d. Laporan triwulan indikator mutu diberikan kepada ketua mutu untuk dilakukan verifikasi ulang, serta memberikan rekomendasi persetujuan atas analisa yang rencana tindak lanjutnya telah dibuat kemudian diberikan kepada Direktur Rumah sakit
 - e. Direktur Rumah sakit melakukan telaah terhadap rekomendasi tindak lanjut yang diajukan, jika disetujui maka laporan pencapaian indikator mutu Rumah Sakit akan diberikan kepada Direktur PT. Disa Prima Medika
 - f. Direktur PT. Disa Prima Medika akan memberikan *feed back* atas laporan tersebut kepada Direktur Rumah sakit untuk kemudian diberikan kepada unit terkait untuk di tindak lanjuti
3. Laporan IKP (Insiden Keselamatan Pasien)
 - a. Alur pelaporan Insiden ke Tim Keselamatan Pasien di RS (*Internal*) :
 - 1) Apabila terjadi suatu insiden (KNC/ KTD) di rumah sakit, wajib segera ditindaklanjuti (dicegah / ditangani) untuk mengurangi dampak / akibat yang tidak diharapkan.
 - 2) Setelah ditindaklanjuti, segera buat laporan insidennya dengan mengisi Formulir Laporan Insiden pada akhir jam kerja / shift kepada atasan langsung (paling lambat 2 x 24 jam), disertakan formulir kronologis yang telah diisi sebelumnya (1x24 jam) untuk membantu memetakan kejadian.
 - 3) Setelah selesai mengisi laporan, segera serahkan kepada atasa langsung pelapor (atasan langsung sesuai dengan keputusan manajemen : kepala ruang)
 - 4) Atasan langsung akan memeriksa laporan dan melakukan grading risiko terhadap insiden yang dilaporkan.

- 5) Hasil grading akan menentukan bentuk investigasi dan analisa yang akan dilakukan sebagai berikut :

 investigasi sederhana oleh atasan langsung
waktu maksimal 1 minggu

 investigasi sederhana oleh atasan langsung
waktu maksimal 1 minggu

 investigasi komprehensif / RCA oleh Tim KP di
RS, Waktu maksimal 45 hari

 investigasi komprehensif / RCA oleh Tim KP di
RS, Waktu maksimal 45 hari

- 6) Setelah selesai melakukan investigasi sederhana, laporan hasil investigasi dan laporan insiden dilaporkan Tim Keselamatan Pasien di RS (Komite mutu & Keselamatan pasien)
- 7) Tim KPRS akan menganalisa kembali hasil investigasi dan laporan insiden untuk menentukan apakah perlu dilakukan investigasi lanjutan (RCA) dengan melakukan regrading pada grading dengan grade biru/hijau
- 8) Untuk Grade Kuning / Merah, Tim KP di RS akan melakukan analisis akar masalah / Root Cause Analysis (RCA)
- 9) Setelah melakukan RCA, Tim Keselamatan Pasien di RS akan membuat laporan dan rekomendasi untuk perbaikan serta “pembelajaran” berupa : petunjuk /”safety alert” untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali.
- 10) Hasil RCA, rekomendasi dan rencana kerja dilaporkan kepada Direktur RS.
- 11) Rekomendasi untuk “perbaikan dan pembelajaran” diberikan umpan balik kepada unit kerja terkait serta sosialisasi kepada seluruh unit di rumah sakit.
- 12) Unit Kerja membuat analisa dan trend kejadian di satuan kerjanya masing- masing.
- 13) Monitoring dan evaluasi perbaikan oleh Tim KPRS.
- 14) Pelaporan insiden keselamatan pasien dilaporkan kepada representasi pemilik dan pemilik minimal setiap 6 bulan sekali, dan bila ada kejadian sentinel dilaporkan langsung setiap kejadian dan dilaporkan kembali setelah dilakukan RCA maksimal 45 hari dari kejadian.
- b. Alur pelaporan insiden ke KPPRS – Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (*Eksternal*)

Laporan hasil investigasi sederhana / analisis akar masalah / RCA yang terjadi pada pasien dan telah mendapatkan rekomendasi dan solusi oleh Tim Kelamatan Pasien di RS (Internal) / Pimpinan RS dilaporkan dengan cara melakukan entry data (e-reporting) dikirim ke KKPRS melalui website www.buk.depkes.go.id dengan menggunakan user name dan password untuk menjamin kerahasiaan sumber informasi (Depkes, 2015).

4. Laporan Budaya keselamatan pasien

- a. Orang yang telah diinput langsung dan dibuat analisanya oleh masing – masing Tim sesuai jenis pengukuran yang telah ditentukan di atas. Untuk kemudian dibuat rekomendasi tindaklanjutnya oleh komite mutu.

-
- b. Laporan yang sudah disertakan analisa dan rekomendasi tindak lanjut diberikan kepada Direktur untuk disetujui.
 - c. *Feed back* dari Direktur Rumah sakit disosialisasikan kembali oleh manager mutu di forum pertemuan morning meeting, rapat Mutu RS dan Rapat Staf dan Rapat Koordinasi.

BAB XI PENUTUP

Demikianlah pedoman Peningkatan Mutu dan Keelamatan Pasien Rumah Sakit Prima Husada disusun, untuk dapat dipergunakan bagi semua unit kerja dalam memantau pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan dan berkesinambungan guna tercapainya peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Prima Husada Pedoman ini berlaku untuk tiga tahun , jika dipandang perlu dapat dilakukan perbaikan . Hasil analisis dijadikan sebagai bahan untuk pemberian rekomendasi kepada masing-masing bagian /bidang/unit kerja dan seluruh Tim terkait di Rumah Sakit Prima Husada.

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 03 Januari 2026
Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

REFERENSI

- AHRQ. (2019), Survey on Patient Safety Culture Hospital Survey 2.0 : User's Guide.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/sops/surveys/hospital/SOPS-Hospital-Survey-2.0-5-26-2021.pdf. didownload tanggal 01 Januari 2025.
- Acuan Alur Penanganan Klinis (Clinical Pathway) dan Pedoman PPK1- PPK2-PPK3 - Dokter Spesialis Bedah Indonesia; Tahun 2014
- Budiharjo, A. (2008), Pentingnya Safety Culture di Rumah Sakit-Upaya Menimalkan Adverse Events, Jurnal Manajemen Bisnis. Vol.1 no.1 pp 53-70
- Cahyono, J.B. Suharjo B, (2008), Membangun Budaya Keselamatan Pasien Dalam Praktik Kedokteran, Yogyakarta : Kanisius.
- Idris, Haerawati (2017), Dimensi Budaya Keselamatan Pasien, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Vol. 8, no.1.
- IL, Kanan, Rini Anggraeni dan Alimin Maidin (2015), Budaya Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Islam Faisal
- Iskandar H., Halimi Maksum dan Nafisah (2014), Faktor Penyebab Penurunan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Jurnal Kedokteran Brawijaya, Vol. 28, Suplemen no. 1
- Pedoman Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient Safety , Kemenkes RI Edisi 2015 25
- Pedoman Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) (Patient Safety Incident Report), KKPRS 2015
- Pedoman Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit, Depkes, 1994 Petunjuk Pelaksanaan Indikator Mutu Pelayanan Rumah Sakit, WHO.Depkes, 2001 Pedoman MUTU RS. Bunda Palembang. 2018
- Pedoman Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien RSD Mangusada Tahun 2019
- Pedoman Komite Mutu Rumah Sakit Prima Husada Malang Tahun 2022